

SAÚDE MENTAL E QUALIDADE DE VIDA

CFO PM 2024



SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO.....	3
1. INTRODUÇÃO À SAÚDE MENTAL E QUALIDADE DE VIDA	4
2. FATORES QUE IMPACTAM A SAÚDE MENTAL E QUALIDADE DE VIDA	11
3. TRANSTORNOS MENTAIS MAIS COMUNS ENTRE OS PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA.....	16
4. ESTIGMAS E BUSCA DE AJUDA EM SAÚDE MENTAL	35
5. VITIMIZAÇÃO POLICIAL	37
6. RECURSOS DE APOIO À SAÚDE MENTAL NA PMPE.....	40
REFERÊNCIAS	46
ANEXOS.....	47

APRESENTAÇÃO

A relação trabalho versus saúde entre policiais tem sido amplamente discutida, tanto no âmbito das organizações policiais quanto nas universidades brasileiras e nos diversos veículos de divulgação da imprensa e mídias sociais.

Nesse contexto, a saúde mental ganhou destaque e interesse crescente por envolver tanto as peculiaridades da função, a qual possui uma série de características consideradas potencialmente perigosas do ponto de vista da saúde física e psíquica, como também o contexto diário de risco.

Dados da pesquisa nacional “Saúde na Segurança Pública: indicadores e diretrizes para intervenções no âmbito do Programa Nacional de Qualidade de Vida para Profissionais de Segurança Pública – Pró-Vida”, do Ministério da Justiça e Segurança Pública – SENASP, sugerem que o déficit de efetivo nas corporações constitui uma variável importante para a sobrecarga de trabalho como um fator de risco ao adoecimento físico e psíquico do profissional da segurança pública, contribuindo para o aumento dos índices de absenteísmo e afastamentos de serviço em geral.

Episódios de suicídios e homicídios seguidos de suicídio (H/S), assim como os números de afastamentos de serviço relacionados aos transtornos mentais envolvendo policiais apontam para a relevância da temática não só para policiais, mas também para a população a quem se destinam os serviços de segurança pública e defesa social.

A Organização Mundial da Saúde define saúde mental como um estado de bem-estar no qual uma pessoa é capaz de lidar com os estresses normais da vida, ser produtiva no trabalho e contribuir para a sua comunidade (OMS, 2001). Além disso, a OMS enfatiza que a saúde mental não se resume à ausência de transtornos mentais, mas envolve também aspectos como a capacidade de estabelecer e manter relacionamentos saudáveis, ter equilíbrio emocional e lidar com desafios e adversidades de forma eficaz.

Nesta disciplina, empreenderemos uma jornada de conhecimentos com o objetivo de capacitar o futuro Oficial da PMPE a reconhecer fatores que impactam a saúde mental e a qualidade de vida do profissional de segurança pública, tornando-o capaz de promover estratégias de autocuidado, enfrentamento e manejo do estresse ocupacional e do adoecimento no trabalho, assim como adotar ações necessárias à busca de ajuda e/ou encaminhamento de outros policiais aos serviços de apoio profissional no âmbito da Corporação. Bons estudos!

(Trecho extraído e adaptado do artigo Ações Institucionais de Saúde Mental na Polícia Militar de Pernambuco: uma estratégia de Segurança Pública de SANTOS, 2023)



1. INTRODUÇÃO À SAÚDE MENTAL E QUALIDADE DE VIDA

1.1 Conceito de Saúde Mental

A saúde mental é definida pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como um estado de bem-estar em que o indivíduo é consciente de suas próprias habilidades, pode lidar com o estresse normal da vida, pode trabalhar de forma produtiva e contribuir para a sua comunidade. A saúde mental não é apenas a ausência de doenças mentais, mas envolve um equilíbrio emocional, psicológico e social que afeta a forma como pensamos, sentimos e agimos. Ela também influencia como enfrentamos o estresse, nos relacionamos com os outros e tomamos decisões.

1.2 Qualidade de Vida

A qualidade de vida, por sua vez, é um conceito amplo que abrange diferentes dimensões da vida, incluindo saúde física, bem-estar psicológico, relações sociais e fatores ambientais. De acordo com a OMS, a qualidade de vida é "a percepção do indivíduo sobre sua posição na vida, no contexto da cultura e do sistema de valores em que vive, em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações".

Definir qualidade de vida não é simples, pois se trata de um conceito que, por vezes, pode se apresentar como sinônimo ou complementar a outras concepções como saúde, bem-estar ou satisfação com a vida.

A variabilidade inerente à avaliação da qualidade de vida leva à discussão de determinados aspectos inerentes a esse conceito, que devem ser considerados no seu processo de definição. Trata-se de um conceito dinâmico, pois depende das motivações, necessidades e expectativas de cada indivíduo, situações que estão em constante transformação. Com base nessa definição contextualizada, é possível afirmar que qualidade de vida é, portanto, algo contingencial, pois se modifica conforme as circunstâncias externas vivenciadas pela pessoa e pela sociedade, sofrendo, assim, influências individuais e coletivas. Por conseguinte, isto implica afirmar que se trata de um conceito abrangente e multidisciplinar uma vez que engloba todas as esferas da vida

humana, sendo alvo de interesse de várias ciências, como saúde, psicologia, sociologia, ergonomia, economia, administração, entre outras. (CAÑETE, 2004)



Conceito

DISTINGUINDO OS CONCEITOS DE SAÚDE, QUALIDADE DE VIDA E BEM-ESTAR

Será que é possível distinguir os conceitos de bem-estar, saúde e qualidade de vida? Embora sejam conceitos bastante próximos, é possível avaliá-los de forma comparativa e identificar que, em linhas gerais, a definição de qualidade de vida engloba a concepção de saúde, que, por sua vez, possui o bem-estar como aspecto central. Em termos práticos, vale também frisar que a satisfação com a vida costuma ser um indicador de avaliação desses três conceitos.

SAÚDE

Em 1948, a Organização Mundial de Saúde (OMS) redefiniu a concepção de saúde, conceituando-a como um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não somente como ausência de enfermidades. Tal definição abriu campo para que a saúde fosse percebida de forma menos reducionista, elucidando seus aspectos positivos.

QUALIDADE DE VIDA

Qualidade de vida é a “percepção do indivíduo sobre a sua posição na vida, dentro do contexto dos sistemas de cultura e valores nos quais está inserido e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações” (WHOQOL GROUP 1994, p. 28), sendo essa percepção influenciada por sua saúde física e psicológica, por seu nível de independência, pelas relações sociais estabelecidas, pelas crenças pessoais e, ainda, pelas características salientes do respectivo meio (cultural, social) em que a avaliação subjetiva da qualidade de vida se dá.

BEM-ESTAR

Inicialmente, o termo bem-estar foi cunhado pela economia e seu significado remetia a questões materiais, sendo avaliado a partir do rendimento que o indivíduo tinha e que lhe permitia adquirir bens e serviços para o seu bem-estar. Entretanto, as transformações sócio-históricas, especialmente marcadas pela denominada “Segunda Revolução da Saúde” na década de 70, despertaram a atenção para aspectos que influenciam o bem-estar do indivíduo, mas que estão para além dos recursos materiais. Assim, o bem-estar é entendido hoje a partir de uma perspectiva subjetiva, que considera a prevalência de estados afetivos positivos sobre os negativos, e também a partir de uma perspectiva psicológica, que compreende o bem-estar como resultante de experiências de realização pessoal e de possibilidade de desenvolvimento/expressão dos potenciais individuais. (CARNEIRO; FERNANDES, 2015)

Figura 1 Conceitos (Laila Leite Carneiro, 2018)

1.3 Inter-relação entre Saúde Mental e Qualidade de Vida

Estudos evidenciam que a saúde mental e a qualidade de vida estão intrinsecamente ligadas. Indivíduos com boa saúde mental tendem a ter uma percepção mais positiva da sua qualidade de vida. Por outro lado, problemas de saúde mental podem resultar em uma diminuição na qualidade de vida, afetando o desempenho no trabalho, as relações interpessoais e a satisfação geral.

1.4 Impacto da Saúde Mental no Ambiente de Trabalho

O ambiente de trabalho tem um impacto significativo na saúde mental da força de trabalho. Fatores como estresse, pressão por resultados, falta de apoio social e condições físicas do trabalho podem afetar a saúde mental dos colaboradores. A saúde mental no ambiente de trabalho não só influencia a qualidade de vida do colaborador, mas também tem implicações diretas para a produtividade da organização.

1.5 Aplicações Práticas no Ambiente de Trabalho

1.5.1 Promoção de Programas de Saúde Mental

Organizações devem investir na promoção de programas de saúde mental que incluam a conscientização sobre a importância da saúde mental, bem como a oferta de suporte psicológico. Esses programas podem incluir:

- Workshops e treinamentos: Para capacitar líderes e colaboradores sobre a gestão do estresse e a promoção do bem-estar emocional.
- Políticas de apoio psicológico: Disponibilização de serviços de psicologia e psiquiatria.

1.5.2 Estabelecimento de um Ambiente de Trabalho Positivo

Criar um ambiente de trabalho que promova a qualidade de vida pode envolver:



- Flexibilidade: Adoção de horários flexíveis e modelos de trabalho híbrido que permitem um melhor equilíbrio entre vida pessoal e profissional.

- Apoio social: Fomentar relações de apoio entre colegas de trabalho, promovendo um senso de equipe e colaboração.

1.6 Qualidade de Vida no Trabalho

(trecho extraído de Gestão de pessoas: o novo papel dos recursos humanos nas organizações / Chiavenato, 2014)

Ao lado da higiene e da segurança do ponto de vista físico e ambiental, existe o bem-estar psicológico e social. A expressão “qualidade de vida no trabalho (QVT)” foi cunhada por Louis Davis na década de 1970 quando desenvolvia um projeto sobre desenho de cargos. Para ele, o conceito de QVT refere-se à preocupação com o bem-estar geral e a saúde dos colaboradores no desempenho de suas atividades.

Alguns autores europeus desenvolveram outras conceituações na abordagem sociotécnica e da democracia industrial. Atualmente, o conceito de QVT envolve tanto os aspectos físicos e ambientais quanto os aspectos psicológicos do local de trabalho. A QVT assimila duas posições antagônicas: de um lado, a reivindicação dos colaboradores quanto ao bem-estar e à satisfação no trabalho; de outro, o interesse das organizações quanto aos seus efeitos positivos e potenciadores sobre a produtividade e a qualidade no trabalho. Mais do que tudo, a QVT representa um intenso movimento em direção ao profundo respeito pelo bem-estar das pessoas do ponto de vista biológico, psicológico e social. E é isso o que vale.

QVT é um conjunto de ações de uma empresa envolvendo diagnóstico e implantação de melhorias e inovações gerenciais, tecnológicas e estruturais dentro e fora do ambiente de trabalho, visando a propiciar condições plenas de desenvolvimento humano para e durante a realização do trabalho.

- QVT representa a percepção do indivíduo sobre sua posição na vida, no contexto cultural, sistema de valores em que vive e em relação com objetivos, expectativas, padrões e conceitos. Trata-se de um conceito amplo, que inclui saúde física, estado psicológico, crenças pessoais, relações sociais e suas relações com o ambiente.
- QVT é resultante direta da combinação de diversas dimensões básicas do desempenho das atividades e de outras dimensões não dependentes diretamente das tarefas, capazes de produzir motivação e satisfação em diferentes níveis, além de resultar em diversos tipos de atividades e condutas dos indivíduos pertencentes a uma organização.
- Independentemente das percepções que os funcionários possam ter a respeito do que é QVT, esta deve envolver:
 - Trabalho que valha a pena ser feito.
 - Condições de trabalho seguras.
 - Remuneração justa e adequada.
 - Segurança no emprego.
 - Supervisão competente.
 - Retroação quanto ao desempenho no trabalho.
 - Oportunidades de crescimento intelectual e profissional.
 - Possibilidades de promoção e avanço na carreira.
 - Excelente clima social e justiça.

No fundo, a QVT busca uma visão integral e ética do ser humano em seu relacionamento com as organizações. Tem sido utilizada como indicadora das experiências humanas no local de trabalho e o grau de satisfação das pessoas que desempenham o trabalho. O conceito de QVT implica profundo respeito pelas pessoas. Para alcançar níveis elevados de qualidade e produtividade, as organizações precisam de pessoas motivadas que participem ativamente nos trabalhos que executam e que sejam adequadamente recompensadas pelas suas contribuições.

A competitividade organizacional – e, obviamente, a qualidade e a produtividade – passam obrigatoriamente pela QVT. Para bem atender ao cliente externo, a organização não deve esquecer o cliente interno. Isso significa que, para satisfazer o cliente externo, as organizações precisam antes satisfazer os

seus colaboradores responsáveis pelo produto ou serviço oferecido. Como diz o consultor dinamarquês Claus Möller: “coloque os empregados em primeiro lugar e eles colocarão os consumidores em primeiro lugar”. A organização que investe diretamente no colaborador está, na realidade, investindo indiretamente no cliente.

A gestão da qualidade total nas organizações depende principalmente da otimização do potencial humano. E isso depende de quão bem as pessoas se sentem trabalhando na organização. A QVT representa o grau em que os membros da organização são capazes de satisfazer suas necessidades pessoais pelo trabalho na organização e se sentirem satisfeitos e felizes.



COMPONENTES DA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO

A QVT É UM CONSTRUTO COMPLEXO E MULTIDISCIPLINAR QUE ENVOLVE UMA CONSTELAÇÃO DE FATORES, COMO:

- SATISFAÇÃO COM O TRABALHO EXECUTADO.
- POSSIBILIDADES DE FUTURO NA ORGANIZAÇÃO.
- RECONHECIMENTO PELOS RESULTADOS ALCANÇADOS.
- SALÁRIO PERCEBIDO.
- BENEFÍCIOS AUFERIDOS.
- RELACIONAMENTO HUMANO NA EQUIPE E NA ORGANIZAÇÃO.
- AMBIENTE PSICOLÓGICO E FÍSICO DE TRABALHO.
- LIBERDADE DE ATUAR E A RESPONSABILIDADE DE TOMAR DECISÕES.
- POSSIBILIDADES DE ESTAR ENGAJADO E DE PARTICIPAR ATIVAMENTE.

Chiavenato, 2014, p. 420

1.7 Estratégias para Melhorar a Qualidade de Vida e Saúde Mental

1.7.1 Comunicação Clara e Abertura

Uma comunicação eficaz é vital. A organização deve cultivar um ambiente onde os colaboradores se sintam à vontade para expressar suas preocupações, buscando ajuda quando necessário.

1.7.2 Reconhecimento e Valorização dos Colaboradores

O reconhecimento do trabalho realizado e a valorização dos colaboradores são fundamentais para aumentar a motivação e a satisfação no emprego, contribuindo positivamente para a saúde mental.

A promoção da saúde mental e da qualidade de vida deve ser uma prioridade nas organizações contemporâneas. Ao investir no bem-estar de seus colaboradores, essas organizações não apenas contribuem para a saúde individual, mas também para a produtividade e a eficiência do ambiente de trabalho. A implementação de políticas e práticas efetivas pode resultar em um ciclo positivo, onde colaboradores saudáveis e satisfeitos levam a um ambiente de trabalho mais produtivo e harmonioso.

2. FATORES QUE IMPACTAM A SAÚDE MENTAL E QUALIDADE DE VIDA

(trecho extraído do Artigo da Revista Doutrinal “Ações Institucionais de Saúde Mental na Polícia Militar de Pernambuco: uma estratégia de segurança pública”, SANTOS, 2023)

O exercício da atividade policial militar, por suas características e peculiaridades, expõe o policial militar a situações de elevado risco e estresse físico e emocional. Diversos estudos correlacionam a vivência de situações de risco experienciadas pelos policiais militares ao adoecimento psíquico.

As circunstâncias que envolvem a atuação policial, tais como risco de morte, contato regular e constante com a violência e a criminalidade, situações em que colegas são alvejados ou morrem em serviço, as cobranças por desempenho livre de erros e a falta de reconhecimento social da profissão potencializam o risco do adoecimento mental entre policiais militares de todos os postos e graduações.

Amador (1999) analisou a relação entre trabalho e saúde mental entre policiais militares de Porto Alegre-RS, a fim de entender como estes vivenciavam o impacto do trabalho sobre a sua subjetividade e saúde. A mesma pesquisadora afirma que a questão da segurança pública consiste também em uma importante questão de saúde pública, na medida em que o labor policial não consiste apenas em um conhecimento ou desconhecimento técnico, mas também na vivência de um sofrimento, cujas repercussões atingem um expressivo número de pessoas, quer sejam policiais, quer sejam cidadãos da população em geral.

Para Nogueira & Moreira (1999), a formação do policial militar é perpassada por um ideal de homem que se estrutura em princípios rígidos. Além dos ideais difundidos, a padronização das condutas, comportamentos, atos e fardamentos tende a dificultar a expressão do que é subjetivo, individual e singular. Os autores referem ainda que no caso dos policiais militares existe uma pressão uma cobrança sobre o indivíduo visando à coesão e padronização de condutas do grupo, através de códigos e legislações rígidos.

Ao abordar contexto do trabalho policial militar e as suas relações com a saúde mental desses profissionais, não podemos deixar de contemplar a Teoria Psicodinâmica do Trabalho, onde Dejours (1998) aponta que o trabalho, quer seja uma atividade assalariada ou beneficente, doméstica ou profissional, de mão de obra ou empresarial, pública ou privada, industrial ou de serviço de



agricultura ou de comércio, mobiliza o corpo, a inteligência, a própria pessoa, para uma produção de valor (Gonçalves, 2014, p. 18).

Esta definição de trabalho com o foco no indivíduo possibilita o entendimento da atividade policial militar como um trabalho e do indivíduo policial militar como um trabalhador, um sujeito que sente, se afeta e é afetado. Isso propicia uma melhor compreensão do trabalho policial militar e do trabalhador policial militar, uma vez que estes sujeitos geralmente são vistos pela sociedade como “braços armados do estado”, repressores, violentos e não como seres humanos (Gonçalves, 2014, p. 18).

Entendemos que a temática da saúde mental dos policiais militares está intimamente ligada à temática da vitimização policial, pois compartilham características que remetem aos riscos da profissão e às vulnerabilidades físicas e psíquicas desses profissionais.

O Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2023 aponta que no ano de 2022, no caso de policiais militares, foram 18 mortos em confronto em serviço no ano de 2022: 01 na Bahia, 02 no Espírito Santo, 01 no Pará, 01 no Paraná, **02 em Pernambuco**, 01 no Piauí, 01 em Roraima, 1 em Minas Gerais, 02 em Santa Catarina e 06 em São Paulo (Fórum Nacional de Segurança Pública – FNSP, 2023, p. 51).

Acerca das circunstâncias dessas mortes em serviço, o mesmo anuário aponta dentre outros aspectos, os relacionados ao nível de força utilizado, à compatibilidade de armamento diante do sinistro, à experiência profissional, ao treinamento tático e às condições psicológicas do policial.

Ao tratar dos suicídios de policiais militares da ativa, o Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2023 refere que o tema é sempre permeado por incertezas, trazendo à tona pontos cruciais para o desenvolvimento do trabalho policial relacionados diretamente com a qualidade de vida dentro e fora das polícias (p. 53). Também faz referência aos tabus relacionados ao tema “Na sociedade em geral, falar sobre suicídio e saúde mental é tarefa já bem difícil, dentro das corporações é ainda mais” (Fórum Nacional de Segurança Pública – FNSP, 2023, p. 54).

A existência de estigmas em torno da saúde mental e da busca de ajuda é uma característica que a Polícia Militar de Pernambuco compartilha com outras forças de segurança pública no Brasil e no mundo.



2.1 Compreendendo os impactos à saúde mental e qualidade de vida do policial militar: a Árvore do Problema

A Árvore do Problema é uma ferramenta essencial para identificar e compreender as causas fundamentais de um problema complexo. Através desta abordagem visual e estruturada, é possível mapear as relações entre os diferentes fatores que contribuem para um desafio, permitindo assim o desenvolvimento de soluções eficazes e sustentáveis.

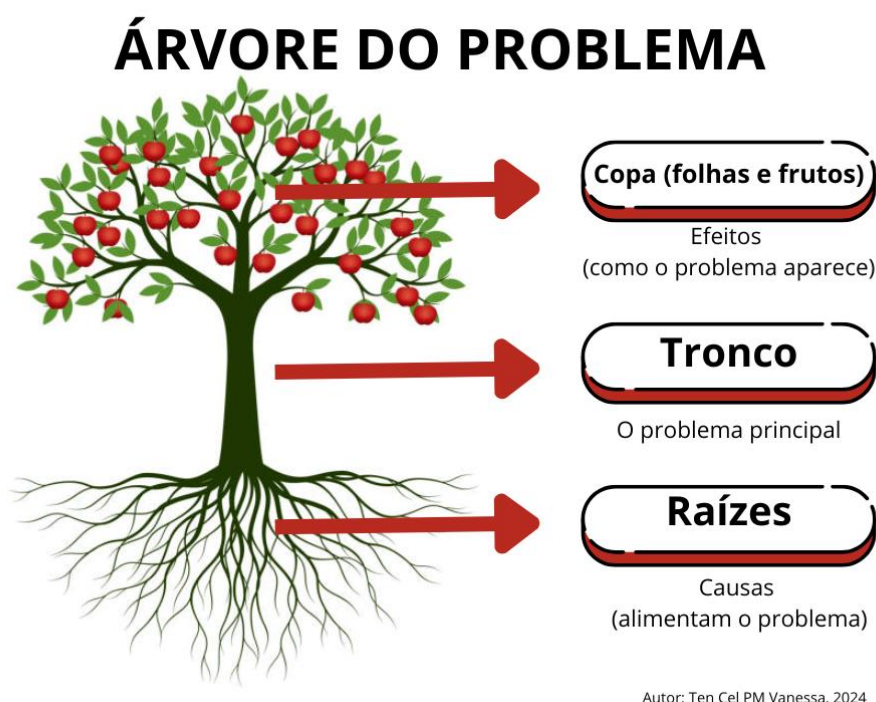
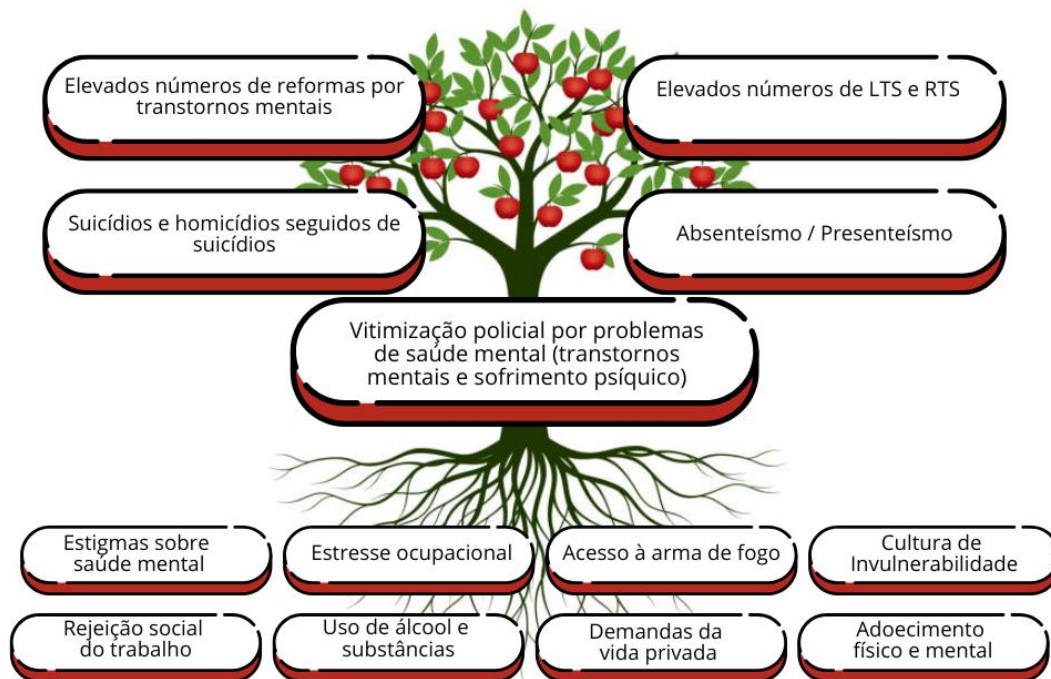


Figura 2 Diagrama da Árvore do Problema (SANTOS, 2024)

No diagrama da Árvore do Problema, a copa (folhas e frutos) representam a forma como o problema se apresenta, como é visto, como é percebido. O tronco representa a descrição do problema em si, e as raízes representam as causas que alimentam o problema em questão. Podemos observar essas representações na figura 2.

SAÚDE MENTAL - PMPE



Autor: Ten Cel PM Vanessa, 2024

Figura 3 Saúde Mental PMPE (SANTOS, 2024)

A figura 3 apresenta um exemplo de mapeamento do problema central “Vitimização policial por problemas de saúde mental – transtornos mentais e sofrimento psíquico (tronco). O problema central se mostra na copa da árvore com os elevados números de reformas por transtornos mentais, suicídios e homicídios seguidos de suicídio, elevados números de afastamentos médicos, absenteísmo e presenteísmo.

As possíveis causas do problema (raízes) são: estigmas de saúde mental, estresse ocupacional, acesso à arma de fogo, cultura de invulnerabilidade, rejeição social do trabalho, uso de álcool e substâncias, demandas da vida privada e adoecimento.

Nesta seção, vimos que a atividade do profissional da segurança pública carrega consigo uma série de complexidades e especificidades que demandam reflexões por parte desses profissionais sobre as experiências diante na natureza específica e das exigências do trabalho.

Assim, para aprofundamento da compreensão da temática, sugerimos a leitura do texto “A profissão do policial militar: vivências de prazer e sofrimento no trabalho”, abaixo referenciado. Boa leitura!

WINTER, Lilian Ester; ALF, Alexandra Machado. A profissão do policial militar: vivências de prazer e sofrimento no trabalho. Rev. Psicol., Organ. Trab., Brasília , v. 19, n. 3, p. 671-678, set. 2019 .

Disponível em http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1984-66572019000300005&lng=pt&nrm=iso. <https://doi.org/10.17652/rpot/2019.3.13214>

3. TRANSTORNOS MENTAIS MAIS COMUNS ENTRE OS PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA

Como já estudamos no capítulo 1, saúde mental não se limita à ausência de doença, mas se constitui em um estado de bem-estar biopsicossocial onde o indivíduo é consciente de suas próprias habilidades, pode lidar com o estresse normal da vida, pode trabalhar de forma produtiva e contribuir para a sua comunidade.

A necessidade de manter um estado de alerta constante, a demanda por um estado de prontidão em qualquer situação, muitas vezes incluindo os horários de folga, além de um regime disciplinar rígido e outras especificidades da atividade de segurança pública, tais como privação de sono, trabalhos por turnos, o risco de morte, contato direto e constante com a violência, torna os profissionais da segurança pública vulneráveis aos transtornos mentais.



Figura 4 Policiamento ostensivo (domínio público)

Os diversos estudos sobre a temática da saúde mental dos profissionais da segurança pública dão conta de que precisamos validar as emoções humanas entre esses profissionais. Ansiedade, medo, tristeza e estresse são emoções componentes do complexo território emocional humano e não devem ser desconsideradas, sob o risco de se tornarem doenças graves.

Não podemos negligenciar o ser humano que enverga a farda, que traz consigo uma história de vida e toda uma carga de emoções e vivências pessoais, problemas cotidianos e familiares, financeiros e outros. Ocorre que deste profissional, diante de eventos de perigo extremo e risco de morte com tempo resposta comprimido, muitas vezes é exigida uma atuação com características

contrastam com a condição humana, ou seja, sem a possibilidade de erros e sem emoções.

O trabalho na área de segurança pública é, portanto, um dos mais arriscados no que tange aos riscos à saúde ocupacional, sendo esses profissionais expostos a condições que os colocam frente a riscos diários, numa condição limítrofe para o desenvolvimento de transtornos mentais.

Dados do Escuta Susp, programa de assistência psicológica gratuita e on-line para profissionais da segurança pública, executado pela Secretaria Nacional de Segurança Pública – SENASP do Ministério de Justiça e Segurança Pública – MJSP, dão conta de que os principais transtornos entre esses profissionais são ansiedade, depressão e estresse, tanto o estresse agudo quanto o pós-traumático (SENASP/MJSP, 2024).

Subordinado à Diretoria de Assistência Social da PMPE – DAS, o Núcleo de Saúde Mental Ten Cel PM Aline Maria Lopes dos Prazeres de Luna – NSMP PMP, que presta atendimento psicológico presencial e on-line aos policiais militares pernambucanos (SUNOR 017/2023 PMPE), aponta que os principais transtornos mentais entre policiais militares pernambucanos são ansiedade, depressão e transtorno bipolar.

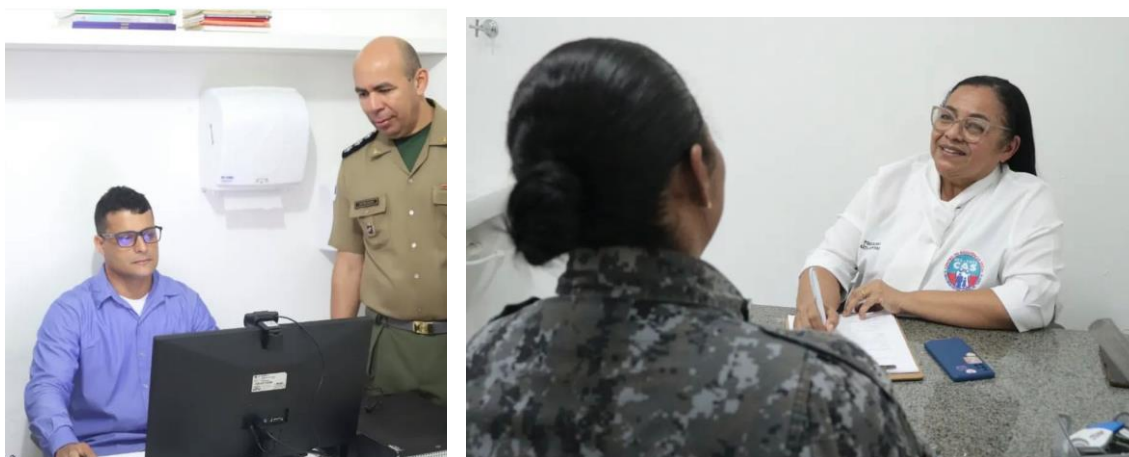


Figura 5 atendimentos on-line e presencial NSM-PMPE

Verifica-se que o adoecimento mental do profissional da segurança pública está intimamente ligado ao estresse disfuncional. Mas, o que é estresse?

3.1 Estresse

O estresse é um processo pelo qual alguém percebe e responde a eventos que são julgados como desafiadores ou ameaçadores. Marilda Lipp define estresse como uma reação psicofisiológica muito complexa que tem em sua gênese a necessidade de o organismo fazer face a algo que ameace a sua homeostase (equilíbrio) interna (2003, p. 18).

O estresse está em nosso cotidiano, podendo vir de várias direções, incluindo da família, vizinhos, trabalho, um ambiente estressante, entre outros. As fontes de estresse são diversas: eventos importantes da vida, problemas cotidianos, estresse ambiental (como ruído, lotação, desastres naturais), estresse relacionado ao trabalho (sobrecarga de trabalho e de papéis, esgotamento, falta de controle sobre o trabalho) e fatores socioculturais (pobreza, imigrantes).

Na maioria dos casos, o estresse é uma experiência rápida, porém pode persistir por um longo tempo. O estresse persistente ou crônico pode influenciar na vulnerabilidade da pessoa a doenças. Isso ocorre quando sobrecarrega os recursos de enfrentamento, prejudicando a saúde física. Algumas das doenças que podem ser relacionadas ao estresse são: doenças cardíacas e hipertensão.

O estresse ocorre em 4 fases e cada fase envolve alterações específicas no organismo que explicam como os sintomas se desenvolvem (Figura 5).

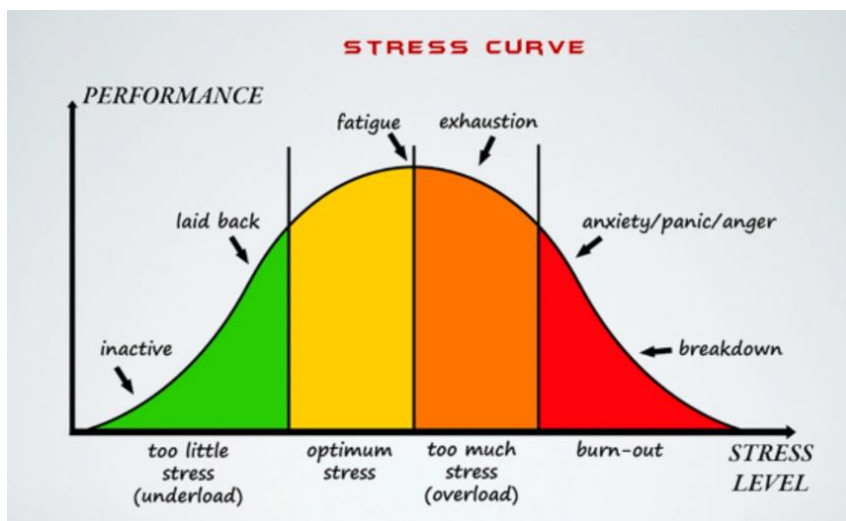


Figura 6 Fases do estresse

Na primeira fase, a do **Alerta**, diante de um desafio ou ameaça percebida, a pessoa necessita produzir mais força e energia a fim de enfrentar a situação desafiadora, havendo uma mobilização de recursos de enfrentamento. As mudanças fisiológicas no organismo neste momento contribuem para que haja aumento da motivação, entusiasmo e energia, o que pode, desde que não excessivo, gerar maior produtividade no ser humano.

Na segunda fase, da **Resistência**, a situação estressante persiste, havendo uma grande utilização de energia na busca pelo reequilíbrio do organismo, causando a sensação de desgaste generalizado sem causa aparente e dificuldades de memória, dentre outras consequências. O desgaste e a falta de memória são sinais de que a demanda ultrapassou a capacidade da pessoa lidar com a situação presente.

Na terceira fase, de **Quase Exaustão**, as defesas do organismo começam a ceder e ele já não consegue resistir às tensões e restabelecer o equilíbrio interior. É comum nesta fase a pessoa sentir que oscila entre momentos de bem-estar e tranquilidade e momentos de desconforto, cansaço e ansiedade. Algumas doenças começam a aparecer.

Na quarta e última fase, de **Exaustão**, com os recursos esgotados, há uma quebra total da resistência e alguns sintomas que aparecem são semelhantes aos da fase de alarme, embora em maior magnitude. Podem ocorrer exaustão psicológica em forma de depressão e exaustão física na forma de doenças que começam a aparecer. Embora seja uma fase grave, não é irreversível.

Quando o estresse é prolongado, ele afeta diretamente o sistema imunológico reduzindo a resistência da pessoa e tornando-a vulnerável ao aparecimento de infecções e doenças contagiosas. Em consequência da queda do sistema imunológico, doenças que permaneciam latentes podem ser desencadeadas, como úlceras, hipertensão arterial, diabetes, problemas dermatológicos, alergias, impotência sexual e obesidade.

3.2 Síndrome de Burnout



Figura 7 Síndrome de Burnout

Síndrome de Burnout ou Síndrome do Esgotamento Profissional é um distúrbio emocional com sintomas de exaustão extrema, estresse e esgotamento físico resultante de situações de trabalho desgastante, que demandam muita competitividade ou responsabilidade. A principal causa da doença é justamente o excesso de trabalho. Esta síndrome é comum em profissionais que atuam diariamente sob pressão e com responsabilidades constantes, como médicos, enfermeiros, professores, policiais, jornalistas, dentre outros.

A Síndrome de Burnout também pode acontecer quando o profissional planeja ou é pautado para objetivos de trabalho muito difíceis, situações em que a pessoa possa achar, por algum motivo, não ter capacidades suficientes para os cumprir. Essa síndrome pode resultar em estado de depressão profunda e por isso é essencial procurar apoio profissional no surgimento dos primeiros sintomas.

A Síndrome de Burnout envolve nervosismo, sofrimentos psicológicos e problemas físicos, como dor de barriga, cansaço excessivo e tonturas. O estresse e a falta de vontade de sair da cama ou de casa, quando constantes, podem indicar o início da doença.

Os principais sinais e sintomas que podem indicar a Síndrome de Burnout são:

- Cansaço excessivo, físico e mental;
- Dor de cabeça frequente;
- Alterações no apetite;
- Insônia;
- Dificuldades de concentração;
- Sentimentos de fracasso e insegurança;
- Negatividade constante;
- Sentimentos de derrota e desesperança;
- Sentimentos de incompetência;
- Alterações repentinas de humor;
- Isolamento;
- Fadiga.
- Pressão alta.
- Dores musculares.
- Problemas gastrointestinais.
- Alteração nos batimentos cardíacos.

Normalmente esses sintomas surgem de forma leve, mas tendem a piorar com o passar dos dias. Por essa razão, muitas pessoas acham que pode ser algo passageiro. Para evitar problemas mais sérios e complicações da doença, é fundamental buscar apoio profissional assim que notar qualquer sinal. Pode ser algo passageiro, como pode ser o início da Síndrome de Burnout.

3.3 Depressão

Caracterizada por uma tristeza constante e prolongada, a depressão envolve uma ampla família de doenças. A síndrome é classificada como doença psiquiátrica crônica e pode ser recorrente, atingindo adultos, adolescentes e crianças.

É um problema médico grave e altamente prevalente na população em geral. De acordo com estudo epidemiológico a prevalência de depressão ao longo da vida no Brasil está em torno de 15,5%. Segundo a OMS, a prevalência de depressão na rede de atenção primária de saúde é 10,4%, isoladamente ou

associada a um transtorno físico. Esses números se apresentam aumentados entre os profissionais da segurança pública.



Figura 8 Depressão (domínio público)

De acordo com a OMS, a depressão situa-se em 4º lugar entre as principais causas de ônus, respondendo por 4,4% dos ônus acarretados por todas as doenças durante a vida. Ocupa 1º lugar quando considerado o tempo vivido com incapacitação ao longo da vida (11,9%). A época comum do aparecimento é o final da 3ª década da vida, mas pode começar em qualquer idade.

Além do sintoma clássico da tristeza profunda (que se manifesta quase diariamente, na maior parte do dia, por um período mínimo de duas semanas), sentimentos de dor, culpa, amargura, perda de interesse, ausência de ânimo, desesperança, baixa autoestima e oscilações de humor são outras características do transtorno. Como ela pode gerar paralisação, incapacidade e levar a pensamentos suicidas, pois a vida pode parecer não ter mais sentido, é importante identificar os sintomas e diagnosticar a doença logo, para iniciar o tratamento.

Quanto às causas da depressão podemos apontar:

- **Genética:** estudos com famílias, gêmeos e adotados indicam a existência de um componente genético. Estima-se que esse componente represente 40% da suscetibilidade para desenvolver depressão;
- **Bioquímica cerebral:** há evidências de deficiência de substâncias cerebrais, chamadas neurotransmissores. São eles Noradrenalina,

Serotonina e Dopamina que estão envolvidos na regulação da atividade motora, do apetite, do sono e do humor;

- **Eventos vitais:** eventos estressantes, traumas e perdas podem desencadear episódios depressivos, especialmente quando combinados com o componente genético.

Observemos abaixo o quadro de sintomas da depressão:

- **Humor depressivo:** sensação de tristeza, autodesvalorização e sentimento de culpa. Acreditam que perderam, de forma irreversível, a capacidade de sentir prazer ou alegria. Tudo parece vazio, o mundo é visto sem cores, sem matizes de alegria. Muitos se mostram mais apáticos do que tristes, referindo “sentimento de falta de sentimento”. Julgam-se um peso para os familiares e amigos, invocam a morte como forma de alívio para si e familiares. Fazem avaliação negativa acerca de si mesmo, do mundo e do futuro. Percebem as dificuldades como intransponíveis, tendo o desejo de pôr fim a um estado penoso. Os pensamentos suicidas variam desde o desejo de estar morto até planos detalhados de se matar. Esses pensamentos devem ser sistematicamente investigados;
- **Retardo motor,** falta de energia, preguiça ou cansaço excessivo, lentificação do pensamento, falta de concentração, queixas de falta de memória, de vontade e de iniciativa;
- **Insônia ou sonolência:** A insônia geralmente é intermediária ou terminal. A sonolência está mais associada à depressão chamada Atípica;
- **Apetite:** geralmente diminuído, podendo ocorrer em algumas formas de depressão aumento do apetite, com maior interesse por carboidratos e doces;
- **Redução do interesse sexual;**
- **Dores e sintomas físicos difusos** como mal-estar, cansaço, queixas digestivas, dor no peito, taquicardia, sudorese.

BRASIL, Ministério da Saúde, 2024.

Dentre os fatores de risco, podemos elencar:

- Histórico familiar;
- Transtornos psiquiátricos correlatos;
- Estresse crônico;
- Ansiedade crônica;
- Disfunções hormonais;

- Dependência de álcool e drogas ilícitas;
- Traumas psicológicos;
- Doenças cardiovasculares, endocrinológicas, neurológicas, neoplasias entre outras;
- Conflitos conjugais;
- Mudança brusca de condições financeiras e desemprego.

O diagnóstico da depressão é clínico, feito pelo médico após coleta completa da história do paciente e realização de um exame do estado mental. Existem inventários e escalas psicológicas para avaliar sintomas de depressão. Não existem exames laboratoriais específicos para diagnosticar depressão. A depressão ou transtorno depressivo maior pode se apresentar de formas específicas, conforme os subtipos abaixo listados.

- **Distímia:** É um quadro mais leve e crônico. As alterações estão presentes na maior parte do dia, todos os dias, por, no mínimo, dois anos. Podem ocorrer oscilações, mas prevalecem às queixas de cansaço e desânimo durante a maior parte do tempo. Geralmente, se mostram como pessoas excessivamente preocupadas, que apresentam um sentimento persistente de preocupação. As alterações de apetite, libido e psicomotoras não são frequentes, é mais comum sintomas como letargia e falta de prazer pelas coisas que antes eram prazerosas. Na maioria dos casos, se inicia na adolescência ou no princípio da idade adulta;

- **Depressão endógena:** Caracteriza-se pela predominância de sintomas como perda de interesse ou prazer em atividades normalmente agradáveis, piora pela manhã, falta de reatividade do humor, lentidão psicomotora, queixas de esquecimento, perda de apetite importante e perda de peso, muita desânimo e tristeza;

- **Depressão Atípica:** Apresenta uma inversão dos sintomas: aumento de apetite e/ou ganho de peso, dificuldade para conciliar o sono ou sonolência, sensação de corpo pesado, sensibilidade exagerada à rejeição, responde de forma negativa aos estímulos ambientais;

- **Depressão sazonal:** Caracteriza-se pelo início no outono/inverno e pela remissão na primavera, sendo incomum no verão. A prevalência é maior entre jovens que vivem em maiores latitudes. Os sintomas mais comuns são: apatia, diminuição da atividade, isolamento social, diminuição da libido, sonolência,

aumento do apetite, “fissura” por carboidratos e ganho de peso. Para diagnóstico esses episódios devem se repetir por dois anos consecutivamente, sem quaisquer episódios não sazonais durante esse período;

- **Depressão psicótica:** É um quadro grave, caracterizado pela presença de delírios e alucinações. Os delírios são representados por ideias de pecado, doença incurável, pobreza e desastres iminentes. Pode apresentar alucinações auditivas;

- **Depressão secundária:** Caracterizada por síndromes depressivas associadas ou causadas por doenças médico-sistêmicas e/ou por medicamentos;

- **Depressão Bipolar:** A maioria dos pacientes bipolares inicia a doença com um episódio depressivo, enquanto mais precoce o início, maior a chance de que o indivíduo seja bipolar. História familiar de bipolaridade, de depressão maior, de abuso de substâncias, transtorno de ansiedade, são indícios de evolução bipolar.

A prevenção da depressão consiste na busca de um estilo de vida saudável:

- Ter uma dieta equilibrada;
- Praticar atividade física regularmente;
- Combater o estresse concedendo tempo na agenda para atividades prazerosas;
- Evitar o consumo de álcool;
- Não usar drogas ilícitas;
- Diminuir as doses diárias de cafeína;
- Rotina de sono regular;
- Não interromper tratamento sem orientação médica.



A Depressão é uma doença mental de elevada prevalência e é a mais associada ao suicídio, tende a ser crônica e recorrente, principalmente quando não é tratada. O tratamento é medicamentoso e psicoterápico. A escolha do antidepressivo é feita com base no subtipo da Depressão, nos antecedentes pessoais e familiares, na boa resposta a uma determinada classe de antidepressivos já utilizada, na presença de doenças clínicas e nas características dos antidepressivos.

90-95% dos pacientes apresentam remissão total com o tratamento antidepressivo. É de fundamental importância a adesão ao tratamento, uma vez interrompido por conta próprio ou uso inadequado da medicação, pode aumentar significativamente o risco de cronificação.

3.4 Transtorno Bipolar

O transtorno bipolar, ou transtorno afetivo bipolar se caracteriza por alterações de humor que provocam alterações no comportamento, levando a pessoa a oscilar entre momentos de euforia e depressão repentinamente. A frequência e a intensidade do quadro variam, podendo ser moderadas ou graves.

O transtorno bipolar tende a começar na adolescência ou no início da idade adulta e pode ocorrer em paralelo com outros problemas, como abuso de substâncias e comportamento irregular na escola ou em local de trabalho. Além disso, a hipomania (mania/euforia de intensidade leve) pode ser um sinal precoce da doença, levando a pessoa a ter pensamentos grandiosos ou ideias e comportamentos impulsivos.

Não há uma causa definida para o transtorno bipolar, mas acredita-se que diversos fatores possam estar envolvidos nas oscilações de humor provocadas pela doença, como:

- Fisiologia do cérebro
- Desequilíbrio entre os neurotransmissores
- Desequilíbrio hormonal
- Fatores genéticos
- Estresse
- Violência sexual e outras experiências traumáticas
- Uso de drogas, como cocaína e anfetaminas

O transtorno bipolar é dividido em três fases e em três tipos, são eles:

Fases

1. **Mania:** fase caracterizada por um estado de exaltação do humor, com aumento de energia, sem qualquer relação com o momento que o indivíduo está vivendo. O paciente não fica deprimido e nem alegre por um motivo especial, mas apresenta humor eufórico, irritável ou mesmo jocoso ou arrogante. Mania de grandeza também é muito comum
2. **Hipomania:** seria um estado de mania mais leve que, geralmente, acarreta em um funcionamento acelerado, porém produtivo para o paciente. Muitos pacientes, quando estão entrando em hipomania (podendo evoluir para a mania ou não) são resistentes quanto a manter o tratamento e, muitas vezes, param com a medicação, o que se torna um grande problema para estabilizar o transtorno
3. **Depressão:** são os mesmos sintomas de um episódio depressivo, possuindo humor deprimido, falta de energia, falta de iniciativa e vontade, falta de prazer, alteração do sono, alteração do apetite, lentidão do pensamento e lentidão motora.

Tipos

- **Transtorno bipolar tipo 1:** o paciente apresenta ciclos de oscilação de humor mais definidos e, pelo menos, um episódio maníaco, manifestação de euforia, irritabilidade e comportamentos que destoam do habitual, como gastar muito dinheiro, perder contato com a realidade e ter planos e ideias irreais, podendo durar uma semana, alternando com períodos de depressão profunda
- **Transtorno bipolar tipo 2:** diferente do tipo 1, o paciente possui ciclos de oscilação de humor mais sutis, além de não atingir a mania completa e manifestar com mais frequência episódios de depressão
- **Ciclotimia:** envolve oscilações de humor menos graves, em que os pacientes alternam entre hipomania e depressão leve. Muitas vezes, pessoas com transtorno bipolar do tipo 2 ou ciclotimia podem ser diagnosticadas incorretamente como tendo apenas depressão.

Os **sintomas de transtorno bipolar** dependem do tipo exato da doença e costumam variar de pessoa para pessoa, entre eles são:

- Oscilação de humor
- Humor deprimido
- Alterações de sono
- Tristeza profunda
- Desinteresse por atividades que antes eram prazerosas
- Dificuldade de concentração
- Cansaço
- Pensamentos suicidas
- Irritabilidade
- Episódios de mania, como picos de euforia, pouca necessidade de sono, fisicamente ativa, desvio de atenção e comportamento agressivo
- Episódios de hipomania, em que o paciente pode se apresentar mais eufórico, falante e ativo do que o habitual
- Depressão

3.5 Transtornos de Ansiedade

Os transtornos de ansiedade ocorrem quando a ansiedade se torna tão intensa e frequente que dificulta o dia a dia. Existem diversos tipos de transtornos de ansiedade, cada um com características próprias, mas todos se manifestam com desconforto:

- Transtorno de Ansiedade Generalizada (TAG):
- Transtorno de Pânico (TP)
- Transtorno de Ansiedade Fóbica (ou “fobia social”)
- Agorafobia
- Transtorno de Estresse Pós-Traumático (TEPT)
- Transtorno Obsessivo Compulsivo (TOC) *

*O Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais - DSM5 não mais apresenta o Transtorno Obsessivo Compulsivo (TOC) dentro da categoria *Transtornos de Ansiedade*, mas em uma categoria separada denominada *Transtorno Obsessivo Compulsivo e Transtornos relacionados*.

A ansiedade é uma sensação de nervosismo, preocupação ou desconforto, sendo uma experiência humana normal. Ela também está presente em uma ampla gama de problemas de saúde mental, incluindo o transtorno de ansiedade generalizada, a síndrome do pânico e fobias. Apesar de essas doenças serem diferentes entre si, todas elas apresentam angústia e disfunção especificamente relacionadas à ansiedade e ao medo.

A ansiedade é uma reação normal a uma ameaça ou a um estresse psicológico. A ansiedade não patológica tem sua raiz no medo e desempenha um importante papel na sobrevivência. Quando uma pessoa se vê diante de um perigo ou uma ameaça, a ansiedade desencadeia uma resposta de luta ou fuga. Assim, se inicia uma série de alterações físicas, como uma maior irrigação sanguínea para o coração e para os músculos para proporcionar ao corpo a energia e a força necessárias para enfrentar situações de risco à vida, como fugir de um animal agressivo ou enfrentar um agressor.

Assim, fica evidente a importância da ansiedade para ajudar a pessoa a se adaptar a fatores estressantes mais comuns, motivando-a a se preparar, praticar e ensaiar. Em sua íntima relação com o medo, ela pode até mesmo levar uma pessoa a abordar situações potencialmente perigosas com a devida cautela.

No entanto, a ansiedade é considerada um transtorno quando:

- Ocorre em momentos indevidos
- Ocorre com frequência
- É tão intensa e duradoura que interfere com as atividades normais da pessoa (ou seja, ela dá origem a um comportamento desadaptativo)

A ansiedade significativa pode persistir vários anos e a pessoa com a ansiedade começa a acreditar que isso é normal. Por essa e outras razões, os transtornos de ansiedade muitas vezes não são diagnosticados ou tratados. Eles também podem estar associados a pensamentos suicidas e tentativas de suicídio.

Outros distúrbios que costumam aparecer com ansiedade proeminente incluem o transtorno de estresse agudo, transtornos de adaptação e o transtorno de estresse pós-traumático (TEPT). Esses distúrbios são causados por experiências traumáticas ou estressantes e são muito prevalentes entre os profissionais de segurança pública.

Os transtornos de ansiedade tendem a ocorrer concomitantemente a outros problemas médicos e de saúde mental:

- Problemas de saúde mental: depressão, transtorno bipolar, transtornos por uso de substâncias, transtornos de personalidade e outros transtornos de ansiedade.
- Problemas de saúde: doença arterial coronariana, asma, enxaquecas e artrite.

As causas dos transtornos de ansiedade não são completamente conhecidas, mas pode haver o envolvimento dos seguintes fatores:

- Ambiente (por exemplo, vivenciar um evento traumático ou estresse);
- Fatores genéticos (incluindo histórico familiar de transtorno de ansiedade);
- Uma doença física (por exemplo, glândula tireoide hiperativa, insuficiência cardíaca);
- Medicamentos, entorpecentes ou outras substâncias (por exemplo, cafeína, corticoides, cocaína);

Um transtorno de ansiedade pode ser iniciado por estresses causados pelo meio, como o fim de um relacionamento importante ou a exposição a um desastre com risco à vida. No entanto, muitas pessoas desenvolvem um transtorno de ansiedade na ausência de um fator desencadeante identificável.

Um transtorno de ansiedade pode se surgir quando a pessoa apresenta uma resposta intensa a um fator estressante ou quando a pessoa é subjugada pelos acontecimentos. Por exemplo, algumas pessoas entendem que discursar em público é uma atividade estimulante. Outras, no entanto, odeiam essa atividade e ficam ansiosas, tendo sintomas como sudorese, medo, aumento da frequência cardíaca e tremores. Pessoas sujeitas a essas reações podem evitar falar mesmo diante de um grupo pequeno.

A ansiedade tende a ser hereditária. Os médicos acreditam que algumas dessas tendências podem ser hereditárias, mas algumas são provavelmente adquiridas ao longo da vida.

3.5.1 Relacionados a Fatores Traumáticos e Estressantes



Os transtornos relacionados a fatores traumáticos e estressantes surgem quando a pessoa é exposta a um evento traumático ou estressante. Os transtornos específicos incluem o transtorno de estresse pós-traumático (TEPT), o transtorno de estresse agudo e transtornos de adaptação. Estes transtornos causam sintomas semelhantes, mas diferem na sua duração.

Os transtornos relacionados a fatores traumáticos e estressantes surgem após um evento traumático. Eles compartilham muitas características, incluindo disforia (desconforto geral ou insatisfação), irritabilidade, dissociação (desconexão de alguns aspectos do funcionamento mental do sentido de si próprio sem estar consciente disso), uso de substâncias ou insônia. Eles diferem quanto à gravidade e à duração dos sintomas.

Embora a depressão e a ansiedade sejam com frequência evidentes em pessoas com transtornos relacionados a fatores traumáticos e estressantes, eles costumam ter uma ampla variedade de sintomas que podem não parecer estar obviamente relacionados ao evento traumático. Por exemplo, a pessoa pode agir de modo agressivo, não conseguir sentir prazer e/ou sentir agitação, descontentamento, raiva, entorpecimento ou desconectada de si mesma e de outros.

❖ O transtorno de estresse agudo

O transtorno de estresse agudo é uma reação disfuncional intensa e desagradável que tem início logo após um evento extremamente traumático e dura menos de um mês. Se os sintomas persistirem além de um mês, a pessoa será diagnosticada com transtorno de estresse pós-traumático (TEPT).

A pessoa com transtorno de estresse agudo desenvolve reações de estresse agudas que aparecem no prazo de um mês após ela ter sido exposta a um evento traumático. Essas reações de estresse incluem aumento da ansiedade, reviver mentalmente o evento traumático, evitar coisas que relembrem o trauma, mostrar humor negativo, desenvolver sintomas dissociativos (incluindo desrealização e amnésia) e mostrar aumento da excitação.

A pessoa com esse transtorno pode apresentar sintomas dissociativos. Por exemplo, ela pode se sentir emocionalmente entorpecida ou desligada de si mesma. É possível que ela sinta que não existe.

O grau de angústia após um evento traumático em pessoas com transtorno de estresse agudo tende a ser maior do que o observado em pessoas com transtorno de adaptação.

O número de pessoas com transtorno de estresse agudo é desconhecido. A chance de uma pessoa apresentar transtorno de estresse agudo é maior quando os eventos traumáticos são graves ou recorrentes.

❖ O transtorno de estresse pós-traumático (TEPT)



O transtorno de estresse pós-traumático (TEPT) consiste em reações intensas, desagradáveis e disfuncionais que ocorrem após um evento extremamente traumático. Dura mais de um mês e pode se desenvolver como uma continuação do transtorno de estresse agudo ou desenvolver-se separadamente até seis meses após o evento.

Eventos de risco à vida ou ferimentos graves podem causar angústia intensa e de longa duração. Esses eventos são mais frequentes quando falamos da atividade de segurança pública. É possível que a pessoa afetada pelo TEPT reviva o evento, tenha pesadelos frequentes e evite qualquer coisa que possa lembrá-la do evento.

Muitas pessoas são afetadas de maneira duradoura quando algo terrível acontece. Em algumas, os efeitos são tão persistentes e graves que são debilitantes e representam um transtorno. Os eventos mais propensos a causar TEPT são aqueles que invocam sentimentos de medo, desamparo ou horror. Combate, agressão sexual e desastres naturais ou provocados pelo homem são causas comuns do TEPT. No entanto, ele pode ser causado por qualquer experiência avassaladora e possivelmente fatal, como violência física ou um acidente de automóvel.

Esses eventos podem ser vivenciados diretamente (por exemplo, sofrer uma lesão grave ou ser ameaçado de morte) ou indiretamente (testemunhar outras pessoas sofrendo lesões graves, morrendo, ou serem ameaçadas de morte, ficar sabendo de eventos traumáticos que ocorreram com familiares ou amigos íntimos ou participar das repercussões da experiência traumática de

outra pessoa, como é o caso dos policiais e bombeiros). É possível que a pessoa tenha vivenciado um único evento traumático ou, como ocorre com frequência, vários eventos traumáticos.

Não se sabe por que um mesmo evento traumático pode causar TEPT vitalício em algumas pessoas, mas não causar nenhum sintoma em outras. Além disso, não se sabe por que algumas pessoas testemunham ou vivenciam o mesmo trauma muitas vezes ao longo de anos sem ter TEPT, mas o desenvolvem em algum momento após um episódio aparentemente semelhante.

É possível que o TEPT crônico não desapareça completamente, mas geralmente fica menos intenso com o passar do tempo, mesmo sem tratamento. No entanto, algumas pessoas permanecem gravemente prejudicadas pelo transtorno em ambientes sociais, no trabalho e em seus relacionamentos pessoais.

❖ Os transtornos de adaptação

Os transtornos de adaptação compreendem reações a eventos estressantes que podem ser marcos comuns do desenvolvimento (por exemplo, tornar-se pai ou mãe) ou ocorrências mais perturbadoras de duração variável (por exemplo, perder um emprego, cuidar de um membro da família com deficiência ou ter problemas com um relacionamento romântico) que causam angústia desproporcional ao evento estressante e levam a dificuldades com o funcionamento cotidiano.

Esses transtornos tendem a se desenvolver logo após o evento estressante e persistem por menos de seis meses. No entanto, os sintomas do transtorno de adaptação podem persistir indefinidamente se o estresse for persistente (por exemplo, doença contínua de um familiar ou desemprego crônico).

Existem muitas manifestações no transtorno de adaptação, sendo as mais comuns: humor deprimido, ansiedade e má conduta. A maioria das pessoas apresenta uma mistura desses sintomas, mas algumas podem apresentar apenas um sintoma especialmente proeminente (por exemplo, sensação de nervosismo e tremores após uma agressão física).

Existe também um maior risco de haver tentativas de suicídio e suicídio consumado.

4. ESTIGMAS E BUSCA DE AJUDA EM SAÚDE MENTAL

A OMS aponta que, em todo o mundo, 80% das pessoas com casos severos de saúde mental estão sem tratamento.

O Brasil se tornou um dos países mais afetados por transtornos mentais, com números alarmantes. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), o país está no topo do ranking de ansiedade e depressão na América Latina, com quase 19 milhões de pessoas com essas condições, sendo o país com a maior prevalência de depressão nesta região.

Estes dados apontam para a necessidade de aumentar a conscientização sobre a importância da saúde mental e vencer o estigma em relação à busca por tratamento profissional. Facilitar o acesso aos tratamentos e profissionais especializados é uma medida necessária para enfrentar o problema, mas que ainda esbarra no preconceito em torno da saúde mental.

Podemos definir estigma como um conjunto de percepções e atitudes negativas, crenças e preconceitos sobre uma determinada condição ou grupo de pessoas. O estigma da saúde mental é um problema que afeta a forma como as pessoas percebem, compreende e agem em relação às questões do processo saúde/doença mental.



Figura 9 Estigma (imagem de domínio público)

As consequências dos estigmas de saúde mental são muito danosas tanto para aqueles que enfrentam problemas de saúde mental quanto para seus familiares e a sociedade como um todo.

As raízes dos estigmas se encontram em medos, estereótipos e mal-entendidos construídos e compartilhados culturalmente. Assim, o estigma geralmente vem da falta de educação ou compreensão. As pessoas são rápidas em julgar e rotular estereótipos como fatos, e é por isso que os problemas de saúde mental são frequentemente descartados ou ignorados. Embora tenha havido alguma melhora na educação sobre saúde mental, o estigma da saúde mental ainda existe hoje.

Os estigmas levam à marginalização das pessoas que enfrentam problemas mentais e ao desencorajamento da busca de ajuda por parte daqueles que temem tornarem-se alvos da discriminação. Assim, a relação entre estigma e busca de ajuda em saúde mental é sempre uma relação inversamente proporcional: quanto maior o estigma, menor a busca de ajuda e quanto menor o estigma, maior a busca de ajuda (Figura 7).

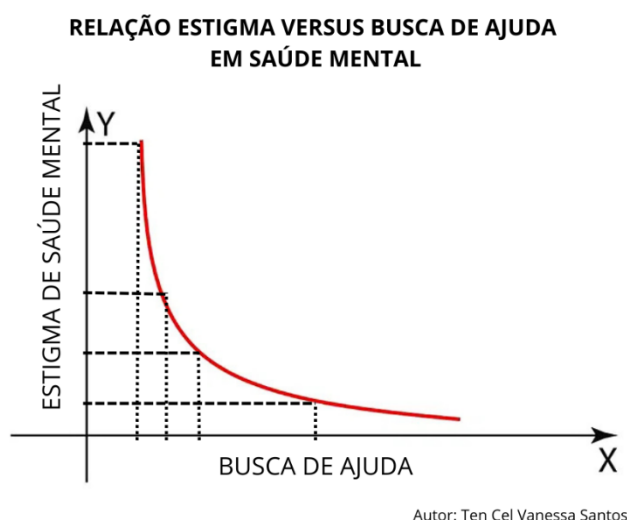


Figura 10 Relação estigma x busca de ajuda (SANTOS, 2024)

O letramento em saúde mental desempenha um papel crucial na redução do estigma e consequente aumento da busca de ajuda em saúde mental. Ensinar sobre saúde mental nos diversos ambientes, inclusive nos ambientes de trabalho, ajuda a disseminar informações úteis e combater os mitos sobre a temática. Campanhas de conscientização também tendem a melhorar a compreensão das pessoas sobre a saúde mental e ajudam a construir uma cultura de aceitação, compreensão e apoio. O processo de redução do estigma e mudança cultural é longo e requer esforços contínuos de todos os indivíduos.

5. VITIMIZAÇÃO POLICIAL

Vitimização policial consiste no ato em que o policial é vítima de violência letal ou não. No Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2022, o Coronel da Reserva da PMESP Alan Fernandes, descreve a vitimização policial em duas dimensões que denominou “objetiva” e “subjetiva”.

Segundo o autor, a vitimização é objetiva quando o policial é alvo de mortes e lesões. Porém, enfatizou que profissionais de segurança foram vítimas ameaças (75,6% em serviço e 53,1% fora de serviço), assédio moral ou humilhação no ambiente de trabalho (63,5%) e foram discriminados por serem profissionais de segurança pública (65,7% e 73,8% entre policiais militares), no que ele denominou vitimização subjetiva.

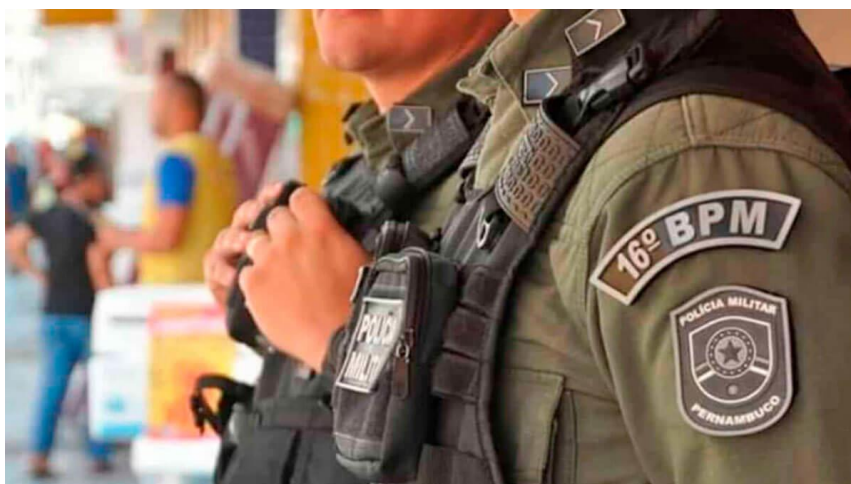


Figura 11 Polícia Militar de Pernambuco

Considerando os dados sobre mortes de policiais, onde os números em 2022 mostravam que policiais morriam mais em confronto na folga, depois por suicídio e, por último, por confronto em serviço, os números referentes a 2023 apontaram, pela primeira vez desde que o Fórum Brasileiro de Segurança Pública - FBSG passou a coletar dados sobre vitimização de policiais, que o que mais matou policiais militares no ano de 2023 foi o suicídio. PMs morreram mais por suicídio do que por confronto na folga e por confronto em serviço.

O ano de 2023 registrou, em relação ao ano anterior, queda de 18,1% na taxa de policiais civis e militares vítimas de CVLIs (Crimes Violentos Letais e Intencionais) no Brasil, enquanto a taxa de suicídios de policiais civis e militares da ativa cresceu 26,2% no mesmo período no país. Considerando apenas a Polícia Militar, o total nacional de suicídios nas corporações superou, em 2023, a soma dos registros de PMs mortos em confronto em serviço e fora de serviço. Foram 110 registros de suicídios, ante 46 casos de PMs mortos em confronto em serviço e 61 mortos em confronto ou por lesão não natural fora de serviço – 107 óbitos ao todo. (FNSP, 2024, p. 48)

Utilizaremos o artigo “Policiais mortos em 2023: suicídios superam mortes em confronto” do 18º Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2024 (p. 48-58), disponível no link <https://publicacoes.forumseguranca.org.br/items/f62c4196-561d-452d-a2a8-9d33d1163af0> e também anexo a esta apostila. Bons estudos!



Figura 12 18 Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2024, p. 48

Considerando que o suicídio está entre as três maiores causas de vitimização policial, utilizaremos o capítulo 1 Suicidologia do livro “Suicide by Cop: Suicídio de Policial e Suicídio Noutra Perspectiva” / Márcio Santiago Higashi Couto, Onivan Elias de Oliveira, José Edir Paixão Sousa. O texto encontra-se anexo a esta apostila.

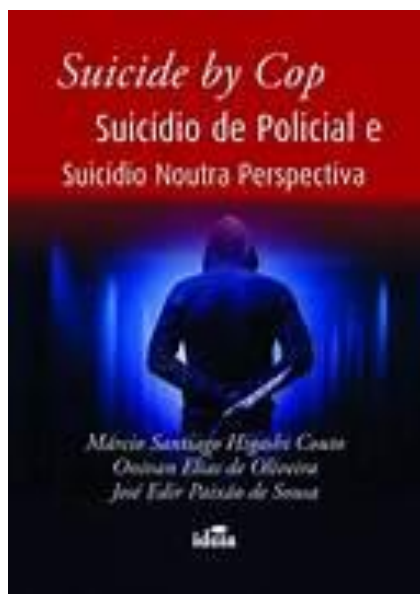


Figura 13 Livro Suicide by Cop

6. RECURSOS DE APOIO À SAÚDE MENTAL NA PMPE

6.1 Núcleo de Saúde Mental Ten Cel PM Aline Maria Lopes dos Prazeres de Luna – NSM PMPE

A Política de Saúde Mental da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) é administrada pelo Núcleo de Saúde Mental (NSM PMPE), criado através da Portaria do Comando Geral Nº 562, de 23 de março de 2023 e oficialmente inaugurado no dia 27 de março do mesmo ano.

Subordinado à Diretoria de Assistência Social – DAS, o Núcleo de Saúde Mental da Polícia Militar de Pernambuco tem por missão, realizar a gestão da Política Pública de Saúde Mental da Corporação e tem as seguintes atribuições:

- Assessorar o Comandante-Geral da PMPE sobre a saúde mental e qualidade de vida dos policiais;
- Receber demandas da Secretaria de Defesa Social;
- Promover ações de capacitação, educação e conscientização;
- Planejar e implementar apoio às unidades da PMPE;
- Produzir e tratar dados e estatísticas de saúde mental;
- Implementar, monitorar e aperfeiçoar sempre que necessário, a Política Pública Saúde Mental na Corporação, com intervenções, ações e projetos de curto, médio e longo prazos;
- Normatizar a Doutrina de Saúde Mental da PMPE, com a construção de protocolos e orientações voltados à promoção da saúde, à prevenção do adoecimento mental e à identificação demandas de adoecimento mental e sofrimento psíquico, com seus devidos encaminhamentos;
- Recepcionar demandas relativas à pauta de Saúde Mental e Qualidade de Vida advindas da Secretaria de Defesa Social;
- Promover ações voltadas à capacitação, educação e conscientização de todo o efetivo acerca da doutrina de saúde mental a ser adotada pela Corporação, através de workshops, sugestão de conteúdos programáticos nos diversos cursos de formação e capacitação, campanhas educativas contínuas e assessoramento a comandantes, chefes e diretores sobre a temática;

- Planejar e implementar apoio contínuo às unidades operacionais e administrativas através de visitas itinerantes de equipes de saúde biopsicossocial, plantões psicológicos, palestras e outras ações pontuais, conforme necessidade e cronograma estabelecidos pela DAS;
- Atuar, quando necessário, em parcerias com organizações da sociedade civil a fim fortalecer a política pública de saúde mental da Corporação;
- Recepcionar demandas relativas à Saúde Mental e Qualidade de Vida advindas Secretaria de Defesa Social do Estado;
- Assessorar tecnicamente o Comandante-Geral da Corporação em relação à Saúde Mental e Qualidade de Vida do efetivo, através do Diretor de Assistência Social.



Figura 14 Placa da criação do NSM PMPE

O NSM PMPE, denominado Núcleo de Saúde Mental TC PM Aline Maria Lopes dos Prazeres de Luna, em homenagem à Oficial Combatente e Psicóloga que se tornou símbolo da causa da saúde mental na Corporação, tem sua sede na Rua Coronel Silva Torres, 73, no bairro do Derby, Recife-PE.

Entendendo que a atividade policial militar carrega consigo fatores estressores que, somados às demandas da vida privada, têm elevado potencial de causar distúrbios psicológicos e afetar de forma geral a saúde biopsicossocial do policial militar, o Núcleo de Saúde Mental PMPE, dentro das Doutrinas de Saúde Mental estabelecidas na Corporação, através da Instrução Normativa 564, de 03 de abril de 2023, atua na gestão da promoção, prevenção e assistência em Saúde Mental no âmbito da PMPE.

O NSM PMPE desenvolve ações, programas e projetos em saúde mental, dentre os quais podemos destacar:

- Atendimento de psicoterapia presencial e on-line gratuito prioritário para policiais militares do serviço ativo.
- Programa de suporte entre pares “Tamojunto”.
- Palestras nas OMEs.
- Campanhas educativas (janeiro branco, setembro amarelo e outras).
- Serviço de apoio psicológico (psicólogo de sobreaviso) para casos de ocorrências traumáticas, mortes e outras crises envolvendo policiais militares pernambucanos.

Destacam-se entre as iniciativas do NSM PMPE, o atendimento de psicoterapia on-line gratuito para todos os policiais militares ativos do estado e o Programa de Suporte entre Pares da Corporação denominado Tamojunto - TMJ.

Oficialmente lançado no dia 26 de setembro de 2024 o “Programa TMJ” - Programa de iniciativa da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), visa capacitar policiais militares, de todas as regiões do estado para atuarem na política de suporte de pares.

Cada OME possui dois policiais denominados focais, que são policiais do quadro de praças, voluntários, treinados para que possam em suas respectivas unidades orientar e ouvir os colegas de trabalho e, caso estes precisem de ajuda profissional relacionadas à saúde mental, o policial focal contacta o NSM PMPE para o devido encaminhamento psicológico e/ou psiquiátrico.



Figura 15 Logotipo do Programa TMJ PMPE

Vale ressaltar que nas respectivas OME o focal pode criar ações e junto com o núcleo implementá-las, tais como ciclo de palestras, workshop, de temas variados que visem dar suporte efetivo.

O nome do programa foi escolhido com base na metodologia de suporte entre pares, já conhecida e utilizada em diversos setores de diversos países. Esta metodologia baseia na ajuda mútua, onde um policial orientado e capacitado dá suporte a outro policial militar (suporte entre pares), desta forma é possível diminuir o estigma da busca pela ajuda em saúde mental e também, a longo e médio prazo, proporcionar mudança na cultura policial de invulnerabilidade (a falácia do herói, do imortal), encorajando a busca por ajuda, melhorando as relações, humanizando os processos e prevenindo o adoecimento.

6.2 Fundação de Apoio ao CAS - FCAS

Além do Núcleo de Saúde Mental da PMPE, a DAS – Diretoria de Assistência Social - conta com outros serviços que visam a prevenção e o cuidado com a saúde mental do efetivo, em trabalho conjunto com FCAS – Fundação de Apoio ao Centro de Assistência Social da PMPE. Estes serviços são oferecidos aos policiais militares ativos e veteranos que são contribuintes da fundação, assim como seus dependentes legais. Os serviços oferecidos são:

- Gabinete de Psicologia:

O Gabinete de psicologia, administrado pela Fundação de apoio ao CAS – FCAS, trabalha em conjunto com o NSM PMPE e conta com o serviço de psicologia que atende na modalidade presencial. Conta também com apoio de médico psiquiatra.

Além do atendimento de psicoterapia semanal, também são oferecidos atendimentos pós-trauma em ocorrência e pós-trauma em suicídio. O gabinete de psicologia conta com unidades em Recife, Nazaré da Mata, Palmares, Caruaru, Garanhuns, Serra Talhada e Petrolina.



Figura 16 Instalação do Gabinete de Psicologia em Recife

- NADEQ PMPE – Núcleo de Apoio ao Dependente Químico:

O Núcleo de Apoio ao Dependente Químico (NADEQ) tem como propósito acolher, tratar e resgatar policiais militares que sejam dependentes de substâncias psicoativas afetando sua saúde mental e seu convívio social.

O programa é realizado nas dependências do NADEQ, por uma equipe multidisciplinar, que envolve terapias individuais e de grupo, atendimento psiquiátrico, atividade física, arteterapia, assistência social a policiais militares e familiares, dentre outras atividades.

Atendendo policiais militares da Região Metropolitana do Recife, como também do interior do Estado. O atendimento presencial no NADEQ acontece de segunda a sexta-feira, no horário das 08h00 às 15h00. O policial militar poderá se apresentar voluntariamente no local, ser apresentado pelo seu comandante ou encaminhado por médico psiquiatra, sendo submetido a uma triagem antes de iniciar o tratamento.

- Complexo de Qualidade de Vida da Polícia Militar de Pernambuco

O Complexo de Qualidade de Vida e o Ginásio de Terapias Integradas (GTI) estão localizados na Vila Militar e oferecem aos policiais militares e seus dependentes assistência com médicos, psicólogos, fisioterapeutas, nutricionistas, médicos da família, educadores físicos, massoterapeutas e serviços de terapias holísticas, acupuntura, biodança, quiropraxia, hidroterapia e todas as modalidades terapêuticas necessárias para a qualidade de vida focada na prevenção. Também são oferecidos tratamentos nas diversas áreas biopsicossociais, com uma equipe multidisciplinar para pronto atendimento e uma equipe completa para tratamento de patologias já instaladas, reabilitando o policial para o serviço. A saúde preventiva está no centro das atenções, cuidando da vida para prevenir o adoecimento.

6.3 Projeto Escuta SUSP do Ministério da Justiça e Segurança Pública



O Escuta SUSP oferece serviço de psicoterapia on-line e gratuito para profissionais de segurança pública. A iniciativa é fruto da parceria entre a Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) e a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e visa oferecer atendimento psicológico especializado aos profissionais de segurança pública.

Atualmente, o projeto já funciona em Alagoas (AL), no Distrito Federal (DF), em Minas Gerais (MG), em Pernambuco (PE), no Rio Grande do Norte (RN), no Maranhão (MA) e em Sergipe (SE). Profissionais da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Polícia Penal e do Corpo de Bombeiros Militar, além de peritos criminais contam com o atendimento de 42 terapeutas.

Para que os profissionais de segurança pública possam ter acesso às consultas, basta acessar o site, preencher o cadastro e anexar uma cópia da carteira funcional para comprovar o vínculo institucional. O agendamento é feito por e-mail, e as sessões são on-line e semanais.

REFERÊNCIAS

- Carneiro, Laila Leite. Qualidade de Vida no Trabalho. Salvador: 2018.
- Couto, Márcio Santiago Higashi. Suicide by cop: suicídio do policial e suicídio noutra perspectiva. João Pessoa: Ideia, 2021.
- Lipp, M. E. N. (2003). *Mecanismos neuropsicofisiológicos do stress: teoria e aplicações*. São Paulo: Casa do Psicólogo.
- Lipp, M. E. N. (2010). O modelo quadrifásico do stress. In M. E. N. Lipp (org). *Mecanismo Neuropsicofisiológicos do Stress: teoria e aplicações clínicas*. São Paulo: Casa do Psicólogo.
- Ministério da Saúde, <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/d/depressao>
- Ministério Público do Piauí. Guia Prático sobre a Síndrome de Burnout. Terezina: 2020.
- Organização Mundial da Saúde. (2021). Mental health: strengthening our response. [Disponível em: www.who.int](<http://www.who.int>)
- Organização Mundial da Saúde. (2021). WHOQOL: Measuring Quality of Life. [Disponível em: www.who.int](<http://www.who.int>)
- World Health Organization. (2019). Mental health in the workplace. [Disponível em: www.who.int](<http://www.who.int>)
- World Health Organization. (2021). Mental health promotion and mental disorder prevention: A policy for the European Region. [Disponível em: www.who.int](<http://www.who.int>)

ANEXOS

1. Suplemento Normativo PMPE 13/2023.
2. Suplemento Normativo PMPE 17/2023.
3. Portaria do Comando-Geral PMPE 300/2024.
4. Cartilha do Policial Militar Focal PMPE.
5. 18º Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2024.
6. Artigo “A profissão do policial militar: vivências de prazer e sofrimento no trabalho (WINTER, 2019).
7. Cap. 1 Suicide by Cop: suicídio de policial e suicídio noutra perspectiva.

Art. 4º Os Comandantes, Chefes e Diretores deverão providenciar instrução ao efetivo através das suas Seções de Ensino e Instrução ou seção equivalente, não existindo, far-se-á através da Seção de Pessoal ou setor correspondente.

Art. 5º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. Tibério César dos Santos – Cel QOPM Comandante Geral.(SEI nº 3900000278.000162/2022-00).

--oo(0)oo--

Nº 562, de 23 MAR 2023

EMENTA: Cria Núcleo de Saúde Mental da Polícia Militar de Pernambuco **"NÚCLEO DE SAÚDE MENTAL TEN CEL PM ALINE MARIA LOPES DOS PRAZERES DE LUNA"**.

O Comandante-Geral, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 101, I,II, III e IV do Decreto nº 17.589, de 16 de junho de 1994, que aprovou o Regulamento Geral da Polícia Militar de Pernambuco.

Considerando que a atividade policial militar carrega consigo fatores estressores que, somados às demandas da vida privada, têm elevado potencial de causar distúrbios psicológicos e afetar de forma geral a saúde biopsicossocial do policial militar.

Considerando a necessidade de realizar a gestão da Política Pública de Saúde Mental da Polícia Militar de Pernambuco, assim como a necessidade de planejar, executar e monitorar intervenções, ações e projetos específicos voltados à promoção, prevenção e assistência em Saúde Mental, melhorando os níveis de qualidade de vida e saúde emocional dos Policiais Militares ativos e veteranos no âmbito da Corporação.

R E S O L V E:

Art. 1º Criar o Núcleo de Saúde Mental da PMPE, denominado **"NÚCLEO DE SAÚDE MENTAL TEN CEL PM ALINE MARIA LOPES DOS PRAZERES DE LUNA"**, subordinado à Diretoria de Assistência Social (DAS).

Art. 2º O Núcleo de Saúde Mental da PMPE passa a ter as seguintes atribuições:

- a. implementar, monitorar e aperfeiçoar sempre que necessário, a Política Pública de Saúde Mental na Corporação, com intervenções, ações e projetos de curto, médio e longo prazos;
- b. normatizar a Doutrina de Saúde Mental da PMPE, com a construção de protocolos e orientações voltados à promoção da saúde, à prevenção do adoecimento mental e à identificação das demandas de adoecimento mental e sofrimento psíquico, com seus devidos encaminhamentos;
- c. recepcionar demandas relativas à pauta de Saúde Mental e Qualidade de Vida advindas da Secretaria de Defesa Social.
- d. promover ações voltadas à capacitação, educação e conscientização de todo o efetivo acerca da doutrina de saúde mental a ser adotada pela Corporação, através de workshops, sugestão de conteúdos programáticos nos diversos cursos de formação e capacitação, campanhas educativas contínuas e assessoramento a comandantes, chefes e diretores sobre a temática.
- e. planejar e implementar apoio contínuo às unidades operacionais e administrativas, através de visitas itinerantes de equipes de saúde biopsicossocial, plantões psicológicos, palestras e outras ações pontuais, conforme necessidade e cronograma estabelecidos pela DAS;
- f. atuar, quando necessário, em parcerias com organizações da sociedade civil a fim de fortalecer a política pública de saúde mental da Corporação;
- g. recepcionar demandas relativas à Saúde Mental e Qualidade de Vida advindas de Secretaria de Defesa Social do Estado;
- h. apoiar os processos de seleção, no âmbito da Corporação, nas pautas relativas a perfis profissiográficos, testes psicométricos, avaliações psicológicas e outras demandas contempladas pela Psicologia;

- i. acompanhar os processos de formação, capacitação e aperfeiçoamento no âmbito da Corporação no que diz respeito à Psicologia;
- j. produzir e tratar dados e estatísticas de Saúde Mental na Corporação;
- k. produzir estudos sobre a temática da Saúde Mental e Qualidade de Vida na Corporação;
- l. assessorar tecnicamente o Comandante-Geral da Corporação em relação à Saúde Mental e Qualidade de Vida do efetivo, através do Diretor de Assistência Social.

Art. 3º Esta Instrução Normativa entrará em vigor na data de sua publicação. Tibério César dos Santos – Cel QOPM Comandante Geral. (SEI nº 3900000015.000969/2023-14)

3ª P A R T E

III – Normas Externas

(Sem Alteração)

**ABÍLIO APOLÔNIO CUSTÓDIO DA SILVA - Ten Cel QOPM
AJUDANTE GERAL**



Documento assinado eletronicamente por **Abilio Apolonio Custodio da Silva**, em 24/03/2023, às 19:10, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do [Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.pe.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **34662421** e o código CRC **32086910**.

QUARTEL DO COMANDO GERAL DA PMPE

Praça do Derby s/nº, Derby, Recife-PE CEP 52.010-140 Fones (081) 3181-1320, Fax 3181-1002,
E-mail acg.pm@pm.pe.gov.br

“Nossa presença, sua Segurança!”

ESTADO DE PERNAMBUCO
POLÍCIA MILITAR
QUARTEL DO COMANDO GERAL



QUARTA-FEIRA - RECIFE, 19 DE ABRIL DE 2023 - SUNOR Nº G 1.0.00.017

SUPLEMENTO NORMATIVO

Para conhecimento desta PM e devida execução, publico o seguinte:

1ª P A R T E

I – Leis e Decretos

(Sem Alteração)

2ª P A R T E

II – Normas Internas

1.0.0. INSTRUÇÃO NORMATIVA DO COMANDO GERAL

Nº 564, de 03 ABR 2023

Ementa: Institui princípios, diretrizes e ações a serem adotados pelo efetivo da PMPE, em âmbito interno da Corporação, sobre saúde mental.

O Comandante-Geral, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 101, I, II, III e IV, do Decreto nº 17.589, de 16 de junho de 1994, que aprovou o Regulamento Geral da Polícia Militar de Pernambuco; e

Considerando a necessidade de se estabelecer normas e diretrizes de funcionamento para o recém-criado Núcleo de Saúde Mental TC PM Aline Maria Lopes dos Prazeres Luna.

R E S O L V E:

Art. 1º Instituir princípios, diretrizes e ações a serem adotados como referência nos procedimentos em saúde mental na Polícia Militar de Pernambuco.

CAPÍTULO I
PRINCÍPIOS NORTEADORES

Art. 2º Os procedimentos em saúde mental a serem adotados pela Polícia Militar de Pernambuco obedecerão aos seguintes princípios:

I – estar em consonância com as políticas públicas de saúde mental, considerando as políticas de cuidados ao servidor da Secretaria de Defesa Social do Estado, os pressupostos estabelecidos pelo Ministério da Saúde e Ministério da Justiça e Segurança Pública, através da Secretaria Nacional de Segurança Pública, além das recomendações da Organização Mundial de Saúde – OMS e a Organização Pan-Americana da Saúde - OPAS, respeitando as especificidades da carreira policial militar e a realidade local;

II – basear-se em princípios humanitários e éticos de igualdade, equidade, não discriminação, privacidade e autonomia individual, garantindo o tratamento adequado ao paciente;

III – incentivar parcerias e redes, em um sistema integrado de referência e contrarreferência de atenção psicossocial que propicie a expansão de ações e serviços de saúde mental e potencialize resultados na área de prevenção aos agravos, de promoção à saúde, de assistência terapêutica e de reabilitação para melhor articulação e universalização do cuidado em saúde mental na Corporação;

IV – apoiar interlocuções com setores da sociedade que atuem em saúde mental;

V – priorizar estratégias coletivas para o enfrentamento dos problemas relacionados à saúde mental dos policiais militares, com monitoramento dos riscos ambientais e considerando indicadores de saúde, bem como com promoção de ações educativas;

VI – gerenciar os esforços de atendimentos, por meio de equipes multiprofissionais nas unidades da capital e interior, através da atuação do Núcleo de Saúde Mental TC PM ALINE MARIA LOPES DOS PRAZERES LUNA sob responsabilidade da Diretoria de Assistência Social - DAS, garantindo um atendimento interdisciplinar e uma abordagem transdisciplinar; e

VII – desenvolver intervenções, ações e programas de apoio aos processos seletivos e de formação, capacitação e aperfeiçoamento no âmbito da Corporação.

CAPÍTULO II DIRETRIZES E AÇÕES

Seção I Da Promoção de Saúde Mental

Art. 3º Para os fins desta Instrução Normativa, entende-se por promoção de saúde mental as ações voltadas à melhoria das condições e relações de trabalho que favoreçam a ampliação do conhecimento, do desenvolvimento de atitudes e de comportamentos individuais e coletivos para a proteção da saúde mental do policial militar.

§ 1º Inclui-se na promoção de saúde mental a prevenção a danos e agravos de ordem mental, entendida como ação antecipada para evitar abalos à saúde psíquica e emocional do policial militar em decorrência de fatores comportamentais, ambientais e/ou decorrentes da labuta.

§ 2º São considerados procedimentos de promoção à saúde mental do policial militar a serem realizados pelo Núcleo de Saúde Mental da PMPE:

I - promover ações que mantenham e fortaleçam vínculos entre os policiais militares em sofrimento/adoecimento psíquico com seus familiares, pares, superiores e subordinados, tornando estes parceiros no acolhimento, no planejamento do tratamento e na constituição de redes de apoio e de integração social a todos os envolvidos;

II - realizar programas e ações fundamentados em informações epidemiológicas, considerando as especificidades e as vulnerabilidades do policial militar;

III - realizar ações de promoção inclusivas com respeito à pluralidade cultural e à diversidade humana (diferenças de religião, gênero, orientação sexual, étnica, habilidade física ou intelectual, classe e idade), buscando combater o estigma das pessoas em situação de adoecimento/sofrimento psíquico;

IV - promover a concepção ampliada de saúde mental, integrada à saúde física e ao bem-estar socioeconômico dos policiais militares;

V - planejar e direcionar as ações de promoção ao desenvolvimento humano, ao incentivo à educação para a vida saudável;

VI - ampliar a divulgação, o acesso, o uso e a integração dos serviços de saúde mental;

VII - capacitar comandantes, chefes e diretores a promoverem ações que fomentem a sensibilidade da tropa para identificar subordinados, pares e superiores com sinais, mesmo que discretos, de sofrimento psíquico e/ou com transtorno mental;

VIII - acolher e monitorar o tratamento do policial militar em sofrimento psíquico e/ou com transtorno mental;

IX - realizar ações, em vários níveis de interlocução, para combater o estigma das pessoas com transtornos mentais, incluindo orientação ao efetivo da Corporação sobre sofrimento psíquico e doenças mentais;

X - identificar nos locais de trabalho os fatores promotores do adoecimento mental, mapear os espaços, tipos de atividades que fomentem tais problemas e propor medidas de intervenção no ambiente e na organização do trabalho para mitigar tais efeitos, valorizar o policial militar e diminuir seu sofrimento psíquico;

XI - apoiar as ações e programas de preparação do policial militar para a sua passagem à reserva remunerada.

Seção II

Da Assistência Terapêutica

Art. 4º Entende-se por assistência terapêutica o conjunto de práticas com foco no atendimento às necessidades e expectativas de saúde mental dos policiais militares, assim dispostas:

I - apoiar o atendimento individual do policial militar em sofrimento psíquico e com transtorno mental, orientado para o alívio dos sintomas, identificando e estabelecendo mecanismos eficientes de referências e contrarreferências, com o apoio e a orientação também à família;

II - priorizar a atenção psicossocial por meio de equipe multiprofissional, estimulando a integração e o aprofundamento de saberes e práticas integradas em torno de um conhecimento transdisciplinar;

III - proporcionar, nas unidades integrantes da DAS, o oferecimento de apoio e suporte aos processos terapêuticos dos policiais militares, por meio de atendimentos individuais e/ou coletivos, presenciais ou na modalidade de teleatendimento, promovendo a autonomia e a inserção laboral;

IV - valorizar o atendimento em grupo como espaço de troca de experiências subjetivas e de informações gerais sobre atendimentos médicos e psicológicos, garantindo o sigilo profissional;

V - organizar serviços de acompanhamento psicossocial que atendam demandas espontâneas dos policiais militares, ou quando devidamente encaminhadas, com vistas a intervenções breves e encaminhamento para tratamento;

VI - oferecer serviços de referência propiciadores de vínculos significativos, por meio de projetos terapêuticos que respeitem as especificidades do policial militar e de sua relação com o trabalho;

VII - realizar visitas técnicas às OME, possibilitando maior apoio ao efetivo e entendimento do contexto da saúde mental no serviço policial militar;

VIII - atuar sobre os fatores de risco e proteção associados ao abuso de álcool e outras substâncias; e

IX - incentivar e fortalecer parcerias com universidades e organizações da sociedade civil, em especial aquelas que possuem iniciativas de atenção à saúde mental.

Seção III

Da atuação frente à reabilitação

Art. 5º Entende-se por reabilitação um conjunto de ações e intervenções que visam melhorar a reestruturação da autonomia da pessoa nas suas dimensões física, mental, social e afetiva, integrando-a aos diferentes espaços da sociedade.

Parágrafo único. A reabilitação tem como objetivo diminuir ou eliminar as limitações sofridas pelo policial militar para o exercício de suas atividades laborais e valorizar as capacidades e

competências.

I - estimular a criação de grupos de readaptação, ressocialização, apoio terapêutico e reinserção nos locais de trabalho, conforme a realidade, como forma de lidar com as demandas de reabilitação;

II - propiciar a realização de intervenções terapêuticas não medicalizantes para estabilização de quadros clínicos apresentados pelos policiais militares; e

III - sensibilizar o efetivo da Corporação, em especial comandantes, chefes e diretores, para o acolhimento dos policiais militares no retorno ao trabalho.

Seção IV

Da Informação, da Formação, da Comunicação e da Pesquisa em Saúde Mental

Art. 6º Uma intervenção qualificada no processo saúde e trabalho na PMPE requer:

I - sistema de informação com dados confiáveis;

II - política de comunicação que aborde a complexidade da saúde mental;

III - projeto de formação e capacitação que ajude a ampliar a concepção de saúde mental para além da doença; e

IV - iniciativas de pesquisa em saúde mental cujos estudos produzam conhecimentos importantes relacionados à área de saúde mental no trabalho policial militar.

a) criar e manter atualizados sistemas de informação e de notificação sobre saúde, com indicadores de saúde mental padronizados;

b) registrar a história clínica do policial militar para auxiliar no melhor entendimento das relações entre o adoecimento e a sua atividade laboral;

c) desenvolver indicadores para detecção de ambientes propiciadores de sofrimento psíquico para fins de prevenção e formulação de políticas de recursos humanos que propiciem um ambiente de trabalho mais saudável;

d) garantir o retorno das informações e resultado das pesquisas para os comandantes, chefes, diretores e o efetivo da Corporação de uma forma geral;

e) incentivar e fortalecer parcerias com as universidades e outras instituições de ensino, para apoiar iniciativas de formação e capacitação de policiais na área de saúde mental;

f) dar ampla divulgação das iniciativas voltadas à saúde mental do policial militar, de trabalhos publicados, de relatos de experiências, de dados coletados e de informações produzidas na área de saúde mental; e

g) avaliar periodicamente e incentivar pesquisas e estudos epidemiológicos sobre o impacto das ações de prevenção dos agravos, de promoção da saúde, das intervenções terapêuticas e da reabilitação, avaliando eficiência, eficácia, efetividade e segurança das ações prestadas.

CAPÍTULO III

Disposições Finais

Art. 7º Para os efeitos desta Instrução Normativa são considerados como público-alvo das iniciativas, ações e projetos desenvolvidos pelo Núcleo de Saúde Mental TC PM ALINE MARIA LOPES DOS PRAZERES LUNA, os policiais militares, ativos e veteranos da PMPE.

Art. 8º Os casos omissos serão tratados em deliberações feitas entre o Comandante-Geral da Corporação e os Diretores de Saúde e de Assistência Social.

Art. 9º Esta Instrução Normativa entrará em vigor na data da sua publicação. Tibério César dos Santos Cel QOPM - Comandante Geral. (SEI nº 3900000015.000969/2023-14).

3ª PARTE

III – Normas Externas

(Sem Alteração)

ROMILDO RODRIGUES DE LIMA - Cel QOPM
Ajudante Geral



Documento assinado eletronicamente por **Romildo Rodrigues de Lima**, em 19/04/2023, às 10:28, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do [Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.pe.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **35462581** e o código CRC **1DF4C954**.

QUARTEL DO COMANDO GERAL DA PMPE

Praça do Derby s/nº, Derby, Recife-PE CEP 52.010-140 Fones (081) 3181-1320, Fax 3181-1002,
E-mail acg.pm@pm.pe.gov.br

“Nossa presença, sua Segurança!”

6.0.0. PORTARIAS DO COMANDO-GERAL**Nº 300, de 17 de Junho de 2024**

EMENTA: Institui o Programa “Tamo Junto” - TMJ no âmbito da Polícia Militar de Pernambuco

O Comando-Geral, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo art. 101, I, II, III e IV do Decreto nº 17.589, de 16 de junho de 1994, que aprovou o Regulamento Geral da Polícia Militar de Pernambuco.

R E S O L V E:

I - Instituir o Programa “Tamo Junto” - TMJ no âmbito da Polícia Militar de Pernambuco como um conjunto de ações dentro do Programa de Saúde Mental da Corporação, voltadas à identificação, acolhimento e encaminhamento das demandas de saúde mental e sofrimento psíquico dos policiais militares pernambucanos.

II – Definir que o Policial Militar integrante do “Tamo Junto” – TMJ é denominado Focal e compreende o militar identificado como sendo portador de habilidade, voluntariedade e disponibilidade para atuar como elo entre o NSM PMPE e a sua OME, atuando no acolhimento do efetivo, divulgando as diretrizes de saúde mental vigentes na Corporação e os canais de atendimento, sendo multiplicador da cultura de aproximação e cuidado entre os policiais militares pernambucanos.

III – Definir como critérios para atuação do Policial Militar Focal do “Tamo Junto” - TMJ:

1. Ser praça do serviço ativo na Corporação;
2. Ser voluntário para o exercício do encargo;
3. Preferencialmente, fazer parte do efetivo do expediente administrativo da OME;
4. Ter bom relacionamento interpessoal;
5. Não ter histórico de faltas disciplinares nos últimos 5 anos;
6. Apresentar habilidades no trato com as pessoas;
7. Apresentar discrição em relação aos assuntos pessoais que lhe chegam ao conhecimento.

IV – Definir as atribuições do Policial Militar Focal do “Tamo Junto” - TMJ:

1. Coletar e remeter mensalmente, conforme orientado pelo NSM PMPE, as informações solicitadas no formulário de acompanhamento da sua unidade.

2. Divulgar junto ao efetivo da sua unidade as ações e iniciativas de saúde mental emanadas do NSM PMPE.

3. Assessorar o Comando/ Chefia da sua unidade na identificação e possíveis encaminhamentos das demandas relacionadas à saúde mental.

4. Comparecer as reuniões, treinamentos e capacitações do NSM PMPE sempre que convocado.

5. Contactar o NSM PMPE sempre que necessário para propor ações e intervenções necessárias à sua unidade, esclarecer dúvidas ou compartilhar informações que julgue necessárias.

6. Zelar pelo tratamento humanizado, pela discrição, respeito, dignidade e sigilo das informações a que tiver acesso por ocasião da sua atuação como focal ou em qualquer outra circunstância.

7. Salvar os dados de saúde mental da sua unidade a que tiver acesso abstendo-se de compartilhá-los ou utilizá-los para qualquer fim que não seja os orientados pelo chefe do NSM PMPE.

8. Informar ao chefe do NSM PMPE quaisquer circunstâncias que o impeçam de exercer as atividades de focal, ainda que temporariamente, tais como férias, afastamentos e transferências.

9. Conhecer e pautar suas ações nas Diretrizes de Saúde Mental da Corporação.

10. Buscar orientação junto ao Chefe do NSM PMPE sobre quaisquer circunstâncias não descritas nestas atribuições.

V – Determinar que a designação dos Policiais Militares Focais do TMJ deve ser renovada anualmente com publicação em Boletim Geral da Corporação.

VI – Determinar que os afastamentos dos Policiais Militares Focais do TMJ por motivo de transferências, reformas e outros devem ser informados ao Chefe do Núcleo de Saúde Mental, através de Ofício ao Diretor de Assistência Social.

VII – Determinar aos Comandantes de OME que não tiverem Policiais Militares Focais do Programa TMJ designados em Portaria do Comando Geral, que remetam os dados dos indicados ao Chefe do Núcleo de Saúde Mental, através de Ofício ao Diretor de Assistência Social.

VIII - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

IX - Cumpra-se. Ivanildo Cesar Torres de Medeiros – Cel PM Comandante-Geral. (SEI nº 3900000015.003508/2024-76).

--oo(0)oo--

Nº 301, de 17 de Junho de 2024

Ementa: Designa Policiais Militares Focais do Programa Tamo Junto - TMJ

O Comando-Geral, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo art. 101, I,II, III e IV do Decreto no 17.589, de 16 de junho de 1994, que aprovou o Regulamento Geral da Polícia Militar de Pernambuco.

R E S O L V E:

I- Designar os Policiais Militares abaixo relacionados para atuarem como Focais do Programa Tamo Junto – TMJ no âmbito da Polícia Militar de Pernambuco, através do Núcleo de Saúde Mental Ten Cel PM Aline Maria Lopes dos Prazeres de Luna – NSM PMPE, pelo período de um ano em suas respectivas OME.

ORD.	GRAD.	MATRÍCULA	NOME	UNIDADE
DGA				
1	3ºSGT	1067370	SANDRA MARIA DA SILVA	AG
2	SD	1200771	VILSON AVELINO DE ALMEIDA	AG
3	1º SGT	1079638	ALEXSANDRO RODRIGUES CUNHA	CPM
4	3º SGT	1077422	JONAS DOS SANTOS NASCIMENTO JÚNIOR	CPM
5	CB	1159038	MICHELLE FERREIRA BORGES DA SILVA DE OLIVEIRA	CREED
6	CB	1172425	GISÉLIA GUIMARÃES SINFRÔNIO	CREED
7	3ºSGT	1044982	ÍTALO PROTÁSIO DE LIMA	DGP
8	3ºSGT	1093177	MARCELO AUGUSTO RODRIGUES ALVES	DGP

DPO				
1	CB	1157205	VANESSA CAMPELO VIRGÍNIO DA SILVA	DASDH
2	CB	1161148	NATHÁLIA REGINA DA SILVA	DASDH

DIM				
1	ST	1046446	PAULA CRUZ BONFIM	11º BPM
2	3º SGT	1105604	LILIAM BARROS DE OLIVEIRA	11º BPM
3	1º SGT	9302697	JOHANN BUTLER DA SILVA BATISTA	12º BPM
4	3º SGT	1091557	CAROLINA PEDROSA SOUZA	12º BPM
5	CB	1157264	RANDERSON BELARMINO DA SILVA	13º BPM
6	CB	1199900	SHIRLEY ELEOTERIO MARTINS	13ºBPM
7	CB	1197282	TEOTÔNIO FELIPE SOUZA LEÃO DE LIRA	18º BPM
8	SD	1254375	MARILIA EDUARDA PEREIRA MACHADO	18º BPM
9	3º SGT	1073079	MÁXIMO CORREIA DE LIMA	19ºBPM
10	SD	1262262	MAYARA MARTINS SOARES DE ARRUDA	19º BPM
11	1º SGT	9803530	IVSON FÉLIX LEAL	1º BPM
12	3º SGT	1087894	IRENE CRISTINA CAMPOS E COSTA	1º BPM
13	3º SGT	1088220	VANESSA FRANÇA DA SILVA	20º BPM
14	CB	1157833	KÁSSIO NUNES INÁCIO OLIVEIRA	20º BPM
15	ST	1056700	ZUDUENDEN QUEIROZ DE ALMEIDA BEZERRA	25º BPM
16	2º SGT	1029592	VICENTE HENRIQUE DA CRUZ JÚNIOR	25ºBPM
17	ST	9803866	JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA	26º BPM
18	3º SGT	1090518	ROBERTO FRANCISCO DE OLIVEIRA	26º BPM
19	CB	1160540	MIRELLI MORGANA PESSOA CASÉ	6º BPM

DINTER 1				
1	3º SGT	1069705	MARCELO JOSÉ TEOTONIO	10ª CIPM



POLÍCIA MILITAR DE PERNAMBUCO
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
NÚCLEO DE SAÚDE MENTAL



MANUAL DO POLICIAL FOCAL



NSM PMPE

Criado através da Portaria do Comando Geral Nº 562, de 23 de março de 2023 e oficialmente inaugurado no dia 27 de março do mesmo ano, o Núcleo de Saúde Mental da Polícia Militar de Pernambuco está subordinado à Diretoria de Assistência Social e tem como objetivo realizar a gestão da Política Pública de Saúde Mental da Corporação, assim como planejar, executar e monitorar intervenções, ações e projetos específicos voltados à promoção, prevenção e assistência em saúde mental, melhorando os níveis de qualidade de vida e saúde emocional dos Policiais Militares ativos e veteranos no âmbito da Corporação.

Entendendo que a atividade policial militar carrega consigo fatores estressores que, somados às demandas da vida privada, têm elevado potencial de causar distúrbios psicológicos e afetar de forma geral a saúde biopsicossocial do policial militar, o Núcleo de Saúde Mental PMPE, dentro das Doutrinas de Saúde Mental estabelecidas na Corporação, através da Instrução Normativa 564, de 03 de abril de 2023, atua na gestão da promoção, prevenção e assistência em Saúde Mental no âmbito da PMPE.

O NSM PMPE, denominado Núcleo de Saúde Mental TC PM Aline Maria Lopes dos Prazeres de Luna, em homenagem à Oficial Combatente e Psicóloga que se tornou símbolo da causa da saúde mental na Corporação, tem sua sede na Rua Coronel Silva Torres, 73, no bairro do Derby, Recife-PE.



NÚCLEO DE SAÚDE MENTAL TEN CEL PM ALINE MARIA LOPES DOS PRAZERES DE LUNA

Ementa: Cria Núcleo de Saúde Mental da Polícia Militar de Pernambuco “NÚCLEO DE SAÚDE MENTAL TEN CEL PM ALINE MARIA LOPES DOS PRAZERES DE LUNA”.

https://www.pm.pe.gov.br/wp-content/uploads/2023/06/SEI_GOVPE-34662421-PMPE-SUNOR-Nucleo-SM.pdf

São funções do NSM PMPE:

1. Planejar e implementar apoio contínuo às unidades operacionais e administrativas, através de visitas itinerantes de equipes de saúde biopsicossocial, plantões psicológicos, palestras e outras ações pontuais, conforme necessidade e cronograma estabelecidos pela DAS;
2. Recepcionar demandas relativas à pauta de Saúde Mental e Qualidade de Vida advindas da Secretaria de Defesa Social;
4. Assessorar tecnicamente o Comandante Geral da Corporação em relação à Saúde Mental e Qualidade de Vida do efetivo, através do Diretor de Assistência Social.

Acesse o SUNOR de criação do NSM PMPE no link no início desta página ou através do QR-CODE abaixo.



IMPORTÂNCIA DO NSM PMPE

1. Diagnosticar comportamentos suicidas e intervir em favor da vida;
2. Atenção aos sinais de adoecimentos;
3. Dar suporte ao policial militar em suas demandas relacionadas aos desafios da vida policial;
4. Lugar de acolhimento, valorizando a tomada de decisão por buscar ajuda psicológica como um importante passo do processo de elaboração da experiência;
5. Ser um agente de mudança social, promovendo uma melhor qualidade de vida para o policial militar, conseqüentemente para a sociedade, família e os espaços nos quais esse agente está inserido;
6. Acolher o policial no momento da angústia, em que algo peculiar emerge;
7. Permitir ao policial falar de SI e ser ESCUTADO, sem julgamentos, sem rótulos.

COMO BUSCAR AJUDA DO NSM PMPE?

*Busca Voluntária
(presencialmente ou através de ligação telefônica);
Encaminhamento
(SEI pelo comandante da OME)*



O POLICIAL MILITAR FOCAL

QUEM É O FOCAL DA OME?

O Focal é o policial militar identificado como portador de perfil adequado para atuar como elo do Núcleo de Saúde Mental PMPE com a sua OME. Sua função tem importância fundamental no alcance das ações da política de saúde mental da Corporação.

O policial militar focal deve sempre pautar todas as suas ações nos princípios do respeito, discrição e sigilo das informações das pessoas a que tiver acesso.

São atribuições do policial militar focal da OME:

1. Coletar e remeter mensalmente, conforme orientado pelo NSM PMPE, as informações solicitadas no formulário de acompanhamento da sua unidade.
2. Divulgar junto ao efetivo da sua unidade as ações e iniciativas de saúde mental emanadas do NSM PMPE.
3. Assessorar o Comando / Chefia da sua unidade na identificação e possíveis encaminhamentos das demandas relacionadas à saúde mental.
4. Comparecer às reuniões, treinamentos e capacitações do NSM PMPE sempre que convocado.



5. Contactar o NSM PMPE sempre que necessário para propor ações e intervenções necessárias à sua unidade, esclarecer dúvidas ou compartilhar informações que julgue necessárias.
6. Zelar pelo tratamento humanizado, pela descrição, respeito, dignidade e sigilo das informações a que tiver acesso por ocasião da sua atuação como focal ou em qualquer outra circunstância.
7. Salvar os dados de saúde mental da sua unidade a que tiver acesso abstendo-se de compartilhá-los ou utilizá-los para qualquer fim que não seja os orientados pelo Chefe do NSM PMPE.
8. Informar ao Chefe do NSM PMPE quaisquer circunstâncias que o impeçam de exercer as atividades de focal, ainda que temporariamente, tais como férias, afastamentos e transferências.
9. Conhecer e pautar suas ações nas Diretrizes de Saúde Mental da Corporação.
10. Buscar orientação junto ao Chefe do NSM PMPE sobre quaisquer circunstâncias não descritas nestas atribuições.

**DIRETRIZES DE SAÚDE MENTAL DA
POLÍCIA MILITAR DE PERNAMBUCO**

SUNOR 017 DE 19ABR2023 Ementa: Institui princípios, diretrizes e ações a serem adotados pelo efetivo da PMPE, em âmbito interno da Corporação, sobre saúde mental.



SAÚDE MENTAL UMA MISSÃO DE TODOS NÓS

*Focal, você é muito importante para
que os cuidados em saúde mental
alcancem todos os policiais militares
pernambucanos!*



Policiais mortos em 2023: suicídios superam mortes em confronto

No último Anuário abrimos o texto sobre mortes de policiais dizendo que os números em 2022 mostravam o que já observávamos nos anos anteriores: que policiais morriam mais em confronto na folga, depois por suicídio e, por último, por confronto em serviço. Os números referentes a 2023 apontam, pela primeira vez desde que o FBSP passou a coletar dados sobre vitimização de policiais¹, que o que mais matou policiais militares no ano passado foi o auto-extermínio. PMs morreram mais por suicídio do que por confronto na folga e por confronto em serviço.

O ano de 2023 registrou, em relação ao ano anterior, **queda de 18,1% na taxa de policiais civis e militares vítimas de CVLIs** (Crimes Violentos Letais e Intencionais) no Brasil, enquanto **a taxa de suicídios** de policiais civis e militares da ativa **cresceu 26,2%** no mesmo período no país.

Considerando apenas a Polícia Militar, o total nacional de suicídios nas corporações superou, em 2023, a soma dos registros de PMs mortos em confronto em serviço e fora de serviço. Foram 110 registros de suicídios, ante 46 casos de PMs mortos em confronto em serviço e 61 mortos em confronto ou por lesão não natural fora de serviço – 107 óbitos ao todo.

No caso dos suicídios, somados dados das polícias Civil e Militar, houve aumento importante dos registros nos Estados de São Paulo (80%) e Rio de Janeiro (116,7%), detentores dos maiores efetivos das duas corporações. Olhando apenas para os números de mortes de policiais militares, a situação é muito grave: no Acre, Amapá, Ceará, Espírito Santo, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo, os policiais militares morreram mais por suicídio em 2023 do que por confronto na folga ou em serviço.

São Paulo informou 31 casos de suicídio de PMs da ativa no ano passado, ante 19 em 2022. O Estado não forneceu registros de suicídio de policiais civis para 2023. No Rio de

Juliana Lemes

Doutora em Política Social pela UFF, Conselheira do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e Cabo da Polícia Militar de Minas Gerais.

Juliana Martins

Psicóloga, Doutora pelo Instituto de Psicologia da USP e Coordenadora Institucional do Fórum Brasileiro de Segurança Pública.

¹ Dados de homicídios de policiais aparecem pela primeira vez no 7º Anuário, em 2013, e o de suicídio no 8º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, em 2014.

Janeiro, foram 13 suicídios de PMs da ativa em 2023, contra 5 em 2022 – segundo os dados oficiais, não houve casos na Polícia Civil no ano passado.

POLICIAIS MORTOS EM SERVIÇO

Em âmbito nacional houve aumento nas mortes em confronto em serviço de policiais civis (8 em 2023 ante 4 em 2022) e de policiais militares (46 ante 39), enquanto as mortes em confronto ou por lesão não natural fora de serviço apresentaram queda, 12 em 2023 contra 20 em 2022 para policiais civis e 61 em 2023 ante 92 em 2022 entre policiais militares.

O movimento de crescimento nas mortes de policiais em confronto não se verificou no caso do Rio de Janeiro, que apresentou queda nas mortes de policiais civis e militares em confronto em serviço (0 em 2023 ante 2 em 2022, no caso da Polícia Civil, e 11 ante 17 para a Polícia Militar entre os períodos). O Estado não forneceu números de policiais civis e militares vítimas de CVLI fora de serviço.

São Paulo registrou alta no número de policiais mortos em confronto em serviço em 2023. Dentre policiais civis, foram 3 casos, contra 1 em 2022 e entre os policiais militares, 9 casos, contra 6 em 2022.

POLICIAIS MORTOS FORA DE SERVIÇO

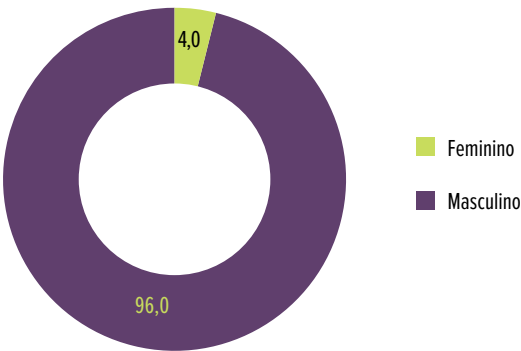
Em relação às mortes de policiais fora de serviço, por confronto ou por lesão não natural, em São Paulo houve queda nos números para as duas corporações (4 casos em 2023 contra 7 em 2022 para a PC, e 12 em 2023 contra 19 em 2022 para a PM).

Destaca-se que, a nível de Brasil, os números totais de policiais civis e militares vítimas de CVLIs em 2023 apresentaram crescimento em relação ao ano anterior em Mato Grosso (200%), no Amazonas (100%), no Paraná (100%), no Maranhão (66,7%), no Pará (17,6%) e no Ceará (12,5%).

Houve redução no Amapá (-100%), no Espírito Santo (-100%), em Roraima (-100%), em Santa Catarina (-100%), no Tocantins (-100%), na Paraíba (-66,7%), no Piauí (-60%), no Rio Grande do Norte (-50%), em Rondônia (-50%), no Rio de Janeiro (-42,1%), em Goiás (-40%), em São Paulo (-15,2%) e em Pernambuco (-7,7%).

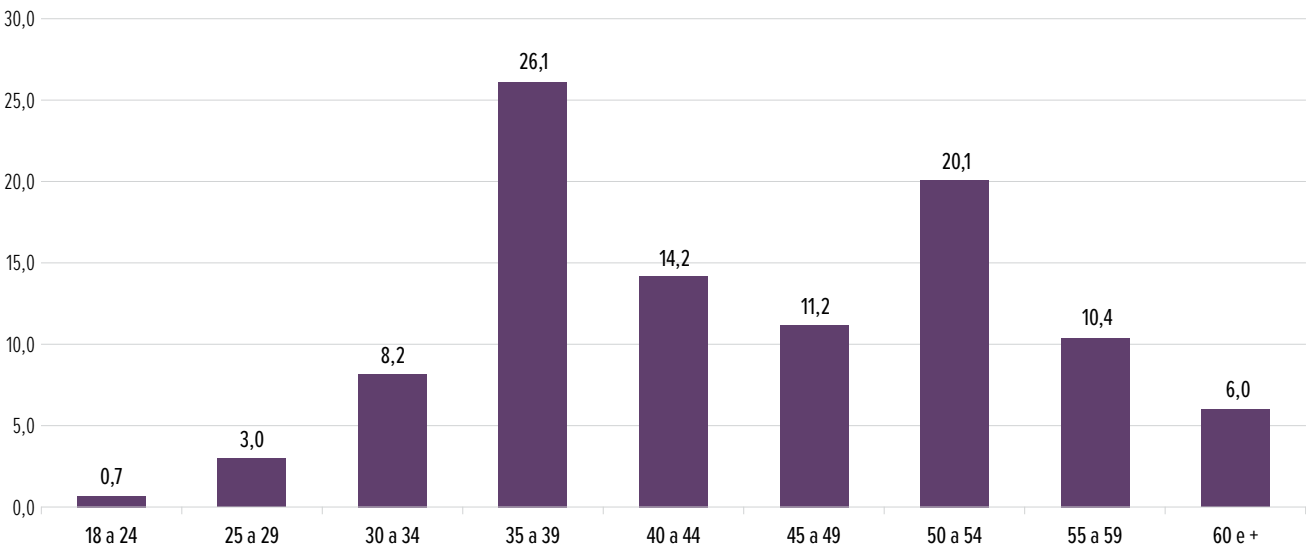
Em relação ao sexo, raça/cor e faixa-etária dos policiais vítimas de CVLI, mantém-se o perfil observado nos anos anteriores: morreram mais homens (96%), negros (69,7%) com faixa etária entre 35 e 54 anos (71,6%).

GRÁFICO 08
Mortes Violentas Intencionais de Policiais Cíveis e Militares, por sexo (em %)
Brasil, 2023



Fonte: Análise produzida a partir dos microdados dos registros policiais e das Secretarias estaduais de Segurança Pública e/ou Defesa Social. Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 2024.

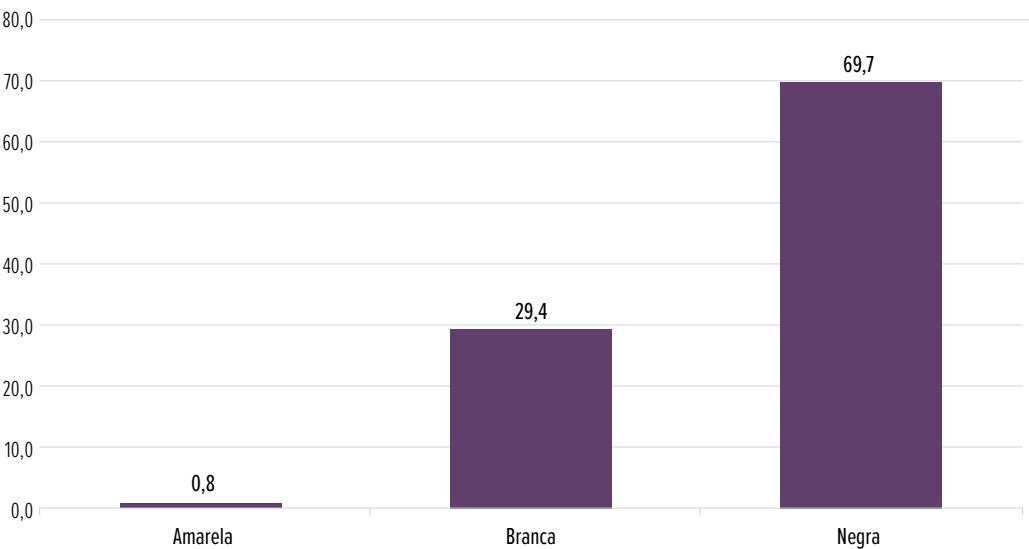
GRÁFICO 09
Mortes Violentas Intencionais de Policiais Cíveis e Militares, por faixa etária (em %)
Brasil, 2023



Fonte: Análise produzida a partir dos microdados dos registros policiais e das Secretarias estaduais de Segurança Pública e/ou Defesa Social. Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 2024.

GRÁFICO 10

Mortes Violentas Intencionais de Policiais Cíveis e Militares, por raça/cor (em %)
Brasil, 2023



Fonte: Análise produzida a partir dos microdados dos registros policiais e das Secretarias estaduais de Segurança Pública e/ou Defesa Social. Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 2024.

A VITIMIZAÇÃO POR SUICÍDIO

Mais de 700 mil pessoas morrem por suicídio todos os anos, sendo essa a quarta principal causa de morte de jovens entre 15 e 29 anos.

Dados da Organização Mundial da Saúde nos mostram que mais de 700 mil pessoas morrem por suicídio todos os anos, sendo essa a quarta principal causa de morte de jovens entre 15 e 29 anos². Apesar de observarmos uma redução de 36% no número de suicídios no mundo entre 2000 e 2019, nas Américas o caminho foi inverso: houve um aumento de 17% no continente sendo que o Brasil apresentou um dos crescimentos mais significativos: 43% entre 2010 e 2019³. Estudo desenvolvido pelo Centro de Integração de Dados e Conhecimentos para Saúde (Cidacs/Fiocruz Bahia), em colaboração com pesquisadores de Harvard⁴ e lançado em março deste ano, mostram que a taxa de suicídio entre jovens cresceu 6% ao ano no Brasil entre os anos de 2011 e 2022. As taxas de notificações por autolesões na faixa etária de 10 a 24 aumentaram 29% a cada ano nesse mesmo período. O número foi maior que na população em geral, cuja taxa de suicídio teve crescimento médio de 3,7% ao ano e a de autolesão 21% ao ano, no mesmo período.

2 <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/suicide>
3 Brasil, Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde. Mortalidade por suicídio e notificações de lesões autoprovocadas no Brasil. Bol Epidemiol (Rio J). 202
4 The rising trends of self-harm in Brazil: an ecological analysis of notifications, hospitalisations, and mortality between 2011 and 2022 anThe rising trends of self-harm in Brazil: an ecological analysis of notifications, hospitalisations, and mortality between 2011 and 2022

A alta exposição ao estresse e ao trauma foram observados em relatório⁵ sobre suicídio de policiais dos Estados Unidos, evidenciando os fatores ocupacionais como condicionantes importantes. Em 2023, no Brasil, assim como nos Estados Unidos, os casos de suicídio destacaram-se na questão da vitimização policial, conforme revelado pelos dados do FBSP.

Estudo desenvolvido junto de policiais norte-americanos concluiu que o estresse rotineiro no ambiente de trabalho constitui elemento fortemente associado aos sintomas do Transtorno de Estresse Pós-Traumático (TEPT)⁶. Os impactos produzidos pelo TEPT, que, dentre outros fatores, se complexifica pelos cronogramas de trabalho desafiadores e pelos consequentes distúrbios relacionados ao sono, vão além daqueles decorrentes de incidentes críticos causados em razão da natureza arriscada da profissão⁷.

Os dados de suicídio trazidos agora pelo Anuário Brasileiro de Segurança Pública nos mostram o quanto estamos falhando em proteger a vida do policial, especialmente do policial militar. Há tempos, o FBSP aborda a saúde mental dos policiais através de iniciativas como a editoria “Setembro Amarelo” do Fonte Segura⁸, que transcende a limitação temporal do mês de setembro, período mundial de prevenção ao suicídio. Trazendo reflexões e análises de profissionais de diversas áreas, especialmente de policiais, alertando sobre esse grave problema. Desde que começamos a tratar do tema nos Anuários chamamos a atenção para o fato da subnotificação desses registros, uma vez que há muito tabu em torno do tema, especialmente nas instituições de segurança pública.

Os dados de suicídio trazidos agora pelo Anuário Brasileiro de Segurança Pública nos mostram o quanto estamos falhando em proteger a vida do policial, especialmente do policial militar.

Não é raro, a exemplo do que vemos em São Paulo⁹, que, quando um policial militar morre em confronto em serviço, a instituição adote verdadeiras operações vingança, que se desdobram em uma caçada ao criminoso que matou o policial. Mas e agora que a maior causa das mortes é o suicídio, o que fazer? Que operações serão realizadas para honrar esses policiais? Quem é o inimigo, se o que adoce o policial é a própria polícia?¹⁰ Será que de uma vez por todas os governos vão mostrar, através de ações, programas concretos e mudanças na cultura organizacional que, de fato, a vida do policial importa?

Mesmo com uma melhora ao longo dos anos, os dados de vitimização ainda são precários e carecem de muita melhora. Sabemos que o suicídio ainda é um tabu e que possivelmente estamos lidando com uma subnotificação dos casos. Nesse sentido, nos

5 <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3974929/>

6 <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3974929/>

7 <https://www.vox.com/first-person/2019/6/25/18701253/police-suicide-mental-health-emt-firefighters-first-responders>

8 <https://fontesegura.forumseguranca.org.br/editorias/setembro-amarelo/>

9 <https://g1.globo.com/sp/santos-regiao/noticia/2024/03/16/operacao-verao-e-607percent-mais-letal-do-que-operacao-escudo-no-litoral-de-sp.ghtml>

10 <https://fontesegura.forumseguranca.org.br/a-ainda-alarante-quantidade-de-suicidios-de-policiais/>

Nos parece que um passo importante seria investir na melhora da notificação dos casos de suicídio e na visibilidade dos números e características do fenômeno no intuito de contribuir para a criação de estratégias de prevenção. Sem expor, obviamente, vítimas e familiares, essas informações ajudam a entender qual a proporção do problema.

parece que um passo importante seria investir na melhora da notificação desses casos e na visibilidade dos números e características do fenômeno no intuito de contribuir para a criação de estratégias de prevenção. Os EUA tem, desde 2020, o Law Enforcement Suicide Data Collection Act que determina que o FBI colete informações sobre suicídios e tentativas de suicídio no que se refere a circunstâncias, meio empregado, informações demográficas, local e categoria profissional dos casos de suicídio. Sem expor, obviamente, vítimas e familiares, essas informações ajudam a entender qual a proporção do problema.

Chamamos a atenção, no ano passado, para a importância do registro e compartilhamento dessas informações, porque o fato do número de mortos por suicídio não ser divulgado não significa que o problema não exista. Um exemplo disso foi o caso da Polícia Militar de Minas Gerais, que nos anos anteriores, colocava suicídios como “fenômeno inexistente”, decorrente de um decreto institucional de sigilo sobre essas informações. O silêncio em nada contribui para que comecemos a apresentar soluções e estratégias de enfrentamento a uma questão que, como sabemos, por conta justamente da divulgação dessas informações, é comum a todas as polícias. A PMMG, após o sigilo dos últimos anos, retificou os dados do ano passado, compartilhando os números de policiais que morreram por suicídio. Este foi um passo importante para o enfrentamento e prevenção das mortes de policiais por autoextermínio.

Jogar luz sobre o que nos revelaram os números sobre as mortes de policiais em 2023 representa o desafio de desconstruir certezas, implementar novos conceitos e uma nova consciência sobre a importância de incluir, no debate sobre a Segurança Pública do país, estratégias que dialoguem estreitamente com o conjunto de policiais mais vulneráveis ao adoecimento em razão da exposição rotineira ao estresse no ambiente de trabalho.

Na edição anterior do Anuário, quando as mortes de policiais em confronto ou por lesão intencional provocada por terceiro fora de serviço foram mais recorrentes do que as mortes em serviço ou por suicídio, destacamos o nível de responsabilidade do Estado frente àquela realidade. No caso, as múltiplas circunstâncias de ocorrência das mortes de policiais “fora de serviço” autoriza dúvidas a respeito do rumo conclusivo da análise sobre a razão central do sinistro, apontando duas principais interpretações: **a) particular**, quando há a individualização do caso, como se a situação fosse isolada e em razão da conduta individual adotada pelo(a) policial, que pode ter criado as condições determinantes para o confronto que resultou em sua morte – como exemplo, casos em que policiais, ao exercerem funções associadas à segurança privada, os chamados “bicos”, são vitimados durante confronto com terceiros, na ocasião da condição laboral irregular que, normalmente, tem por finalidade a complementação da própria renda; **b) pública**, quando se compreende a morte do policial fora de serviço como diretamente relacionada à natureza

do trabalho do agente. Assim, o problema demanda, claramente, resposta institucional no sentido de prevenir baixas desses profissionais que, pelo cumprimento rotineiro do dever, são vitimados em virtude de terem se deparado com a ocorrência de um crime ou mesmo por vingança de terceiros.

Ao passo que as mortes de policiais em confronto ou por lesão intencional provocada por terceiro fora de serviço, ou mesmo mortos em confronto em serviço, têm relação direta com a natureza da função do profissional de segurança pública, as mortes policiais em razão de autoexterminio/suicídio têm conotação diversa e imbricada ao campo da saúde pública.

Em geral, os cursos de formação e os treinamentos dos profissionais de segurança pública são orientados à construção da identidade policial, na medida que massificam e reproduzem conceitos e práticas alinhadas à ideia de policial preparado o suficiente para lidar, resistir e enfrentar toda e qualquer condição externa, seja qual for o nível de risco e/ou complexidade. Mesmo que parte de uma mesma classe/categoria, policiais são representativos da pluralidade dos indivíduos, que, paradoxalmente, adaptam-se ao engessamento de suas respectivas instituições. Nesse caminho, ao assumirem o compromisso no desempenho das funções de resolução de problemas de segurança pública, os policiais acabam sendo levados a acreditar que precisam abrir mão de suas necessidades individuais em prol do espírito institucionalmente construído de coletividade policial.

A cristalização da ideia de “policial herói”, comumente nomeado de “superior ao tempo”, diz respeito à produção, no imaginário, tanto popular quanto profissional, de que antes de “ser ou estar”, um policial precisa “parecer ser ou parecer estar” investido de habilidades incríveis. Simbolicamente, um servidor público incomum, distinto por sua autoridade e destreza, sabidamente demandado pela envergadura de sua função, representa um perfil profissional desautorizado a demonstrar fraqueza, cansaço ou esgotamento laboral. Assim, a cultura de naturalização de situações estressantes, à medida que fortalece o tabu que envolve o assunto da saúde mental policial, pode favorecer a invisibilidade do trauma, oportunizando o aprofundamento dos sintomas do adoecimento mental dos policiais. Uma vez que a ausência de identificação do problema impede seu reconhecimento pelo indivíduo ou por parte de terceiros, a necessária busca por ajuda e tratamento adequado são desconsiderados.

Os dados sobre as mortes autoprovocadas por policiais no ano de 2023 revelam a urgência de formulação de políticas voltadas a esse público. Afinal, no desenvolvimento da análise, a presença dos números ou a ausência deles sempre diz algo sobre a realidade investigada. No caso dos suicídios de policiais, a situação parece ainda mais complexa porque envolve tensionamentos resultantes do ambiente de trabalho que afetam, não apenas a individualidade em si, mas o coletivo da categoria.

A cultura de naturalização de situações estressantes, à medida que fortalece o tabu que envolve o assunto da saúde mental policial, pode favorecer a invisibilidade do trauma, oportunizando o aprofundamento dos sintomas do adoecimento mental dos policiais.

Majoritariamente, a segurança pública é ocupada por pessoas do gênero masculino. Logo, são trabalhadores formados como sujeitos de limitada ou nenhuma identificação com a tarefa do cuidado - seja de si ou de outrem -, por ser a atividade socialmente associada ao gênero feminino. Por um lado, a ideia de cuidado atribui ao indivíduo a responsabilidade pela identificação e busca por tratamento - autocuidado. Por outro, tende a desobrigar o Estado do investimento em **políticas de prevenção** do adoecimento e, principalmente, das mortes autoprovocadas de policiais, deixando de reconhecê-las como recados individuais de que o coletivo não vai bem.

FATORES CAPAZES DE PROTEGER OS QUE PROTEGEM

O Escuta SUSP, programa do Ministério da Justiça e Segurança Pública, nos parece uma iniciativa importante frente à falta de oferta adequada de serviços de atendimento.

O Escuta SUSP, programa do Ministério da Justiça e Segurança Pública, nos parece uma iniciativa importante frente à falta de oferta adequada de serviços de atendimento - só aumentar o número de profissionais atendendo, obviamente, não é suficiente se as práticas que produzem sofrimento e adoecimento não forem revistas. Mas ter um programa federal ouvindo esses profissionais é uma estratégia que pode ajudar muito os policiais de todo o Brasil.

Mas nada disso dará frutos se os gestores não estiverem capacitados e sensibilizados para essa temática. Portanto, dois fatores que se complementam parecem fundamentais para a mudança do presente cenário. Trata-se da combinação entre a necessária reorientação na forma de gestão dos recursos humanos por parte das instituições a partir do reconhecimento de que a formulação de políticas destinadas à melhoria da qualidade de vida dos profissionais é condição para a melhoria da prestação de serviços em segurança pública para toda a população.

Destaca-se, assim, **a urgência da tomada de consciência dos gestores institucionais**, que, em regra, atuam nos limites dos respectivos recortes estratégicos e distanciados do universo profissional de base. Condição que dificulta o acesso das camadas superiores alinhadas à gestão, à realidade da massa dos policiais em atividade de ponta de linha - aqueles mais afetados pelo estresse crônico rotineiro relacionado ao ambiente de trabalho. Logo, se o topo conhece, mas não compreende as demandas da base, a gestão se torna incapaz de formular respostas que deem conta de fazer frente aos problemas do coletivo policial. O que, em curto e médio prazos, reflete na qualidade dos serviços prestados à população.

Nessa direção, como resposta ao conjunto de demandas nesse campo, **a formulação de políticas inovadoras voltadas à garantia dos direitos humanos dos profissionais da segurança pública**, no âmbito tanto dos governos quanto das instituições, com foco na melhoria da qualidade de vida dos policiais e envolvendo, fundamentalmente, o cuidado continuado com a saúde mental individual e coletiva, condições dignas de trabalho e valorização salarial.

1 Suicidologia

Afinal, o que é o suicídio? Esse é um questionamento de extrema importância, pois os números de suicídios são subnotificados na maioria dos países do mundo, uma vez que os sistemas de notificação não são perfeitos, bem como as investigações de causas relacionadas são precárias em muitos países.

Entretanto, o entendimento do que seja realmente o suicídio é um dos sérios obstáculos em relação às notificações. Como o tema ainda é um tabu, o suicídio é um assunto que traz também sentimento de culpa e de vergonha para certas famílias e ainda não foi elevado a um nível de diálogo maduro para muitas pessoas. A conceituação do que seja o suicídio gera dúvidas na hora da notificação.

1.1 Filosofia e Literatura

De forma científica ou prática, ao se estudar o suicídio, é relevante entender que ele é objeto de estudo de inúmeras áreas do conhecimento.

Para Albert Camus, escritor francês ganhador do prêmio Nobel de literatura, no livro "O mito de Sísifo", (CAMUS, [1942] 2014, p. 19), ele suscita o questionamento: "Só existe um pensamento filosófico realmente sério: o suicídio.

Julgar se a vida vale ou não a pena ser vivida é responder à questão principal da filosofia."

Ao discutir a supracitada pergunta filosófica, Camus continua em seus pensamentos críticos a desenvolver raciocínios lógicos que levam o leitor a entender que filosofar sobre viver ou morrer é importante. A pergunta shakespeariana "to be or not to be, that's the question", "ser ou não ser, eis a questão" tem muito a ver com esse questionamento. Ser ou não ser pode ser interpretado como decidir viver ou decidir morrer.

Assim, quando Camus diz que essa é a principal pergunta, que essa é a questão principal da Filosofia, Shakespeare e Camus entram em consenso quanto à relevância acerca do suicídio face à vida. Utilizando suas obras literárias, eles, mesmo depois de mortos, alcançam milhares de leitores em todo o mundo e em inúmeras gerações que os sucederam, isso porque a pergunta filosófica sobre decisão sobre a vida ou a morte voluntária continua a ecoar e reverberar ao longo dos anos.

No livro, *História do Suicídio*, outro francês, o escritor Georges Minois, inicia sua obra com uma epígrafe que cita exatamente essa passagem da obra shakespereana. De fato, como será visto nesta obra, o desejo de vida e de morte perpassa pelo ser humano, pois este tem a mente, o raciocínio, o refletir para determinar suas decisões.

Aproveitando o dilema de Shakespeare, citamos que a **ambivalência**, dois valores, o de morrer ou o de viver, é uma palavra de suma importância no estudo do suicídio.

Segundo o psicólogo norte americano, Edwin S. Shneidman, conhecido por muitos leitores e estudiosos deste tema com o Pai da Suicidologia, a ciência que estuda

os suicídios, a ambivalência é um dos aspectos comuns da crise suicida.

Ao listar alguns desses aspectos comuns sobre o suicídio, em seu livro *The Suicidal Mind- A mente suicida* - (SHNEIDMAN, 1985, p. 131) expressa "*the common cognitive state in suicide is ambivalence*" (O estado comum cognitivo no suicídio é a ambivalência, em tradução livre).

Dessa forma, de posse dessa relevante informação, um profissional de segurança pública ou privada ou um profissional de emergência da área de saúde, por exemplo, pode compreender os altos e baixos, o querer agora e não querer depois, a confusão mental indecisa de uma pessoa em crise suicida.

A partir do momento em que os profissionais que lidam com pessoas eminentemente suicidas passam a compreender como se dá a natureza do fenômeno, potencializam, maximizam as chances de êxito em uma intervenção de resgate.

Nesse sentido, entendemos que, se uma pessoa está prestes a se matar, e um chamado de socorro é realizado, é porque aquele que ameaça contra sua própria vida, mas ainda não consumou o ato, está em ambivalência.

Existe impulsividade e também determinação, constrição e rigidez em algumas vítimas em crise suicida; mas, de maneira geral, se alguém dá tempo para que uma equipe de socorro chegue em seu auxílio é porque ela está ambivalente e o conhecimento disso é de vital importância para o sucesso de um resgate.

1.2 Sociologia

Se Shneidman é conhecido por muitos como pai da Suicidologia, Émile Durkheim é conhecido como o pai da Sociologia e é importante não confundir duas ciências diferentes e de escrita e pronúncia similares em português. A Suicidologia estuda os suicídios e aquilo que está ligado com sua natureza; já a Sociologia se liga ao estudo do social, das relações em sociedade e dos fatos sociais.

Émile Durkheim notabilizou-se com o livro “O Suicídio”, no qual faz uma abordagem social sobre o fenómeno do suicídio tentando explicar que todas as sociedades produzem suicídios diante de relações sociais.

Assim, Durkheim utiliza números, comparações, teorias sociais e enuncia os tipos de suicídio, sob o modelo explicativo sociológico, como egoísta, altruísta, anômico e fatalista, explorando as correntes suicidógenas como associadas às causas de suicídios em diferentes países e culturas.

Segundo Durkheim, ([1897], 2005, p. 15):

Chama-se suicídio todo caso de morte que resulta direta ou indiretamente de um ato positivo ou negativo praticado pela própria vítima, ato que a vítima sabia produzir esse resultado. A tentativa de suicídio é o ato assim definido, mas interrompido antes que dele resulte a morte.

Essa é umas das definições mais utilizadas em relação ao suicídio, mas é preciso alertar que Durkheim e seus ensinamentos foram criticados e superados em muitos aspectos atuais da Suicidologia, como é comum acontecer em uma evolução científica.

Ainda, é importante salientar que alguns estudiosos de Durkheim concordam que as correntes suicidógenas concorrem para a existência de suicídios em diferentes sociedades e que essa crença pode gerar uma falsa concepção de que não valem os esforços para prevenção.

Nesse sentido, ao contrário do que essa interpretação equivocada dos ensinamentos de Durkheim sugere, expressamos que segundo a Organização Mundial de Saúde OMS (2014, p. 11), "*suicides are preventable*" (Os suicídios são evitáveis, em tradução livre).

**"Os suicídios são evitáveis."
(Organização Mundial da Saúde, 2014, p.11).**

Vale ressaltar que do ponto de vista da elaboração de políticas públicas para o enfrentamento ao suicídio, saber que uma das principais instituições mundiais da área de saúde afirma que evitar suicídios é de alta relevância.

Entretanto, quando se está falando com pessoas enlutadas por suicídio, enfatizar que os suicídios podem ou poderiam ser evitados, pode causar mais dor e mais sentimento de culpa em sobreviventes indiretos – as pessoas que conviveram com suicidas.

Diante disso, é preciso ter cuidado e evitar trazer à tona ou reforçar ideias de que os suicídios poderiam ter sido evitados e aquela pessoa enlutada não conseguiu salvar seu amigo, parente ou pessoa estimada. O conhecimento sobre Suicidologia deve priorizar o bem-estar das pessoas, trabalhar para a prevenção de forma humanizada e compassiva.

Ainda recomendamos àqueles que queiram aprofundar conhecimento acerca do suicídio à luz da Sociologia, a leitura de escritos de Max Weber e Nöbert Elias, sobre as relações sociais, processos civilizatórios e a possibilidade de suicídios, podendo-se encontrar que os atos pessoais também são importantes na formação do tecido social e, dessa forma, mitigar a crença de que a força social sobre o indivíduo é inescapável.

Karl Marx é outro autor famoso na área da Sociologia que também escreveu sobre o assunto. “Sobre o Suicídio” de Karl Marx trata sobre quatro suicídios, entre os quais 03 são de mulheres. Através das narrativas, o autor fala da opressão sobre as mulheres e segue uma linha de raciocínio que reforça a necessidade de mudanças sociais.

Ainda existem fenômenos notáveis acerca das relações sociais e suicídio. Um deles é o Sati.

De acordo com Barbagli (2019, p. 262):

Naqueles mesmos anos, em várias partes da Índia, outras mulheres se mataram após a morte do marido. Em 1984, houve um caso no vilarejo a vinte quilômetros de Deorala. Em 1988, no Uttar Pradesh, uma mulher de 28 anos imolou-se na pira de um marido que a abandonara fazia muito tempo. Há notícias de casos na última década, mas certamente são os últimos exemplos de um costume que existiu durante séculos: o Sati.

Segundo Barbagli, a palavra Sati tem vários significados, mas geralmente está associada na cultura da Índia com a ideia de uma esposa virtuosa, casta e fiel. Novamente, observamos a cultura opressiva sobre as mulheres que devem manter-se fiéis ou recusar à própria vida na ausência

do marido. Todavia, o próprio autor expressa a extinção do supracitado fenômeno social.

Ainda, Barbagli (2019), que estuda o fenômeno do suicídio no Ocidente e no Oriente, relata sobre uma modernização do fenômeno suicida, bem como uma globalização desse fenômeno. O autor trata o termo terrorismo suicida como uso do terror nas ações suicidas, mas aponta para a ausência de uma uniformização do conceito do que seja o próprio terrorismo.

Segundo Barbagli, o uso de tecnologia com aparelhos celulares, tanques, bombas e até o uso de aviões como nos ataques do World Trade Center, em 11 de setembro de 2001, maximizou número de vítimas, buscou glorificar e tornar os atos como espetáculos de demonstração de força e poder.

Em algumas culturas, os homens bombas são chamados de Kamikazes modernos, em alusão aos pilotos suicidas de Pearl Harbor (O porto da Pérola), durante a segunda guerra mundial, guerreiros que possivelmente tiveram inspiração de estratégia de guerra no modelo suicida de honrar a morte com a autodestruição como se vê nos rituais de morte Haraquiri dos samurais nipônicos.

1.3 Psicologia e Psiquiatria

Atualmente, estudiosos da Psicologia e da Psiquiatria têm demonstrado grande volume de pesquisas acerca do fenômeno do suicídio.

Em 2014, a Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP) publicou a obra, "Suicídio: Informando para Prevenir" que tem apenas 52 páginas, mas traz de forma clara e didática, ensinamentos para a prevenção de suicídios.

Na supracitada obra podemos encontrar relevantes conceitos, como a divisão das fases do suicídio em ideação, planejamento e tentativa, estatísticas e características do fenômeno no Brasil, bem como estratégias de prevenção.

Nesse sentido, a ABP (2014, p. 06) expressou um conceito mais atualizado do que seja suicídio, a saber:

O suicídio pode ser definido como um ato deliberado executado pelo próprio indivíduo, cuja intenção seja a morte de forma consciente e intencional, mesmo que ambivalente, usando um meio que ele acredita ser letal.

Observamos que a Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP) leva em conta o importante fenômeno de ambivalência já mencionado nesta obra. De fato, o potencial suicida quer mata a dor, o sofrimento, quer suportar o sofrimento que se encontra fustigando com veemência a sua mente.

Em "Luto e Melancolia" (1917), Sigmund Freud relata sobre a questão do luto enquanto processo doloroso de perda de algo, alguém ou um objeto de desejo que normalmente traz o sentido de vida, que é Eros, amor, vontade e vida.

Freud leva igualmente em conta a questão da ambivalência demonstrando o que muitos profissionais de segurança pública presenciam no mundo real, vítimas de suicídio que oscilam entre querer viver e querer morrer.

Tal dicotomia, crise existencial de quem hesita entre dois extremos, suscita estranheza entre os profissionais despreparados e desconhecedores de certos pensamentos comuns nas mentes suicidas. Ao contrário, quando se conhece e se treina para este momento, a oscilação causada pela ambivalência é explorada de forma benéfica e oferece vantagem a um interventor em crise suicida que saberá aproveitar os momentos exatos de oscilação para a vida para tentar êxito em sua condução da ocorrência.

Ainda é importante saber que, segundo Botega (2015, p. 108), a depressão, o transtorno bipolar, o abuso de álcool e outras drogas, a psicose esquizofrênica e os transtornos de personalidade com presença de impulsividade e agressividade, como o transtorno da personalidade limítrofe ou *borderline*, são as doenças mentais mais associadas ao suicídio.

Todavia, cuidado, nem todo paciente mental é suicida, nem todo suicida é paciente mental.

Nem todo paciente mental é suicida, nem todo suicida é paciente mental.

O suicídio é explicado por diferentes modelos científicos e não se pode reduzir sua natureza somente às questões de adoecimento mental; porém, ressaltamos que são duas áreas de extrema importância dentro do presente assunto.

1.4 Saúde Pública

O suicídio é considerado um grave problema de saúde pública porque atinge todas as camadas sociais, homens e mulheres, ricos e pobres, brancos, pretos, pardos, indígenas, ateus e religiosos, pessoas de diversas orientações sexuais, pessoas de visões políticas diferentes, jovens, adultos e idosos. O suicídio é alvo de várias áreas da ciência e da vida prática não acadêmica. O suicídio, no século XXI, mostrou que mata mais que homicídios no mundo OMS (2014).

Assim, é necessário entender que, como o suicídio é um desfecho, também chamado de agravo externo sob a óptica da Epidemiologia, ele está associado a múltiplos fatores. Portanto, de acordo com a OMS, o suicídio é multideterminado, multicausal, fenômeno complexo e plural.

Em termos de conceitos, a OMS (2014, p. 12), estabelece "o suicídio é o ato deliberado de alguém se matar."

Dessa forma, observamos que existem vários conceitos diferentes, como foram expressos nesta obra. Existem outros que fugiram a leitura destes autores, mas é oportuno transmitir literatura atualizada, a saber, deste ano de 2021 e de autoria do presidente da Associação Internacional de Prevenção de Suicídios, o psicólogo escocês Rory O'Connor.

Para ele, é relevante dizer não somente o que é o suicídio, mas dizer também o que o suicídio não é.

De acordo com O'Connor (2021, p. 79-86), o suicídio não é:

- 1 - Egoísmo. Crer que o suicídio é egoísmo é aumentar o estigma sobre pessoas e sobre o tema em estudo. Eminentemente, a maioria das pessoas que tentam suicídio estão com

- dor que se apresenta insuportável e o suicídio é um meio que essas pessoas encontraram de acabar com a dor.
- 2 - Forma covarde de fuga. Dizer que o suicídio é uma forma covarde de fuga não vai ajudar as pessoas a vencer ideias suicidas, nem elaborar luto por suicídio. É algo que rotula e insulta muitas pessoas.
 - 3 - Resultado causado só por um fator. O que muitos chamam de causa do suicídio é um **fator precipitante**, um gatilho que disparou a crise suicida e, de fato, uma pessoa em crise suicida está envolta com vários fatores de proteção e de risco e isso precisa ser levado em conta na compreensão do fenômeno.
 - 4 - Desfecho explicado pela doença mental. Para indicar o equívoco dessa crença basta voltar à leitura das páginas iniciais deste capítulo e ver muitas faces que estão interconectadas à questão do suicídio. **O'Connor informa que menos de 5% das pessoas tratadas com depressão (doença mental mais associada aos suicídios) em hospitais se matam.**
 - 5 - Pecado. O suicídio é crime em pelo menos 25 países do mundo. Muitas religiões consideram o suicídio como pecado e crime. Alguns países punem a tentativa de suicídio enquanto a pessoa precisa de fato de ajuda. Portanto, entender que o suicídio é pecado causa muito prejuízo em relação à prevenção de suicídios. Muito mais proveitoso é lançar olhar e ação humanista e ajudar as pessoas diante das crises e da dor.
 - 6 - Culpa dos enlutados. As pessoas que sobrevivem ao suicídio de um parente, amigo ou pessoa estimada vão passar provavelmente por um tipo específico de luto por suicídio que se diferencia de outros tipos de luto e o luto em si se diferencia de pessoa a pessoa. A ideia de que existem fases do luto é didática e não acontece do mesmo jeito para pessoas diferentes. Muitos enlutados se culpam achando que deveriam ter dado mais. A culpa não é deles. Quando se entende que o suicídio é muito mais uma forma de cessar a dor de alguém que não encontrou outros recursos, a culpa é mitigada e tende a desaparecer, mas sempre que possível a ajuda de

profissionais capacitados para lidar com o luto por suicídio será bem-vinda.

Por fim, em relação às conceituações sobre suicídio é importante que se tenha cuidado especial com pessoas de idade avançada e que não por um ato, mas muitas vezes por omissão do autocuidado, podem alcançar sua própria morte.

Um exemplo hipotético¹:

A esposa de Marcos, dona Isabel, tem 80 anos e o marido tem 85 anos. Senhora Isabel adoece e vem a falecer. O Sr. Marcos mora sozinho, pois seus dois filhos estão casados e moram em outras cidades. O senhor Marcos passa a morar sozinho e não tem mais a companhia e os compromissos e tarefas que realizava junto com a esposa. Sofre a anomia, ausência de normas sociais do homem casado, sente a falta da esposa, chora às vezes olhando o retrato do casal. Liga para os filhos, mas eles nem sempre têm tempo de escutá-lo, pois trabalham muitas horas por dia. Marcos se vê só. Não está engajado em grupos sociais. Toma muitos remédios para pressão alta, diabetes e problemas cardíacos. Marcos percebe que não tem mais motivo para viver. Passa pela anedonia, ausência de prazer nas atividades habituais. Deixa de tomar seus remédios. Marcos sente que quer dormir pra sempre. Quer descansar da dor e do vazio que a ausência da esposa e do trabalho que tinha fazem a ele. Passa a não comer, nem beber mais nada. Não toma os remédios e se deita desejando morrer. Assim, devido à idade avançada,

¹ Os nomes usados são fictícios.

a necessidade dos remédios, bem como devido a desidratação o corpo de Marcos entra em colapso e vem a óbito. Havia consciência e intencionalidade de que suas omissões de autocuidado em sua situação de doença e idade avançada o levariam à morte certa e rápida. Assim, entendemos que em circunstâncias semelhantes, uma pessoa, por omissão, poderá também morrer por suicídio.

Esse exemplo no final deste capítulo traz, para além de uma reflexão sobre o que é o suicídio, o alerta para o cuidado que se deve ter com as pessoas, principalmente com pessoas em idade avançada que formam um grupo vulnerável onde a taxa de suicídios é mais elevada.

1.5 Fatores de Proteção, Fatores de Risco, Gatilhos e Âncoras

Em Suicidologia, os conceitos têm mostrado que não existe uma única causa ou fator explicativo para o suicídio. O'Connor (2021), traz essa lição, mostrando como o suicídio tem sua pluralidade, complexidade, sendo ocasionado por interações diferentes, inclusive de natureza social. Aquilo que geralmente se chama de causa do suicídio, na verdade é o gatilho, um fator de risco precipitante, aquilo que dispara uma crise suicida.

Segundo a Organização Mundial de Saúde, muitos são os fatores que podem levar ao comportamento suicida, como fatores sociais, culturais, psicológicos, entre outros. De acordo com a OMS, uma tentativa prévia de suicídio é o fator de risco mais forte associado a uma tentativa consumada. (OMS, 2014).

De acordo com a Associação Brasileira de Psiquiatria (2014), os dois maiores fatores de risco são a tentativa prévia de suicídio e a doença mental. Esses fatores associados são identificados através de estudos e de investigações em pessoas que pensam, tentam e morrem por suicídio.

Assim, não somente fatores de risco, mas também fatores protetivos para superação de crises suicidas e prevenção de suicídios consumados são identificados nos estudos e pesquisas científicas. Para um melhor entendimento, podemos dizer que fatores de risco aumentam a probabilidade de morte por suicídio e fatores de proteção diminuem a probabilidade de morte por suicídio.

Segundo a ABP (2014), fatores protetivos seriam: bons laços sociais estabelecidos com a família, autoestima elevada, afiliação religiosa, razão para viver, acesso a serviços de saúde, capacidade de adaptação, capacidade de resolução de problemas, entre outros. Fatores de risco seriam: desesperança, desespero, desamparo, impulsividade, doença mental, eventos adversos na infância e na adolescência, histórico familiar de suicídio, dependência química, entre outros.

Importante enfatizar que existem fatores que são modificáveis, podendo em determinado tempo de vida de uma pessoa ser protetivo e em outro tempo ser de risco. Um exemplo seria o casamento. O casamento pode ser protetivo, mas quando existem conflitos, processos de separação, traições conjugais, entre outras características adversas, podem fazer com que o casamento se torne um fator de risco.

Assim, um determinado fator pode deixar de ser protetivo e passar a ser de risco e vice-versa. O mesmo casamento que virou um fator de risco pode passar reconciliação e voltar a ser protetivo.

Um profissional que atende a uma ocorrência em tentativa de suicídio não deve partir do princípio que os fatores de risco e de proteção de uma pessoa são estabelecidos previamente, mas sempre verificar por meio de escuta e de interação comunicativa com a vítima em crise suicida quais fatores são de fato protetivos e de risco naquele exato momento.

Evidenciamos que se existe um disparador de crise suicida que é chamado comumente de “gatilho”, também podem existir fatores especiais que são verdadeiros freios para parar ou mitigar crises suicidas que são conhecidos por “âncoras.” Uma âncora em Suicidologia seria um fator especial que se vincularia a um forte sentido de vida e valor para uma vítima.

Uma âncora tem a capacidade de fazer uma pessoa em crise suicida repensar se realmente quer se matar. A vítima fica em dúvida e oscila para desejos de vida quando pensa em uma âncora.

Os fatores protetivos e âncoras podem ser utilizados habilmente por um profissional que atende ocorrência em tentativa de suicídio para criar desejos de vida, conexões e esperança, e produzir ou aumentar a probabilidade de desistência de ato suicida.

A profissão do policial militar: vivências de prazer e sofrimento no trabalho

Lilian Ester Winter^{1,a}, Alexandra Machado Alf^b

Faculdade Integrada de Santa Maria – FISMA, Santa Maria, Brasil^a, Sociedade Educacional Três de Maio – SETREM, Três de Maio, Brasil^b

Palavras-chaves:

Policiais militares;
Prazer;
Sofrimento;
Trabalho.

Resumo

Este artigo contempla pesquisa realizada com profissionais da Polícia Militar lotados no interior do Estado Rio Grande do Sul, no ano de 2016, com abordagem da Psicodinâmica do Trabalho. Foram investigados fatores que determinam vivências de prazer e sofrimento no cotidiano de trabalho. Este estudo avaliou dez profissionais, por meio de questionário sociodemográfico e entrevista semiestruturada. Os discursos foram analisados por meio da análise de conteúdo. Os resultados indicam que o trabalho desses profissionais é gerador tanto de prazer como de sofrimento. O fardamento desconfortável e o descontentamento com o quadro de funcionários são causas de sofrimento, já os sentimentos de prazer são apontados pela autonomia no atendimento às ocorrências. Desta forma, foram identificadas estratégias de defesas utilizadas pelos policiais militares para amenizar o sofrimento ocasionado pelo trabalho, destacando-se: a resiliência, a sublimação e a não verbalização do sofrimento, sustentado pelo recurso simbólico da virilidade reforçada pela cultura gaúcha.

Police Officer Profession: Experiences of pleasure and suffering at work

Keywords:

Policemen;
Pleasure;
Suffering;
Labor.

Abstract

This article examines research conducted with Military Police professionals in a remote area of Rio Grande do Sul State, in the year 2016. Based on the theory of Psychodynamics of Work, some factors that create experiences of pleasure and suffering in the daily work of the Military Police were investigated. This study evaluated ten professionals, using a sociodemographic questionnaire and an individual semi-structured interview. The discourse was analyzed using content analysis. The results showed that Military Police work creates both pleasure and suffering. The uncomfortable uniform and the discontent with employees' situations were linked with suffering, while the feelings of pleasure were indicated for the opportunity to work with autonomy in responding to incidents. Thus, some defense strategies used by the Military Police to ease the suffering at work were identified, highlighting: resilience, sublimation, and nonverbalization of suffering, supported by the virility reinforced by the gaucho culture.

La profesión del policía militar: vivencias de placer y sufrimiento en el trabajo

Palabras-clave:

Policiales Militares;
Placer;
Sufrimiento;
Trabajo.

Resumen

Este artículo comprende una investigación realizada con profesionales de la Policía Militar en el interior de Río Grande del Sur, en el año 2016, con abordaje teórico de la Psicodinámica del Trabajo. Se investigaron factores que determinan vivencias de placer y sufrimiento en su trabajo diario. En estudio fue evaluado diez profesionales con un cuestionario sociodemográfico y una entrevista semiestruturada, cuyos discursos fueron analizados por medio del análisis de contenido. Los resultados revelaron que el trabajo genera tanto placer como sufrimiento. El uniforme incómodo y lo desagradado con el cuerpo de funcionarios causan sufrimiento, ya los sentimientos de placer se apuntan con la posibilidad del policía actuar con autonomía. Así, se identificaron estrategias de defensas utilizadas para ablandar el sufrimiento, en que se destacan: el elasticidad, la sublimación y la no verbalización del sufrimiento sostenida por la función simbólica de la virilidad y reforzado por la cultura gaucha.

¹ Endereço para correspondência:

R. José do Patrocínio, 26 - Centro, Santa Maria - RS, 97010-260 E-mail: lwinter10@gmail.com

Como citar este artigo:

Winter, L. E., & Alf, A. M. (2019). A profissão do policial militar: vivências de prazer e sofrimento no trabalho. *Revista Psicologia: Organizações e Trabalho*, 19(3), 671-678. doi: 10.17652/rpot/2019.3.13214

O policial militar desempenha uma importante função na sociedade, é ele quem zela pela segurança e bem-estar de todos os cidadãos, podendo ser considerado o representante da lei que se mantém mais próximo da comunidade. Ao policial compete oferecer segurança e ordem, de um lado, por inibir os atentados à ordem social; de outro, por propiciar aos cidadãos a liberdade, para os que vivem em conformidade com os princípios da lei.

A Polícia Militar do Rio Grande do Sul passou por uma série de transformações decorrentes da evolução socioeconômica e política do Estado. Recebeu diversas denominações, tais como Força Policial, Corpo Policial, Guarda Cívica, Brigada Policial, até que, em outubro de 1892, passou a se chamar Brigada Militar, denominação utilizada somente no Estado do Rio Grande do Sul. Atualmente, a Instituição conta com cerca de 26.000 homens e mulheres em seu quadro de servidores, constituindo a maior instituição pública do Estado, com mais de 170 anos de história (Brigada Militar Rio Grande do Sul, 2016; Ribeiro, 2011).

Os integrantes da Brigada Militar são servidores militares e estão regulados nos artigos 46, 47 e 48 da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, de 3 de outubro de 1989. A Brigada Militar foi instituída para a preservação da ordem pública no Estado e é considerada força auxiliar para o Exército Brasileiro, sendo uma Instituição permanente, organizada com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Governador do Estado (Lei Complementar RS 10.990, de 1997).

Atualmente, com o crescente índice de violência e criminalidade no País, há o fomento de pesquisas no campo da segurança pública com foco no trabalho do policial militar, considerando sua exposição diária a situações de risco e o contexto profissional ao qual estão inseridos (Ferreira, 2009). Os estudos evidenciam os policiais militares como um dos profissionais mais vulneráveis a acidentes, agressões e mortes no exercício de sua função (Souza & Minayo, 2005; Souza, Franco, Meireles, Ferreira, & Santos, 2007). Em nível internacional, pode-se encontrar estudos que investigam o trabalho do policial associado a patologias, como estresse ocupacional, disfunções físicas, transtornos mentais e até mesmo suicídio (Hartley, Knox, Fekedulegn, Barbosa-Leiker, Violanti, Andrew & Burchfiel, 2012; Who, 2010; Stuart, 2008). No Brasil, levando em consideração os inúmeros batalhões de polícia existentes, ainda há um número reduzido de pesquisas que procuram investigar a relação sujeito-trabalho desses profissionais.

Destacam-se autores como Machado, Traesel, e Merlo (2015) e Spode e Merlo (2006), que estudam essa categoria pelo viés da psicodinâmica do trabalho. Suas pesquisas apontam que os policiais estão expostos a um alto nível de tensão, visto que a constante violência a que estão submetidos, somada à organização da atividade, tempos e ritmos instáveis, exigem dos profissionais um estado de vigilância contínuo, próprio desse segmento. Esta organização do trabalho acaba demandando comprometimento físico e psicológico muito grande, o que pode influenciar diretamente na saúde física e psicológica desses trabalhadores.

Além disso, salienta-se que as relações sociais desse grupo profissional estão pautadas em círculos e níveis hierárquicos, condicionando os trabalhadores ao cumprimento estrito da ordem de um superior, havendo pouca mobilidade para tomar decisões (Oliveira & Santos, 2010). Essa estrutura engessada característica das instituições militares, bem como a natureza da atividade policial, revelam uma categoria com índices de estresse superiores a outros profissionais (Souza, Minayo, Silva, & Pires, 2012).

Outra particularidade a ser mencionada é a falta de reconhecimento social e o preconceito da população sobre esse segmento profissional, o que justifica a escassa literatura sobre o tema.

Esse preconceito pode ser considerado algo naturalizado na sociedade, possivelmente originado no período da Ditadura Militar no Brasil, quando a figura do policial era associada ao abuso de autoridade e uso excessivo (Ferreira, 2009; Souza & Minayo, 2005).

Autores como Holloway (1997), Mesquita Neto (1999) e Souza e Minayo (2005) afirmam que a desconfiança da população em relação aos militares permanece até hoje. A classe média alta frequentemente critica a segurança pública por sentir-se prejudicada pela ineficiência do combate à criminalidade, enquanto os moradores de áreas periféricas e violentas, julgam a conduta policial como duvidosa e, por vezes, discriminatória (L. A. M. Silva & Leite, 2007; Souza & Minayo, 2005). A atuação do policial militar, frequentemente em evidência pela mídia, deixa uma lacuna não conhecida pela sociedade: a do policial trabalhador, cuja função é conter a violência, mas que, ao mesmo tempo, corre o risco de reproduzi-la para manter a ordem (Spode & Merlo, 2006).

A constante exposição ao perigo inerente ao exercício do policial, somada à violência que permeia a sociedade, ocasionam sentimentos como medo de ser agredido, ou até morto no desempenho de sua função, e de ser reconhecido como agente de segurança mesmo em seu horário de descanso e na companhia da família (Minayo, Souza, & Constantino, 2008). Todos os dias, o policial militar coloca sua vida em risco em favor da vida do outro (Souza et al., 2012). Desse modo, a morte acaba sendo realidade no cotidiano desse profissional, que precisa estar preparado para enfrentá-la a qualquer momento, seja no horário de trabalho ou fora dele (Oliveira & Santos, 2010).

No entanto, é notório que esses profissionais passam por formações específicas para se tornarem policiais, participam de cursos e treinamentos em que se especializam no combate à criminalidade e se apropriam da cultura militar. Nesses momentos, também reafirmam-se ideais como a virilidade, a força, a rudeza, a superação e a coragem, atributos que compõem o enredo cultural e histórico do militar (França & Gomes, 2015). Sobre a cultura gaúcha, esse estereótipo machista ganha ainda mais destaque, pois valores como “povo guerreiro, orgulhoso, viril e bravo” (estão presentes...) estão presentes no imaginário regional. A identidade do sujeito gaúcho se caracteriza por sempre estar disposto para batalha e nunca fugir de suas obrigações (Henriques & Lisboa Filho, 2015; Lisboa Filho, 2009). Essas características intrínsecas do universo militar, acrescidas do estereótipo e cultura gaúcha, exigem ainda mais dos policiais lotados nesta região do país.

De fato, não é difícil identificar que se trata de uma categoria profissional bastante vulnerável à produção de sofrimento psíquico e que merece atenção, não só da academia, mas também da sociedade. Mediante a busca de estudos realizados, observou-se que existem pesquisas com profissionais da Polícia Militar (Ferreira, 2009; Machado et al., 2015; Oliveira & Santos, 2010; Souza & Minayo, 2005; Souza et al., 2012; Spode & Merlo, 2006); porém, ainda são escassas as que investigam a relação sujeito-trabalho a partir da psicodinâmica do trabalho. Assim, almeja-se que este estudo possa contribuir para uma reflexão sobre o policial militar e seu contexto de trabalho, considerando a sua influência na saúde psíquica dos policiais. A seguir, serão apresentados os procedimentos metodológicos que guiaram o estudo.

Método

Tipo de Estudo

Trata-se de uma pesquisa qualitativa que busca compreender as questões a partir das narrativas dos sujeitos. O referencial teórico

que sustenta o estudo está pautado na psicodinâmica do trabalho, teoria que estuda a relação sujeito-trabalho desde a década de 80, usando como base os fundamentos da Psicanálise, da Ergonomia e da Sociologia do trabalho (Merlo, 2002; Merlo & Mendes, 2009). Quanto aos procedimentos, realizou-se um estudo de caso múltiplo com foco em um grupo de policiais militares, objetivando conhecer a sua realidade profissional e sua influência para vivências de prazer-sofrimento no trabalho (Yin, 2015).

Local de Estudo

A coleta de dados ocorreu no período de fevereiro e março de 2016, em uma corporação da Polícia Militar, no interior do Estado do Rio Grande do Sul.

Participantes

A população do estudo foi composta por dez profissionais da Brigada Militar, lotados em um município localizado no Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul. A seleção dos participantes ocorreu de forma voluntária, partindo do interesse do profissional em participar do estudo.

Tabela 1
Dados sociodemográficos

Participante	Idade	Sexo	Escolaridade	Patente	Tempo de serviço	Estado Civil	Nº de filhos
E1	38	Masculino	Superior Incompleto	Tenente	18 anos	Casado	03
E2	44	Masculino	Superior Completo	Sargento	27 anos	Casado	02
E3	28	Masculino	Superior Incompleto	Soldado	6 anos	Casado	01
E4	59	Masculino	Ensino Médio	Tenente	32 anos	Casado	03
E5	36	Feminino	Superior Completo	Sargento	19 anos	Casado	02
E6	45	Masculino	Ensino Médio	Sargento	29 anos	Casado	01
E7	36	Masculino	Superior Completo	Soldado	13 anos	Solteiro	01
E8	42	Masculino	Ensino Médio	Sargento	17 anos	Casado	02
E9	46	Masculino	Ensino Médio	Sargento	29 anos	Casado	02
E10	30	Masculino	Ensino Médio	Soldado	9 anos	Casado	02

Nota. Fonte: Elaborado pelas autoras (2016).

Na tabela 1, pode-se constatar que os sujeitos da pesquisa são 90% do gênero masculino e 10% do gênero feminino. A faixa etária que compõe a amostra concentra-se entre 28 e 59 anos de idade. Quanto ao estado civil dos participantes, 90% são casados e 10% solteiros, sendo que 100% da amostra possui filhos. O grau de escolaridade varia entre ensino médio e ensino superior completo, sendo que, da amostra, 30% possui ensino superior completo, 20% ensino superior incompleto e 50% possui o ensino médio completo. O tempo de serviço dos participantes apresenta alternância entre menos de 10 anos de serviço até 32 anos, sendo que, destes, 20% têm até 10 anos de serviço, 40% têm até 20 anos, 30% têm até 30 anos e 10% até 32 anos de atividade laboral. Em relação às patentes dos militares, 20% ocupam o posto de tenente, 50% de sargento e 30% de soldado.

Instrumentos

Os instrumentos utilizados como técnica de coleta de dados foram: um questionário sociodemográfico, que possibilitou a caracterização do perfil dos entrevistados, e uma entrevista semiestruturada, com questões abertas, que teve como prioridade a escuta do trabalhador. O roteiro das questões foi elaborado a partir de revisão de literatura na área, considerando aspectos do contexto de trabalho, cooperação, espaço de discussão, autonomia no trabalho e dinâmica prazer-sofrimento.

Procedimento de Coleta de Dados e Cuidados Éticos

Para a realização da pesquisa, contou-se com a corporação da Brigada Militar do município no qual foi apresentado o projeto de pesquisa ao responsável pela Corporação, que concordou com a realização do estudo. Da mesma forma, a proposta foi apresentada para os demais integrantes do Batalhão, sendo neste momento identificados os profissionais com interesse em participar do estudo.

Previamente, foi realizada a busca por um local sigiloso e reservado para realização das entrevistas, que ocorreram individualmente conforme disponibilidade de cada profissional. Embora a psicodinâmica do trabalho preconize que o levantamento de informações ocorra em pequenos grupos (espaços de discussão), a realização de entrevistas individuais se justifica pelas especificidades do público-alvo, como a preservação da identidade dos sujeitos (Mendes, 2007).

Os participantes receberam esclarecimentos acerca do caráter acadêmico da pesquisa, realizando a leitura e assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, do qual mantiveram uma cópia para si. A coleta de dados foi realizada em março de 2016. Todas

as entrevistas foram gravadas, tendo duração média de 30 minutos cada, e posteriormente foram transcritas na íntegra.

Todos os cuidados éticos foram tomados, estando este estudo respaldado pelas Resoluções do Conselho Nacional de Saúde 466, de 2012, e 510, de 2016, que regulamentam, respectivamente, as questões éticas com pesquisas envolvendo seres humanos. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade de Passo Fundo, através do Parecer 1.390.693.

Procedimento de Análise dos Dados

Os dados coletados nas entrevistas foram analisados por meio da técnica de análise de conteúdo categorial temática. Desse modo, após a transcrição das entrevistas, foi realizada uma pré-análise do material, bem como a codificação e sistematização dos dados em categorias, ou seja, o processamento dos dados em estado bruto para possível compreensão e interpretação (Bardin, 2011).

Neste estudo, foram estabelecidas duas unidades de análise, selecionadas previamente a partir do roteiro de entrevista utilizado: a primeira, denominada Categoria Contexto de Trabalho, que contempla as subcategorias: Relações Socioprofissionais e Hierarquia; Condições de Trabalho: Equipamentos, Fardamentos e Trabalhadores; e a segunda categoria Prazer e Sofrimento no Trabalho, com três subcategorias: Autonomia no Atendimento às Ocorrências, Espaço de Discussão e Cooperação, Sofrimento e Estratégias Defensivas.

Resultados e Discussão

A análise dos resultados está embasada na teoria da psicodinâmica do trabalho, sob a diade prazer-sofrimento. A apresentação dos resultados será iniciada com reflexões acerca da Categoria Contexto de Trabalho, seguida da segunda Categoria Prazer e Sofrimento no Trabalho e suas subdivisões. Para sustentar a análise realizada, foram utilizados trechos emblemáticos narrados pelos participantes, identificados por códigos para preservar a identidade.

Categoria Contexto de Trabalho

Relações Socioprofissionais e Hierarquia

As Relações Socioprofissionais (RS) compreendem uma dimensão social, como a interação e o relacionamento socioprofissional no *locus* de trabalho. Compõem essa categoria as interações hierárquicas, entre chefias e empregados, a interação dos grupos e as interações externas ao ambiente de produção (Mendes & Ferreira, 2008).

Em relação à interação entre os diferentes níveis hierárquicos, os participantes relatam não existir dificuldade no relacionamento com os colegas e superiores. Pode ser constatado também que muitos participantes consideram a hierarquia uma possibilidade de crescimento dentro da profissão, o que pode servir como estímulo para o profissional; outros mencionam a hierarquia como algo necessário e fundamental para o funcionamento da Instituição, o que é relatado nas falas a seguir:

Não tenho atrito com ninguém, me dou muito bem com todos eles, gosto de trabalhar com todos eles, é boa a relação. E com a chefia também, com a chefia da mesma forma. Eu acho que a hierarquia é bom, eu gosto, todos tem que ter hierarquia até em uma empresa particular, se não tiver não vai funcionar né, eu gosto. Para mim é tranquilo (E7);

Em relação a hierarquia não tenho dificuldades, nem problema nenhum, se é superior é superior, eu vejo a hierarquia como uma escala de crescimento (E1).

Em relação à questão da hierarquia, cabe ressaltar que a Brigada Militar segue o regime militar hierárquico, sendo este classificado por graduações, ou seja, nível de responsabilidade e qualificação profissional. Assim, constatou-se como característico da Instituição uma cadeia de comando conservadora e rígida, estabelecendo unidades de comando demarcadas, determinando a qual autoridade de cada subordinado deve-se dirigir (Leiner, 1997; Silva & Vieira, 2008). No entanto, dois entrevistados manifestaram desconforto e mal-estar que muitas vezes essa diferenciação hierárquica pode promover, pois, associada a ela, vem a ausência de diálogo e troca de ideias, dificultando a abertura de um espaço de trabalho mais cooperativo. Segue a narrativa dos entrevistados:

Tu não consegue expor a tua opinião e nem fazer com que teu superior tente enxergar de outra maneira, você tem que cumprir o que ele ta dizendo porque você pode ser punido. É claro que alguns superiores abrem esse espaço para o subordinado, mas tem alguns que cumprem à risca e estes são a maioria (E3);

A questão da hierarquia desde curso a gente aprende, desde curso, tem certas coisas que tu tem autonomia, por isso né tu vive no mundo militar, tem coisas que pode ser contrário a tua forma de pensar, mas se teu superior disse que tem que agir daquela forma, tem que agir (E5).

A partir da análise das falas é possível identificar que as decisões centralizadas ocasionam insatisfação em alguns policiais, tanto pela falta de espaço de discussão quanto pela im-possibilidade do uso da inteligência prática. As decisões são tomadas pelos superiores hierárquicos e todos os que se encontram abaixo desta posição; simplesmente cumprem as ordens, estabelecendo distância entre quem dá as ordens e quem as cumpre (Mendes & Araújo, 2012).

Neste estudo, cabe advertir que as falas que relatam desconforto com a hierarquia e sua interferência direta nas relações socioprofissionais são de patentes e postos da base da escala hierárquica. Esses entrevistados ocupam um lugar de execução e não de comando, o que os coloca em posição de obediência, não tendo espaço e nem voz para confrontar o prescrito. Leiner (1997) enfatiza que essa relação perpassa a cadeia de comando, ou seja, mesmo fora do trabalho os militares estão submetidos a padrões preestabelecidos de comportamento. Em arrimo a essa constatação, serão mencionadas a seguir as condições de trabalho às quais os profissionais são expostos.

Condições de trabalho: equipamentos, fardamento e trabalhadores

A categoria Condições de Trabalho (CT) tem como foco os elementos básicos estruturais para o trabalho como ambiente de produção, infraestrutura e apoio organizacional. Os fatores analisados são o ambiente físico, os instrumentos e equipamentos disponíveis para a realização da tarefa, a matéria-prima e o suporte fornecido pela Instituição (Mendes & Ferreira, 2008).

Ao serem questionados sobre as condições de trabalho aos quais são submetidos, os participantes afirmaram que, em relação aos equipamentos disponíveis para o desempenho das atividades, estão bem amparados. Foi por meio do apoio e da assistência da Comunidade que os policiais conquistaram melhorias para seu cotidiano de trabalho. Como segue nas narrativas:

Nosso contexto de trabalho hoje melhorou bastante em relação a equipamentos, armamentos e proteção individual nós estamos muito bem (E1);

De material está melhor com certeza, desde equipamento, colete, arma cada um tem a sua, e viatura também está bem melhor (E10).

Outro aspecto importante ressaltado pelos policiais foi a insatisfação em relação ao uniforme de trabalho, ou seja, seu fardamento, sendo este um aspecto que interfere de forma negativa no desempenho das atividades habituais, como pode ser visto nas falas a seguir:

No verão é muito quente, nossa farda não teve uma evolução, nossa farda eu uso o mesmo tecido há praticamente 27 anos, então a gente passa muito calor e no inverno passa frio porque é uma coisa que não esquenta (...) Se você quer um conforto melhor no fardamento você tem que tirar do bolso, no fim a Brigada gasta e eu gasto (E2);

Até teriam que rever esse nosso fardamento por que chega a ser desumano num calor desse e a gente trabalhando dessa forma, acaba que a gente fica sem ânimo de trabalhar (E5).

Estas falas ilustram a importância de desvelar aspectos que passam despercebidos pelo Estado, que é o órgão responsável. O fardamento inapropriado um fator desfavorável às atividades laborais, interferindo, inclusive, no ânimo dos policiais, como mencionado em uma das narrativas. Este aspecto faz compreender que o trabalho do policial militar tem nuances que, muitas vezes,

não são vistas e nem consideradas na prática cotidiana do policial militar e que interferem em sua motivação para desempenhar seu trabalho.

No que se refere ao quadro de funcionários, ou seja, trabalhadores disponíveis, há evidências de descontentamento. Os policiais se referem ao número reduzido de funcionários como sendo o principal problema existente no momento, o que sobrecarrega os profissionais que estão disponíveis e prejudica a qualidade do serviço prestado à Comunidade.

O nosso problema de hoje que a gente tem enfrentado é material humano (E1);

Falta efetivo, número baixo de funcionários o que prejudica desenvolver um bom trabalho (E3);

(...) certas atitudes que você deveria tomar que seria a correta, você acaba não tomando por que está em menor número, até por que se é para tu apanhar em uma ocorrência é melhor tu recuar, recuar momentaneamente e chamar um reforço de fora (E5).

Quanto ao contexto de trabalho do policial militar, deve-se destacar que a Brigada Militar é uma Instituição com mais de 170 anos de existência e que possui normas e regulamentos específicos, pautados no modelo militar e permeados por uma cultura que determina seu funcionamento. Esse modelo de gestão burocrático pode ocasionar desconforto entre os trabalhadores por não concordarem (ou estarem insatisfeitos) com determinados aspectos do trabalho e não possuírem viabilidade de manifestação. Segundo M. B. Silva & Vieira (2008) a dicotomia entre o pensar e o executar pode contribuir para ações arbitrárias e para o desconforto no contexto de trabalho.

Categoria Prazer e Sofrimento no Trabalho

Autonomia no atendimento às ocorrências

Para Dejours (2007) os espaços coletivos de fala, a possibilidade de agir com autonomia frente às dificuldades encontradas no real do trabalho, assim como o uso da inteligência prática para completar as tarefas permitem ao trabalhador o sentimento de prazer no trabalho. Questionados se possuem autonomia no desempenho de suas atividades, os entrevistados responderam que possuem autonomia para tomar decisões e conduzir situações, no atendimento às ocorrências ou na prática do policiamento ostensivo, quando não dispõem de tempo para consultar seus superiores. Como pode ser identificado nas falas abaixo:

Tenho autonomia, nós temos os nossos superiores como qualquer outra condição, porém quando você está na rua você passa por cima deles muitas vezes, tem que passar por que as decisões são tomadas muito rápido (E3);

Sim, nas ocorrências, o que está dentro da lei a gente tem autonomia para fazer sem nenhum tipo de restrição. Tu chega e resolve (E10).

As narrativas ilustram que o contexto de trabalho dos policiais é feito de imprevistos e pode ser considerado uma “caixinha de surpresas”; isso exige que esse profissional esteja preparado para enfrentar as mais diversas situações, devendo conhecer as normativas legais e os procedimentos prescritos a serem seguidos (Spode & Merlo, 2006). Entretanto, é indispensável que o policial militar

possua autonomia na sua prática de trabalho, pois, diariamente, enfrenta situações inesperadas e não previstas pela organização. Como pode ser observado na fala do participante E10 e E8:

Todo dia que a gente começa a trabalhar a gente não sabe o que vai ser o serviço, se vai dar acidente, se vai dar roubo, furto, briga, como é, de que jeito é, sempre diferente, todo dia é diferente isso que é o melhor do trabalho, nunca vai ser igual de um dia para o outro, as vezes não dá nada, as vezes dá um monte de problema (E10)

Deste modo, pode-se constatar que cada dia de trabalho é diferente, assim como todas as ocorrências são distintas, não podendo estas serem solucionadas somente a partir dos procedimentos prescritos. A autonomia permite ao policial acessar suas experiências passadas para solucionar os imprevistos do real do trabalho nas ocorrências das ruas, possibilitando a mobilização da inteligência prática, atribuindo sentido ao trabalho e gerando prazer (Lancman & Sznelman, 2011).

Entretanto, para ser reconhecido, o trabalhador precisa compartilhar seus segredos no coletivo de trabalho, transformando sua inteligência prática em sabedoria prática, através dos espaços de fala (Dejours, 2007; Vasconcelos, 2013).

Espaço de discussão e cooperação

É através dos espaços coletivos que os trabalhadores realizam as trocas de informações, tornam visível o oculto, compreendendo os investimentos pessoais empregados na realização de cada tarefa, possibilitando ao trabalhador se colocar no lugar do outro. Esses espaços são perfeitos para a expressão da fala e do sofrimento (Mendes & Araújo, 2012). Dessa forma, na Instituição estudada, identificou-se a existência de espaço de fala formal e informal, como pode ser verificado nas falas dos entrevistados a seguir:

Normalmente sim, no início do serviço e no término do serviço, e até mesmo na viatura mesmo a gente conversa sobre as ocorrências troca informações. E também, tem as instruções mensais que a gente se reúne, é na realidade é dado espaço de fala, mas nem todo mundo fala, é mais na informalidade que o pessoal fala, mas assim quando é um momento formal nessas reuniões mensais o pessoal não fala muito (E5)

Frente ao exposto, é possível constatar que existe um espaço de fala formal organizado pela Instituição, no qual os policiais têm a possibilidade de falar e de refletir sobre situações de seu cotidiano de trabalho. Entretanto, pode-se perceber que nesse espaço formal os policiais se mantêm mais retraídos, optando por realizarem suas trocas nos momentos informais, legitimados pelo coletivo.

Depois da ocorrência a gente conversa entre a gente, analisa a situação, vê o que que foi, o que aconteceu, o que pode ter acontecido, a gente conversa mais ou menos tenta deduzir com a experiência e tenta juntar as peças (E10);

Nas preleções que é na troca dos turnos de serviço, o pessoal senta, se reúne a gente faz uma meia hora de chimarrão e conversa um pouco, e ali acontece as trocas de informações (E5).

De acordo com Gernet e Dejours (2011), Ghizoni (2013) e Mendes (1995), o espaço público de fala deve ser construído pelos próprios trabalhadores, não sendo prescrito; deve ser natural e espontâneo, pautado na confiança, promovendo a cooperação e a construção das regras comuns. Os policiais, em suas narrativas, revelam que as trocas, as dúvidas e as possibilidades de realização do real do trabalho acontecem em espaços legitimados por eles e

não pela Instituição, ocorrendo sempre em espaços informais oportunizados pelo coletivo de trabalhadores.

A cooperação é outro aspecto importante a ser investigado e está diretamente ligada à existência dos espaços de discussão que viabilizam as práticas do trabalho real. Também está vinculada à interdependência dos artifícios de cada trabalhador, como a engenhosidade e a inteligência astuciosa na busca de um objetivo comum, fundamentados na confiança e na solidariedade (Dejours, 2011 citado em Ghizoni, 2013).

Nos depoimentos, os policiais demonstram a interdependência e a relação de confiança que se instaura entre os policiais militares, na tentativa de juntos, solucionar os imprevistos que enfrentam diariamente em seu cotidiano de trabalho:

A gente se adapta, as vezes a gente tem segundos para resolver, é transmitido a ocorrência para nós e a gente tem segundos para resolver. As vezes tem só dois ou três de serviço e nem tem como se planejar muito, a gente conversa o que vamos fazer, vai ser assim e as vezes nem dá tempo de conversar e ver o que fazer, é automático, cada um já sabe mais ou menos o que faz né. A gente trabalha sempre com colegas diferentes, mas a gente sabe o jeito de trabalhar de cada um (E10).

No trabalho do policial militar, a cooperação aparece como fundamental, sendo que conhecer o colega revigora as relações socioprofissionais que são fonte de prazer e fortalecimento desse trabalhador (Ghizoni, 2013; Martins & Mendes, 2012). Fazendo uso da cooperação é possível minimizar erros e falhas, tornando o desempenho coletivo mais eficaz do que a soma dos desempenhos individuais. Os coletivos de trabalho constituem espaços de resistência para o sujeito, combatem a individualização e a servidão, permitindo ao sofrimento destinos menos patológicos.

Sofrimento e estratégias defensivas

Neste tema, estão presentes as questões referentes às estratégias de defesa utilizadas pelos policiais militares. As estratégias defensivas são dispositivos utilizados pelos trabalhadores, de modo individual ou coletivo, para amenizar o sofrimento ocasionado pelo trabalho (Dejours, 1992; Mendes, 2007; Moraes, 2013). Neste estudo, pode-se observar a sublimação e a resiliência como formas de “proteção” frente às situações mobilizadoras enfrentadas no cotidiano de trabalho:

Tu pega uma criança quebrada em um acidente, ou um indivíduo com tiro na cabeça sei lá, várias situações, colegas feridos que é uma coisa que mexe muito com a pessoa (...) na hora a gente fica meio atônico, e tem que parar um pouco sair daquilo ali para ver o que faz né, tudo muito rápido, são situações que levam a gente ao extremo né, mas tem que tentar na hora ver o que se faz de melhor, e não meter os pés pelas mãos (E8).

Por meio da narrativa pode-se constatar que a sublimação se faz presente, pois o policial canaliza seus impulsos para cumprir as exigências da realidade da profissão, como tomar decisões e prestar socorro em situações em que a vida de pessoas está em risco. Além disso, identificou-se a resiliência como estratégia do ego, que se manifesta quando os policiais mencionam as adversidades do trabalho, características da profissão, sendo esta uma defesa importante para proteger a integridade do mesmo. O relato do participante E5 evidencia esse aspecto:

Às vezes tu fica até assustado, mas tu tem que dar um jeito de resolver aquilo ali né, tu é o responsável por aquilo ali, tu é responsável pela

segurança pública, e tu tem que dar um jeito de resolver né, engole seco e vai (E5).

Na Brigada Militar, ainda se constatou a instauração do silêncio como estratégia defensiva coletiva. As estratégias defensivas coletivas representam acordos firmados no coletivo de trabalho, que podem ser consideradas mais eficazes que as estratégias de defesa individuais, já que se fundamentam na força do coletivo de trabalho (Mendes, 2007; Moraes 2013). Os entrevistados discorrem:

(...) quando acontece essas coisas não é discutido nem conversado, não a nível de trabalho, as vezes só a nível familiar. Não acontece porque é até uma cultura do policial militar, não discutimos essas situações, atendemos a ocorrências e evitamos os pensamentos, é o que me parece (E1);

Tu se abala, claro que tu se abala, mas a instituição nos cobra assim, não é que nos cobra, mas é uma mentalidade assim que a gente tem né, que tu tem que ser durão que tu não pode deixar transparecer (E5).

Assim, percebe-se que, por serem representantes da ordem e da lei, os policiais precisam sustentar uma postura viril, rígida e até mesmo inabalável. Principalmente na cultura gaúcha, essas características machistas intrínsecas ao universo militar, ganham ainda mais destaque (França & Gomes, 2015; Henriques & Lisboa Filho, 2014). Com isso, não é permitido falar nem mesmo expressar medos e desconfortos, não há válvula de escape para as angústias, e isso repercute diretamente na saúde mental do trabalhador. Nesse sentido, no momento em que um dos policiais manifesta seus medos e desconfortos, viola a estratégia coletiva e, em consequência, não é bem visto pelo grupo (Moraes, 2013; Gernet, 2012; Rego, 2013), sendo rechaçado ou deixado de ser bem conceituado pelo coletivo, como constatado na fala do participante E5:

Teve um colega nosso que até apresentou né atestado médico e foi para a psiquiatria e ficou alguns dias afastado, mas não é encarado assim com bons olhos né, porque se têm essa mentalidade que tu tem que ser durão, que tu não pode mostrar, demonstrar o que tu sente (...) Esse colega que apresentou o atestado médico não foi visto com bons olhos assim né, porque ficou alguns dias afastado do serviço, não só por parte da instituição, mas também por parte dos colegas. E até tipo assim, tem aquela visão de “haa... pegou atestado para ficar em casa “sabe “moitiando” como a gente diz, como se aquilo não fosse nada (E5).

A resposta do coletivo à fragilidade e a outros comportamentos fora do padrão acordado que desencadeiam adoecimento está na contramão do ideal militar e da cultura gaúcha regional que enaltecem o machismo e a virilidade. A banalização do sofrimento do outro, a falta de reconhecimento das necessidades e da dor estão presentes no universo militar para enaltecer as habilidades e ignorar os riscos e o sofrimento psíquico advindo da organização do trabalho (Rego, 2013).

De acordo com Dejours (1992), o desenvolvimento de estratégias de defesa pode ser considerado positivo, já que tem como função principal proteger o trabalhador do sofrimento originado pelo trabalho, possibilitando uma relativa estabilidade psíquica, evitando o adoecimento. Entretanto, as mesmas estratégias podem também ser negativas, na medida em que alienam o sujeito, paralisam-no, não permitindo a mobilização subjetiva. Desse modo, verificou-se, a partir das entrevistas realizadas, que os policiais utilizam diversas estratégias defensivas individuais e coletivas para

manter seu equilíbrio psíquico, evitando que tomem consciência de seu próprio sofrimento.

A pesquisa aponta aspectos fundantes da Brigada Militar que continuam vigentes e intactos, depois de mais 170 de anos de existência. Entre eles se destacam a disciplina e a hierarquia que norteiam as relações socioprofissionais. Nesse contexto, a subordinação e o atendimento expresso a ordens são uma das marcas presentes, que, na sua maioria, não são questionadas e nem tão pouco contestadas, causando muitas vezes mal-estar entre as patentes subordinadas. Esta característica revela uma cisão entre quem dá ordens e quem as cumpre, o que pode ser considerado um obstáculo para um trabalho mais cooperativo e um impeditivo para a autonomia do policial. Contudo, observou-se a existência de espaços de fala legitimados pelos próprios policiais, como na troca dos plantões e dentro das viaturas, possibilitando o estreitamento de vínculos e fortalecimento do coletivo. Nas atividades externas que envolvem o trabalho de policiamento na rua, mostraram-se fundamentais a confiança e a cooperação entre os trabalhadores, assim legitimados nos espaços de discussão e relacionamento, ocasionando o fortalecimento dos vínculos e relações pautadas na confiança e autenticidade, sendo um fator de prazer no trabalho (Gernet & Dejours, 2011; Mendes, 1995; Mendes & Araújo, 2012; Mendes & Ferreira, 2008).

Cabe ressaltar que, nas atividades de policiamento ostensivo e no atendimento às ocorrências, ou seja, situações em que o prescrito não contempla o real do trabalho, o policial possui autonomia e pode fazer uso de sua inteligência prática para concretizar suas tarefas. Desse modo, o trabalho externo, na rua, pode ser caracterizado como fonte de prazer e reconhecimento, tanto entre pares, como dos superiores e da própria comunidade (Judge, Robbins, & Sobral, 2010; Mendes & Araújo, 2012). Portanto, o aspecto do processo decisório centralizado restringe o profissional ao cumprimento estrito de ordens quando determinado; no entanto as atividades externas proporcionam uma maior autonomia em sua atuação.

Nas falas dos participantes, é relevante mencionar sobre a estratégia de defesa coletiva utilizada pelos trabalhadores para evitar o adoecimento. O acordo em relação ao silêncio e o recurso simbólico de virilidade relacionam-se a um discurso muitas vezes subliminar vinculado à Brigada Militar como lugar de força e poder somando ao estereótipo machista reforçado pela cultura gaúcha. Por consequência, quem faz parte da Instituição não pode sofrer e nem adoecer para sustentar essa imagem. Quem viola a estratégia coletiva e manifesta descontentamento, desconforto e até adoecimento em relação às situações vivenciadas no trabalho não é bem visto pelo grupo e acaba por ser excluído. Assim, o trabalhador se sente pressionado até o último momento a não mostrar sofrimento, pois não há acolhimento no coletivo do trabalho, onde os pares não aceitam que é possível sofrer e adoecer em função do trabalho, por isso a utilização de estratégias defensivas é fundamental para essa categoria de trabalho (Gernet, 2012; Moraes, 2013).

Em relação às estratégias defensivas, destacam-se a sublimação e a resiliência, que se caracterizam como recurso do ego, como uma proteção ao sujeito em relação ao sofrimento frente às adversidades diárias, e como um modo para resistir e lidar com as contradições do trabalho. Este estudo vai ao encontro das pesquisas já realizadas por Souza e Minayo (2005) e Machado et al. (2015), que salientam que as situações enfrentadas pelo Policial Militar em seu cotidiano de trabalho não se iguala à rotina de trabalho de qualquer outro profissional, por isso se justifica a atenção a ser dada a essa categoria profissional, que, antes de ser policial sinônimo de ordem, socorro e combate, é um trabalhador comum, que sente,

sofre e precisa ressignificar seu trabalho, para que este seja fonte de prazer, saúde e bem estar.

A profissão de policial militar foi descrita pelos participantes como enraizada em sua identidade; eles afirmam que ser policial é estar preparado e disponível 24 horas para servir. Independentemente de estar no horário de folga, momento em que o indivíduo tira a farda e assume outros papéis, ele continua sendo policial militar, constantemente responsabilizado por sustentar tal função. Salientando o quanto essa função exige preparo físico e psicológico dos seus servidores.

Cabe frisar, ainda, que esta pesquisa possibilitou ao policial militar desvendar vivências subjetivas com relação a organização do trabalho, podendo manifestar sentimentos de insatisfação e frustração que geravam sofrimento; Também, identificaram aspectos positivos no trabalho, fatores que são fonte de prazer. Essa ação reflexiva entre sujeito-trabalho é a proposta central da psicodinâmica do trabalho, possibilitando ao trabalhador tomar consciência de sua realidade de trabalho e ir em busca de soluções na intenção de transformar os fatores geradores de sofrimento (Mendes, 2007).

Sobre as limitações deste trabalho, relata-se que uma delas foi a escassa literatura sobre a categoria associada a psicodinâmica do trabalho, o que dificultou a discussão teórica. Além disso, durante a coleta de dados, observou-se resistência dos policiais em participar do estudo, principalmente pelo medo de exposição frente à Instituição. Por se tratar de um estudo de caso, salienta-se que os dados obtidos nos resultados não podem ser generalizados, já que esta pesquisa foi realizada no Rio Grande do Sul, sendo influenciada pela cultura local. Outra realidade pode gerar outros pontos de reflexão, situação que também pode ser considerado um limitador do estudo.

Diante dessa realidade, é importante ressaltar a necessidade de promoverem-se ações preventivas em saúde mental para o trabalhador da Brigada Militar, como, por exemplo, a contratação de profissionais de psicologia, que não atuem somente na seleção de pessoal, mas que possam agir junto aos batalhões de polícia, próximos à realidade desses servidores, tornando o acesso ao acompanhamento psicológico mais facilitado e desmistificado. Almeja-se que este estudo, bem como os resultados alcançados, possa contribuir para uma reflexão sobre o policial militar e seu contexto de trabalho, dando visibilidade a essa categoria profissional a partir da relação sujeito-trabalho, para assim propiciar diálogos em prol da humanização da segurança pública. Salienta-se, por fim, a importância de mais pesquisas em nível nacional serem realizadas, a fim de se conhecer a realidade de trabalho de profissionais lotados em outras regiões do País e sua realidade de trabalho.

Referências

- Bardin, L. (2011). *Análise de conteúdo*. São Paulo, SP: Edições 70.
- Brigada Militar Rio Grande do Sul (2016). *História da Brigada Militar*. Recuperado de https://www.brigadamilitar.rs.gov.br/Institucional/Historia_LT/HistoriaNova
- Constituição do Estado do Rio Grande do Sul (1989). Porto Alegre, Brasil: Assembleia legislativa.
- Dejours, C. (1992). *A loucura do trabalho: Estudos de psicopatologia do trabalho*. São Paulo, Brasil: Cortez-Oberé.
- Dejours, C. (2007). *O fator humano* (5ª ed.). Rio de Janeiro, Brasil: Fundação Getúlio Vargas.
- Ferreira, D. K. S. (2009). *Condições de saúde, de trabalho e modos de vida de policiais militares: estudo de caso na cidade de Recife-PE* (Tese de doutorado, Fundação Oswaldo Cruz, Recife, Brasil). Recuperado de <http://www.cpqam.fiocruz.br/bibpdf/2009ferreira-dks.pdf>
- França, F. G., & Gomes, J. L. F. (2015). "Se não aguentar, corra!": Um estudo sobre a pedagogia do sofrimento em um curso policial militar. *Revista brasileira de*

- segurança pública, 9(2), 142-159. Recuperado de <http://www.revista.forum-seguranca.org.br/index.php/rbsp/article/viewFile/506/213>
- Gernet, I., & Dejours, C. (2011). Avaliação do trabalho e reconhecimento. Em P. F. Bendassolli & L. A. P. Soboll (Orgs.), *Clínicas do trabalho: Novas perspectivas para compreensão do trabalho na atualidade* (pp. 61-70). São Paulo, Brasil: Atlas.
- Gernet, I. (2012). Psicodinâmica do reconhecimento. Em A. M. Mendes, A. R. C. Merlo, C. F. Morrone, & E. P. Facas (Orgs.), *Psicodinâmica e clínica do trabalho: temas, interfaces e casos brasileiros* (pp. 61-76). Curitiba, Brasil: Juruá.
- Ghizoni, L. D. (2013). Cooperação. Em F. O. Vieira, A. M. Mendes, & A. R. C. Merlo (Orgs.), *Dicionário crítico de gestão e psicodinâmica do trabalho* (pp. 99-102). Curitiba, PR/Brasil: Juruá.
- Hartley, T. A., Knox, S. S., Fekedulegn, D., Barbosa-Leiker, C., Violanti, J. M., Andrew, M. E., & Burchfiel, C. M. (2012). Association between depressive symptoms and metabolic syndrome in police officers: Results from two cross-sectional studies. *Journal of Environmental Public Health*, 12(12), 1-9. doi: [10.1155/2012/861219](https://doi.org/10.1155/2012/861219)
- Henriques, M. N., & Lisboa Filho, F. F. (2015). Identidade gaúcha e programa Bahl: entre o tradicional e o contemporâneo. *Verso e Reverso*, 29(72), 155-164. doi: [10.4013/ver.2015.29.72.03](https://doi.org/10.4013/ver.2015.29.72.03)
- Holloway, T. H. (1997). *Polícia no Rio de Janeiro: repressão e resistência numa cidade do século* (19ª ed.). Rio de Janeiro, Brasil: FGV.
- Judge, T. A., Robbins, S. P., & Sobral, F. (2010). *Comportamento Organizacional* (14ª ed.). São Paulo, Brasil: Pearson Prentice.
- Lancman, S., & Sznclman, L. I. (2011). *Christophe Dejours: Da psicopatologia à psicodinâmica do trabalho* (3ª ed.). Rio de Janeiro, Brasil: Fiocruz.
- Lei complementar n.10.990 de 18 de agosto de 1997*. Estatuto dos servidores militares da Brigada Militar do Estado do RS. Porto Alegre, RS: Assessoria de Publicações Técnicas.
- Leirner, P. C. (1997). *Meia volta volver: um estudo antropológico da hierarquia militar*. Rio de Janeiro, Brasil: FGV.
- Lisboa Filho, F. (2009). A gauchidade midiática e televisual: enunciações de sentido no Galpão Crioulo. Em A. Fellipi & V. Nechi (Orgs.), *Mídia e identidade gaúcha*. Santa Cruz do Sul, Brasil: EDUNISC.
- Machado, C. E., Traesel, E. S., & Merlo, A. R. C. (2015). Profissionais da Brigada Militar: vivências do cotidiano e subjetividade. *Psicologia Argumento*, 33(81), 238-257. doi: [10.7213/psicol.argum.33.081.A002](https://doi.org/10.7213/psicol.argum.33.081.A002)
- Martins, S. R., & Mendes, A. M. (2012). Espaço coletivo de discussão: a clínica psicodinâmica do trabalho como ação de resistência. *Revista Psicologia: Organizações e Trabalho*, 12(2), 171-184. Recuperado de http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1984-66572012000200004
- Mendes, A. M., & Araújo, L. K. R. (2012). O sujeito em ação: diálogos entre a psicodinâmica do trabalho e a psicanálise. Em A. M. Mendes & L. K. R. Araújo (pp. 154), *Clínica Psicodinâmica do trabalho: O sujeito em ação*. Curitiba, Brasil: Juruá.
- Mendes, A. M., & Ferreira, M. C. (2008). Contexto de Trabalho. Em M. M. M. Siqueira, *Medidas do comportamento organizacional: Ferramentas de diagnóstico e de gestão* (pp. 113-126). Porto Alegre, Brasil: Artmed.
- Mendes, A. M. (1995). Aspectos psicodinâmica da relação homem-trabalho: as contribuições de C. Dejours. *Psicologia: Ciência e Profissão*, 15(1-3), 34-38. doi: [10.1590/S1414-98931995000100009](https://doi.org/10.1590/S1414-98931995000100009)
- Mendes, A. M. (2007). Da Psicodinâmica à Psicopatologia do trabalho. Em A. M. Mendes (Org.), *Psicodinâmica do trabalho: teoria, método e pesquisas* (pp. 29-48). São Paulo, Brasil: Casa do Psicólogo.
- Merlo, A. R. C., & Mendes, A. M. B. (2009). Perspectivas do uso da psicodinâmica do trabalho no Brasil: Teoria, pesquisa e ação. *Cadernos de Psicologia Social do Trabalho*, 12(2), 141-156. doi: [10.11606/issn.1981-0490.v12i2p141-156](https://doi.org/10.11606/issn.1981-0490.v12i2p141-156)
- Merlo, A. R. C. (2002). Psicodinâmica do trabalho. Em M. G. Jacques & W. Codo (Eds.), *Saúde mental e trabalho: Leituras* (pp. 42-130). Petrópolis, Brasil: Vozes.
- Mesquita Neto, P. (1999). Violência policial no Brasil: abordagens teóricas e práticas de controle. Em D. C. Pandoler et al. (Orgs.), *Cidadania, justiça e violência*. Rio de Janeiro, Brasil: Faculdade Gama Filho.
- Minayo, M. C. S.; Souza, E. R., & Constantino, P. (2008). *Missão prevenir e proteger: condições de vida, trabalho e saúde dos policiais militares do Rio de Janeiro*. Rio de Janeiro, Brasil: FIOCRUZ. Recuperado de <https://static.scielo.org/scielobooks/y28rt/pdf/minayo-9788575413395.pdf>
- Moraes, R. D. (2013). Estratégias Defensivas. Em F. O. Vieira, A. M. Mendes & A. R. C. Merlo (Orgs.), *Dicionário crítico de gestão e psicodinâmica do trabalho* (pp. 153-158). Curitiba, Brasil: Juruá.
- Oliveira, K. L. & Santos, L. M. (2010). Percepção da saúde mental em policiais militares da força tática e de rua. *Sociologias*, 12(25), 224-250. doi: [10.1590/S1517-45222010000300009](https://doi.org/10.1590/S1517-45222010000300009)
- Rego, V. B. (2013). Virilidade. Em F. O. Vieira, A. M. Mendes & A. R. C. Merlo (Orgs.), *Dicionário crítico de gestão e psicodinâmica do trabalho* (pp. 99-102). Curitiba, PR/Brasil: Juruá.
- Resolução 466 de 12 de dezembro de 2012*. Brasília, DF: Ministério da Saúde.
- Resolução 510 de 07 de abril de 2016*. Brasília, DF: Ministério da Saúde.
- Ribeiro, L. C. (2011). História das polícias militares no Brasil e da Brigada Militar no Rio Grande do Sul. Em *Anais XXVI Simpósio Nacional de História*. Simpósio conduzido em ANPUH, São Paulo, Brasil. Recuperado de http://www.snh2011.anpuh.org/resources/anais/14/1313022007_ARQUIVO_textoANPUH.pdf
- Silva, L. A. M., & Leite, M. P. (2007). Violência, Crime e Polícia: O que os favelados dizem quando falam desses temas? *Sociedade e Estado*, 22(3), 545-591. Recuperado de <http://www.scielo.br/pdf/se/v22n3/04.pdf>
- Silva, M. B., & Vieira, S. (2008). O processo de trabalho do militar Estadual e Saúde Mental. *Saúde Soc. São Paulo*, 17(4), 161-170. doi: [1590/S0104-12902008000400016](https://doi.org/10.1590/S0104-12902008000400016)
- Souza, E. R., & Minayo, M. C. S. (2005). Policial, risco como profissão: morbimortalidade vinculada ao trabalho. *Ciência & Saúde Coletiva*, 4(10), 917-928. doi: [10.1590/s1413-81232005000400015](https://doi.org/10.1590/s1413-81232005000400015)
- Souza, E. R., Franco, L. G., Meireles, C. C., Ferreira, V. T., & Santos, N. C. (2007). Sofrimento psíquico entre policiais civis: uma análise sob a ótica de gênero. *Cad Saúde Pública*, 23(1), 105-114. doi: [10.1590/S0102-311X2007000100012](https://doi.org/10.1590/S0102-311X2007000100012)
- Souza, E. R., Minayo, M. C. S., Silva, J. G., & Pires, T. O. (2012). Fatores associados ao sofrimento psíquico de policiais militares da cidade do Rio de Janeiro, Brasil. *Cad. Saúde Pública*, 28(7), 1297-1311. doi: [10.1590/S0102-311X2012000700008](https://doi.org/10.1590/S0102-311X2012000700008)
- Spode, C. B., & Merlo, A. R. C. (2006). Trabalho policial e saúde mental: uma pesquisa junto aos Capitães da Polícia Militar. *Psicologia: Reflexão e Crítica*, 3(19), 362-370. doi: [10.1590/s0102-79722006000300004](https://doi.org/10.1590/s0102-79722006000300004)
- Stuart, H. (2008). Suicidality among police. *Current Opinion in Psychiatry*, 21(5), 505-509. doi: [10.1097/YCO.0b013e328305e4c1](https://doi.org/10.1097/YCO.0b013e328305e4c1)
- Vasconcelos, A. C. L. (2013). Inteligência prática. Em F. O. Vieira, A. M. Mendes, & A. R. C. Merlo (Orgs.), *Dicionário crítico de gestão e psicodinâmica do trabalho* (pp. 237-242). Curitiba, Brasil: Juruá.
- World Health Organization (2010). *Health impact of psychosocial hazards at work: An overview*. Geneva: WHO. Recuperado de https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44428/9789241500272_eng.pdf;jsessionid=2285650EF817FDD80D124DDA12659284?sequence=1
- Yin, R. K. (2015). *Estudo de caso: Planejamento e métodos* (5ª ed.). Porto Alegre, Brasil: Bookman.

Informações sobre o artigo

Recebido em: 15/12/2016

Primeira decisão editorial em: 15/04/2017

Versão final em: 14/04/2019

Aceito em: 20/04/2019